

의료사회복지실천의 이해 1 / 1주차 1차시

1. 보건·의료에서 사회복지 개입배경

1) 의료사회복지란?

- 병원이나 의료기관 등에서 질병의 의학적 치료와 함께 환자 및 가족의 심리적·경제적인 문제를 해결하거나 원조해 줌으로써 환자의 건강회복이나 재활을 돕는 노력

2) 의료사회복지의 목적

- 환자로 하여금 질병치료와 치료적 재활을 도와 사회에 보다 잘 복귀 할 수 있도록 하는데 있으므로 언제나 환자를 단순히 불안정한 능력자로 취급하지 말고 더 적극적으로 환자를 전체적인 인품으로 이해하고 대우해야 함

3) 의료사회복지의 진정한 목적

- 입원 및 외래환자에 대한 사회적·경제적·정서적인 면을 조사, 진단하여 의료적 치료수행에 도움을 줄 수 있도록 하며, 치료가 종료된 후에 정상적인 가정 및 사회로의 복귀가 가능하도록 돕는 제반 활동

4) 의료사회복지의 기능

- 의료사회복지의 목표를 달성하기 위하여 의료기관 즉 병원, 진료소, 보건기관 및 시설, 그리고 사회복지기관과 재활원 등에서 사회복지의 과정을 통하여 다양한 기능을 수행함

5) 보건의료기관에서 사회복지의 개입

- 빈곤한 환자의 경제적 원조
- 질병과 사회환경과의 연관성을 인식시켜 생활환경 개선을 도움
- 환자의 생리·심리·사회적 면의 불가분성을 이해시켜서 다 학문적 접근으로 진료팀을 활성화 시키는 것에 있음

6) 오늘날 의료의 현실

- “3분 진료” 일본에서 사용된 말로 3시간 기다려 3분 진료한다는 말인데 우리나라에도 종합병원의 외래진료실의 진료 환경을 묘사한 것
- 의료보장제도의 확대로 의료수요 증가
- 제한된 의료 인력과 시설로 인하여 전인적인 인간으로서의 환자가 대우받기 어려움
- 의학이 세분화되어 환자의 국부적 처치에 국한됨
- 자연과학이 발달됨에 따라 의료기계의 숲 속에서 진료나 과정이 기계적인 진료로 끝나는 경향이 있음

7) 인간의 신체 질병의 발생

- 인간은 신체적·정신적·사회적·다원적 기제로 형성된 기제이기 때문에 환자가 가지는 질병도 신체적 결핍 이외에 정서적 요소가 잠재해 있는 것
- 질병의 발생은 단순한 신체적 조직 결핍 이외에 정서적인 결핍으로 야기되는 심인적 요인 등에 복합해서 일어나는 것

- 환자가 가지고 있는 심리·사회적인 관계에서 파생되는 욕구를 파악해 내고 사회환경적인 것에 있음을 탐색해야 할 것

8) 환자의 신체적 증상

- 환자의 심리·사회적 기능에까지 영향을 주게 되며 역으로 신체적 증상을 환자의 심리적·사회적 요인에 의해서 발생되기도 함
- 환자의 발병을 관찰할 때 생물학적 균형의 파괴뿐만 아니라 질병에 영향을 주는 개인적·정서적·사회적 요소에도 관심을 가져야 함
- 질병을 가지고 있는 환자를 효과적으로 치료하기 위해서는 신체조직적인 문제해결과 아울러 정서적, 사회적 문제들의 치료 방법도 요청되고 있음
- 로빈슨(Dr. Robinson)
 - 인간을 마음과 육체의 단위로 질병 치료를 위한 의학에서는 이점을 특히 유의해야 한다고 함
- 마고리스(Dr. Margolis)
 - 현대의학의 놀랄만한 발전은 오히려 인간의 마음과 육체의 상호관련성을 모호하게 한다고 개탄함

9) 진료의 한계

- 의사들은 장시간 동안 환자나 그의 가족들이 참여하는 사회관계 등을 자세하게 들어서 사회적 정서적 상황을 사정하거나 자료를 수집하는데 많은 시간을 가지기가 매우 어려움
- 치료 과정에서 파생되는 심리적·사회적·경제적 문제가 질병치료에 저해 요인으로 작용하는 역기능 현상을 사정하고 이를 조정 또는 해결할 수 있는 전문적인 영역의 한계가 있음

10) 질병치료에 있어서 의료사회복지사

- 의학의 기초가 되는 생물학, 물리학, 생화학만으로는 질병의 복잡성을 설명할 수 없음
- 환자에 대한 환자의 생활전반의 정신적 정서적 사회경제적 상황을 전문적으로 조사, 사정
- 의료팀에게 정보를 제공하고, 이해시키며 토의·다학문적 측면에서 정확한 진단과 치료계획을 세우고 치료를 수행할 수 있는
- 전문적인 기술 활동을 해야 함

11) 의료기관에서 의료사회복지사의 기능

- 환자와 그 가족의 신체적·정신적·사회경제적 상황을 전문적으로 조사 사정
- 의료팀에게 보고, 이해시키며 토의함
- 다학문적 측면에서 정확한 진단과 치료 계획을 세우고 치료를 수행 할 수 있는 전문적인 기술 활동을 해야 함

12) 종합

- 의료사회복지
 - 병원에서 제공하는 의료적 치료를 조정, 보강
 - 질병의 원인이 될 수도 있고, 또 질병 치료과정에 장애가 될 수도 있는 사회경제적, 정서적인 인간의 내·외적인 문제를 해결하도록 도움

- 퇴원 후 환자가 그의 가정이나 사회에 복귀하여 가장 적절하게 사회적 기능을 발휘할 수 있도록 도와주는 것
- 이는 사회복지적인 지식과 기술로 의료에 접근하는 사회복지의 한 영역임

2. 의료사회복지의 의의

- 인간에게 질병은 단순히 신체적 조직의 결함에서 뿐만 아니라 정서적 요인 가운데서도 심리적 요인과 사회경제적 요인 등이 크게 작용 할 수도 있음
- 인간은 신체적, 정신적 2대기제(Mechanism)로 구성되어 있음
- 심신의 양기제 설명 사례
 - 예) 혼자 본인이 병을 앓고 있다는 사실을 이미 아는 경우나 본인은 알지 못하나 의사의 진찰로 병이 있음을 알게 되면 심리적·사회적 반응이 일어나 그것이 질병 치료에 장애가 될 수 있게 됨
 - 예) 심리·사회적 요인이 질병에 근원적인 요소로 작용하여 신체가 대신 아파지는 질환(정신신체증)이 오늘날의 중대한 의료문제가 되고 있는 점

1) 건강의 정의

■ 세계보건기구(WHO)

- 건강이란 완전한 육체적·정신적·사회적 그리고 영적 복지의 상태를 말하는 것임
 - 질환의 원인에 있어서 육체적 원인뿐만 아니라 정신적·사회적 원인도 포함되기 때문에 신체적 질환에 따른 사회적·정신적 문제들에 대한 치료가 요청됨
 - 의료의 활동이 치료적인 면에서 보건 활동 면으로 확대되어 가고 있음
 - 의료의 범위 : 단순히 예방정책이나 건강증진대책, 질병의 조기발견, 조기치료에 대한 치료활동의 확대만을 의미하는 것이 아니라 진정한 의료는 심신의 기능 회복과 함께 사회복귀를 위한 원조 활동까지 포함하고 건강의 사회적 기능의 중요성뿐 아니라 의료의 사회적 대책의 의미까지 포함되어야 함

2) 질병의 요인

■ 신체적 조직의 결함

■ 정서적 요인(심리적 요인, 사회경제적 요인)

3) 의료사회복지는?

■ 사회적 요인, 질병의 관계에서

■ 질병을 하나의 사회문제로 보고

■ 질병, 사회, 보건과 상호관계성을 가지고 있다고 봄

4) 신체적인 질병의 영향

- 광범위한 사회적·정서적 구성 요소를 지닌 현실문제이며 이것은 가족들의
- 마음의 평영을 잃게 함
- 감정적 긴장이 환자와 가족에게 일어나며 최악의 경우 환자에게 소외, 무기력, 불안, 의존심, 공포 등을 가져다 줌
- 사회적·정서적 스트레스가 질병의 최초 형성단계 에서부터 최후의 만성적인 데까지 그의 전 과정을 통하여 병의 결과뿐 아니라 병의 형성요인으로 관련됨

5) 의료분야에서 사회복지사

- 환자의 보건의료에 심리·사회적인 접근을 시도해야 하는 특별직업
- 치료팀 구성
 - 의사, 간호사, 물리치료사, 작업치료사, 심리학자, 영양사, 언어치료사, 사회복지사
- 서비스
 - 환자 및 가족
 - 개별사회사업, 집단치료, 가족치료, 환경요법, 프로그램과 정책계획 및 개방, 진찰, 조사, 교육, 행정, 지도력 부여 등

의료사회복지실천의 이해 2 / 1주차 2차시

1. 의료사회복지의 개념

1) 개념

- 인간이 질병으로부터 자신을 보호하는 법
 - 질병에 걸리기 전에 여러 병인(病因)을 제거하여 예방
 - 질병에 걸리면 그 질병을 조기에 발견, 조기치료
 - 치료된 환자에게 사회적 기능을 회복시켜 사회에 복귀할 수 있게 재활 및 잠재능력을 개발하는 방법
- 의료복지의 개념
 - 개인의 건강유지 및 질병치료 그리고 사회복귀에 가용 될 모든 수단이나 기회가 누구에게 공평하게 주어져야 함
 - 이러한 모든 수단에 있어서 기회에 참여하는 데에는 개인이나 집단 등에 따라서 공평하지 못하고 설사 기회가 주어져도 참여 하는 과정에 있어서도 여러 가지 문제가 없지 않음
 - 의료나 보건에 있어서 모든 문제를 사회복지적인 면에서 해결하거나 완화시켜 나아가 건강증진에 참여하고자 하는 노력
- 의료사회복지란?
 - 의료기관에서 실시되는 사회복지를 병원사회복지라고 하였는데, 질병의 사회성과 의료의 사회화로 인하여 의료에서의 건강 개념이 치료에서 건강유지와 예방 활동에 초점을 두고 보건으로 관심이 변화됨에 따라 의료사회복지 개념 또한 확대되고 활동도 다양화되지 않으면 안 되게 됨
 - 의료분야에서 전문직으로 의료사회복지의 시작은 의료에 있어서 기능적인 문제를 돕기 위하여 개입(기술적 개념), 의료의 개념적 변화
 - 의료의 기본권적(권리화)개념으로 의료복지정책 내지 제도적 문제에 초점을 두어 개입하지 않을 수 없는 상황에 이룸(정책적 개념)

2) 기술적 개념

- 의료사회복지의 정의
 - 프리드렌더(Friedlander)
"의료사회복지란 사회복지 전문화된 한 분야로서 환자가 가능한 한 보건서비스를 가장 효과적으로 활용할 수 있도록 하기 위해 병원, 진료소 혹은 기타의 의료기관에서 실시되는 개별사회복지 때로는 집단사회복지의 실천을 포함하고 있다. 이는 환자의 질병과 치료에 영향을 주는 사회적 정서적 문제를 다루는 데 있어서의 원조에 강조점을 두는 것을 그 특색으로 하고 있다."

- 김덕준 교수

“의료사회복지는 의료팀(Medical Team)의 일원으로 사회복지사업의 전문적인 입장에서 의료·보건의 장에서 환자 혹은 그 가족이 당면한 정신적, 사회적, 경제적 문제와 욕구상태를 해결, 완화, 충족하여 의료의 달성을 원조하는 과정이다.”

- 일본 후생성(厚生省)발행 「보건소에서의 의료사회복지지침」

“의료사회복지란 의료 및 보건기관 등의 의료팀의 일부분으로서 사회과학의 입장에서 의사의 진단을 도와주며 한편으로는 환자 질병의 치료와 예방, 갱생의 장애요소인 환자 자신의 문제나 그 가족의 경제적, 정신적 혹은 사회적 제 문제를 만족하게 해결해 나갈 수 있도록 개인과 그 가족을 원조하는 과정이다.”

■ 의료사회복지의 의미

- 진료의 과정에서 환자 및 그 가족이 가지고 있는 사회적, 경제적, 심리적 문제를 실천기술론 등의 전문적인 원조를 활용해서 의료를 효과적이며 능률적으로 전개할 수 있게 도움을 주는 일련의 전문적 행동체계를 의미함

■ 의료사회복지의 기술적 개념

- 사회복지의 전문적 접근은 사회복지를 인간관계의 조정기술로 보는 견해
- 기술적(전문적)관점에서의 의료사회사업이란 의료기관에서 치료 팀의 일원으로서 사회사업의 전문적인 방법을 활용하여 환자의 질병치료와 회복 및 사회복귀기능을 돕는 목적을 가지고 질병으로 인하여 파생되는 환자의 심리적, 사회적 및 경제적 문제가 질병치료에나 그 회복에 악영향을 주지 않도록 문제를 해결해주거나 조정하여 환자 및 그 가족을 돕는 전문적인 활동이라 할 수 있음
 - 의료사회복지사는 의사를 중심으로 하는 임상 의료팀의 일원으로서 위치를 가지고 예방, 진단, 치료, 사후지도, 사회복귀 등 광의의 의료에 참여
 - 의료의 효과를 저해하는 환자 및 그 가족의 물질적·심리적·사회적 장애나 여러 장애를 해결, 완화하도록 원조하는 전문가

■ 최근의 의료사회복지의 관심사

- 의료기관에서 치료를 받고 있는 환자의 문제나 사회적 욕구와 관계없이 그 목적을 보다 잘 달성하기 위해 점차 환자의 가족이나 지역사회주민들이 사회적 욕구나 보건의료의 욕구의 호응해야 함
 - 의료사회복지사는 의료기관 내부의 업무에 머무르지 않고, 지역사회의 개인이나 집단을 원조하는데 노력해야 함
 - 개별사회복지, 집단사회복지 및 지역사회조직의 기본적인 사회복지의 전문적 과정의 전부를 그 활동에 포함시켜야 함

■ 의료사회복지사의 활동 영역

- 가족집단의 맥락 속에서 개개인의 환자에 대한 직접적인 개별사회복지서비스, 환자 및 그 가족집단에 대한 집단사회복지, 다른 의료팀의 구성원에 자문을 구하며 지역의 보건의료관계자와 상담을 하고, 사회복지학과 학생, 의과대학생,
- 간호학과 학생 등에서 교육하고, 조사연구, 지역사회보건계획 입안에 참여하는 것이 그들의 활동영역
- 의료사회복지사가 사회과학의 입장에서 의사의 진료를 돕는 필요성에서 기인한 것
- 환자의 질병 내지 장애에 대해서 올바른 진단을 하기 위해서는 의학적인 진단만으로는 되지 않아 사회·심리적 특히 정서적인 제 상황을 고려하지 않으면 안 된다는 인식
- 인간의 건강이나 병에는 생물학적·심리적·사회적 요인이 복합적으로 서로 상호작용하면서 영향을 주고 있기 때문임
- 병이나 장애의 진단에 적절한 여러 가지 요소를 기반으로 한 종합적인 진단이 요청되는 단계를 전제조건으로 하고 있음

3) 정책적 개념

■ 1905년 캐버트(Richard C. Cabot) 박사

- 매사추세츠(Massachusetts) 종합병원에서 의료팀의 일원으로서 질병의 진단과 치료를 효과적으로 할 수 있도록 지원하던 임상사회복지는 그 초기의 개념
 - 그 후 임상사회복지는 발전하여 그 활동영역이 넓어져서 지역사회보건과 정책적인 분야까지 포함되어 공중보건사업이나 공적부조사업에도 참여
 - 의료가 상병 또는 질병 발생시에 필요한 치료적인 면에서부터 질병이 발생하기 이전의 건강을 유지·증진시키는 예방적인 면 즉, 보건의 개념으로 확대되었음
 - 의료의 개념이 질병치료뿐만 아니라 사회의 안녕과 질서유지를 포함한 건강증진으로 변화됨에 따라 소극적이던 의료기관이 보다 적극적으로 지역사회나 보건사업에 참여하게 되었음
 - 의료사회복지는 의료기관 안에서 협의진단, 자문하는 일과 준 전문가의 훈련 그리고 정책개발 등의 역할을 담당하게 되었으며, 지역사회 진료소와 특수진료소가 생기면서 의료사회복지의 활동이 지역의 장으로 확대되어 그 사회에서 의료복지의 일익을 담당하게 되었음
 - 의료사회복지를 전체 의료조직 내에 포함시켜 사회보험, 공공부조 및 사회적 서비스의 정책기술로서 행하는 각종 제도와 공중보건위생과 의료제도가 규정하고 있는 사회복지적인 시설을 의미함
 - 의료의 변천, 의료의 사회화, 건강의 사회적 기능이 중요시되면서 국가가 의료를 책임지는 형태로서 영국에서는 1948년 국민조건서비스제도가 시작되고, 미국은 1965년 의료보호와 의료부조령이 통과됨

- 우리나라에서는 의료보장제도가 국민의 생존권을 보장한다는 사회복지정책의 근본이념에 기초되어 사회계층간의 소득재분배와 건전한 국민활동력의 보전과 향상 그리고 사회의 균형적 발전과 성장에 이바지하기 위하여 1977년 의료보험과 의료보호제도가 실시·확대되어 가고 있음

■ 의료사회복지의 정책적 개념

- 사회복지의 정책적 개념은 질병의 예방과 건강증진 및 향상을 지향하는 의료복지를 목적으로 보건 및 의료영역에서의 사회복지조사, 사회복지정책 및 행정의 등의 방법을 통하여 보건의료의 욕구측정과 의료서비스의 전달 체계를 평가하여 그 개선과 그 활용을 용이하게 하고 의료보호와 의료부조의 확대와 질적 향상을 기여하는데 참여하는 사회복지의 한 과정
 - 질병이 경제적 빈곤이나 저소득에서 기인된다는 사회과학적인 입장에서 보려는 데서 비롯됨
 - 경제적 어려움이나 생활상의 어려움은 필연적으로 인간의 영양부족과 휴양의 결여, 또는 생활환경의 악화를 가져옴
 - 위와 같은 위기상황은 인간의 이환가능성을 증대시키고 한번 이환된 질병은 만성화가 되기 쉬우며 그 결과 기동력의 상실과 소득의 중단, 막대한 의료비용은 더욱더 빈곤하게 만들고 위약한 환경은 회복의 기회는 멀어지고 심신은 더욱 황폐해 짐

■ 질병 - 빈곤의 악순환의 반복의 원인

- 사회체제나 제도의 기본적인 모순이나 결함에 기인되는 것이고 질병은 단순히 인간의 신체적 부위의 부상이나 장애에 그치는 것이 아니라 역사적, 사회적 상황 속에서 야기되는 사회문제라 할 수 있으며 점차로 그 중요성이 증가되어 의료의 사회적 정책을 규정하게 되었음

■ 대책

- 개인의 가족, 세대의 소득과 자산 상태에 따른 의료보장이 실시되고 있으나 그나마도 실제 현행 의료사회적 보호는 많은 문제를 갖고 있어서 의료기회의 보장이나 막대한 자기부담으로 어려움이 없지 않음
- 현재 사회에서의 사회문제로서의 질병과 의료문제는 기본적으로 사회과학적인 규명이 필요함
- 이 문제를 해결하기 위하여 기본적인 부분인 정책적 보호의 정비와 확충에 관심과 노력이 있어야 함
- 이런 의미에서 의료회복지사는 의료의 사회적 보호로서, 의료보험이나 의료급여의 충실과 그 정비에 개입하게 됨

4) 통합적 접근

■ 중간적 의미의 사회복지.

- 사회복지의 정책적 접근방법은 국민을 대상으로 하고, 전문적 접근방법은 개인을 강조하며, 통합적 접근방법은 사회(개인과 집단)를 중요시함

■ 통합적 관점에서의 의료사회사업이란 질병에 대한 다각적인 접근방법을 바탕으로, 질병을 가진 개인과 환경과의 상호작용관계에 초점을 두고 의료팀의 일원으로서 환자 및 가족의 사회기능 향상을 위해 전문적 실천방법을 활용하여 질병의 예방, 치료 및 재활에 이르기까지 다양한 활동을 수행하는 사회사업의 한 전문분야라고 정의

관점	정책적 정의	기술적 정의	통합적 정의
대상	보건의료체제 전반	환자 및 가족의 심리사회, 경제적 문제	질병을 가진 개인과 환경(환자, 가족은 물론 의료, 보건계 종사자 등)
방법	사회복지조사, 사회복지정책 등 광범위한 방법	사회사업의 전문적 방법	사회사업의 전문적 방법과 사회복지조사, 사회복지정책 등 다각적인 접근방법
목적 (효과)	질병의 예방, 건강증진 및 향상을 지향하는 의료복지	환자의 질병치료와 회복, 사회복지기능 지원	환자 및 가족의 사회기능향상, 질병의 예방, 치료 및 재활 등 다양한 목적

의료사회복지와 사회환경적 특성 1 / 2주차 1차시

1. 의료와 특성과 사회화

1) 의료와 의료제도

■ 일반적으로 의료란?

- 자연과학을 토대로 한 건강 유지와 질병치료를 위한 학문적 체계인 의료의 실천을 말함

■ 미키에이(三木榮)는 의학이란?

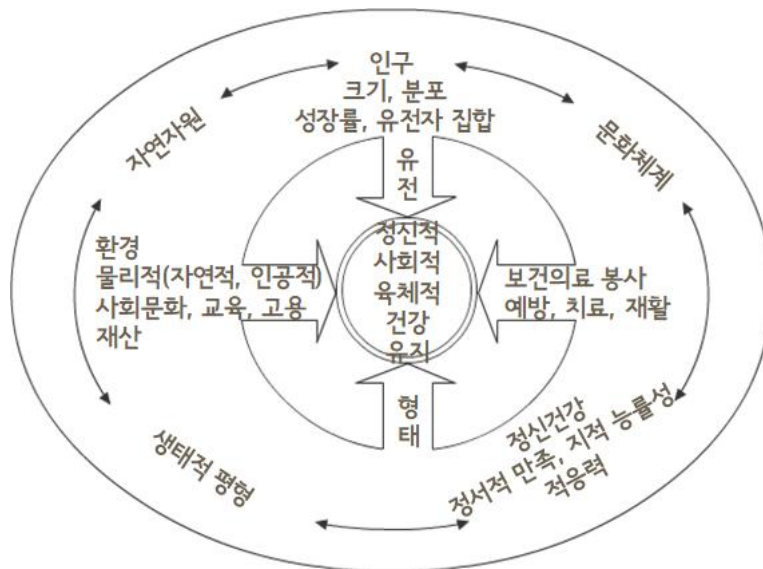
- 자연과학에 의하여 개인과 사회 그리고 인류의 생명과 질병의 원인을 탐구
- 진단, 치료, 위생, 예방의 방법을 추구함
- 실제적 경험과 수련에 의하여 그 기술을 습득함
- 심신의 질병을 제거하고, 건강을 증진시켜 복지향상을 도모함
- 그 실행에 의도로서 완벽을 기하는 특수과학이라고 요약
- 의료 : 사고나 질병을 전제로 하여 의료인에게 진료를 받는 의료서비스
- 협의의 의료
 - 질병의 진단과 치료 즉, 진료를 의미 함
 - 병원이나 기타 의료시설을 갖춘 의료기관에서 의사를 비롯한 의료요원들의 의료서비스를 국민에게 제공하는 행위 및 이를 위한 조직적인 진료체계의 마련이라 할 수 있음
 - 의료서비스 : 의료 인력, 의료시설 및 장비 그리고 중간재 등에 의해서 질병의 진단과 치료는 물론 조기진단과 조기치료, 예방, 재활까지 포함
 - 의료의 성질 : 자연과학 = 사회과학의 영역, 이론과학 = 실천과학
 - 현대적 의미의 의료
 - 의료기관에서 행해지는 서비스 즉, 조기진단과 조기치료뿐만 아니라 예방과 재활은 물론, 정기적인 건강진단이나 집단진단검사 등 건강의 유지, 증진을 위한 모든 영역
- 광의의 의료(Health Care)
 - 보건서비스(Health Service)에 의한 산물이며 육체적 정신적 및 사회적 안녕(Well-being)을 회복, 유지 증진할 목적으로 하는 개인 또는 공공의 모든 활동이 포함됨
- 의료제도
 - 의료, 즉 진료, 재활, 예방을 포함한 총괄적인 보건서비스를 의료인과 의료기관의 편의가 아니라 국민이 필요한 서비스를 그 접근성이 용이하고 효과적인 서비스가 되도록 제도적 접근이 확립되어야 하고, 국가는 의료문제를 해결할 수 있는 사회적 접근수단을 제도화하여야 하는데 이를 의료제도라 함

2) 의료의 특성

- 우리나라에서는 경제성장과 사회발전으로 국민의 의식이 향상되어 의, 식, 주 다음으로 보건의료가 인간의 기본욕구라는 개념이 보편화
- 보건 의료의 특성은 다음과 같음

■ 의료이용의 특성

- 의료소비자는 개인의 취향이나 만족을 위하여 상품과 서비스에 대한 충분한 정보를 가지고 합리적인 결정을 내릴 수 있어야 함
- 국민들은 즉시 의료서비스를 받지 못하면 좋지 않은 결과가 생겨 의료서비스에 즐거움을 가지지 못한 다음과 같은 이유 때문
 - 필요한 의료수요, 의료인의 선택, 의료서비스 질적 수준을 잘 알 수 없음
 - 지식/ 정보가 낮은 사회계층은 불리한 위치에 있음
 - 의료서비스를 받는 동안 불안, 공포, 고통, 부자유스런 생활, 어려움을 무릅쓰고 서비스를 받겠다는 결심이 요구



[그림 1] 의료의 복합체
[자료] 문옥륜, 1977

■ 선택과 통제의 어려움

- 자유 시장 경제에서는 소비자가 스스로 경제형편에 따라 무엇을 사겠는지, 얼마짜리를 어디서 언제 살 것인지를 결정하는 최고결정자
- 질병은 자기도 모르게 언제 생길지 병의 예측이 불가능
- 치료는 연기하게 되면 불리, 분할하여 살수 없음
- 모든 것이 의사가 판단하고 결정하며 환자는 의사, 의료기관을 선택할 뿐 의사에게 맡김

■ 의료서비스의 제약

- 수요의 제약
 - 수요자의 의료수요에 부응하는 사회적 요구를 즉각 충족하기에는 많은 제약
- 의료인 양성기간의 제약
 - 고도의 과학적인 지식, 숙련된 임상기술이 → 양성기간의 장기화
- 공급의 제약
 - 의료수요가 적은 지역까지 공급은 국가적 계획과 조직이 요구

■ 외부효과의 공공이익

- 시장경제
 - 어떤 서비스와 재화의 이용에 따른 이해득실이 개개인에게 국한될 때 더욱 활발
 - ① 의료는 이해득실이 개인에게 그치지 않고 많은 사람들에게 파급됨
 - ② 개개인의 건강회복과 보전은 국력의 자원이고 국가 생산력 보전이 됨
 - 예) 전염병의 경우는 대중보호를 위한 국가의 관여가 요구

■ 공공재화로서의 보건서비스

- 공공재 또는 사회재는 사유재와 달리 비경쟁적, 비현실적인 특성을 가지고 있음
 - 공공재는 개개인이 이를 위하여 투자하려 들지 않고 국가나 사회가 투자할 때까지 기다리는 경향이 있음

■ 의료의 사회경제적 특성

- 의료는 공급독점
 - 의사만 의료를 행할 수 있는 제약이 있음
- 의료는 대량생산이 되지 않음
 - 의료는 개별성을 가지며 주문생산
- 의료는 비축이 되지 않음
 - 주문생산(기성품이 아님)
 - 완성품의 생산 수단(부분적 재료에 불과)
- 의료는 가격인하가 되지 않음
 - 개별적 주문생산 - 합리화가 어려움
- 의료의 유통기구에는 한계가 있음
 - 시장의 확대가 불가능 → 주문생산이고 비축이 되지 않기 때문

■ 의료에는 대체성이 없고 긴급성이 있음

- 대체 불가능
 - ① 의사의 전문성에 의존
 - ② 이차적 대체성은 고려될 수도 없다 → 의료유사행위

3) 의료의 사회화

- 국민에게 필요한 의료를 국가적으로 사회적으로 제공토록 강구하는 것.
- 의료는 일반상품과 달라서 대체가 불가능하다. 의료는 근대의학에 근거하는 의사의 전문성에 의존하므로 대체성은 없다. 그러나 이른바 자가요법, 민간요법, 마약치료내지 의료유사행위에 의존하는 경우에는 이차적 대체성은 고려될 수도 없음

■ 의료의 전달체계 확립문제

- 수요측면
 - 개인의 경제력에 따라 수요자와 수요계층이 한정
- 공급측면
 - 의사의 도시집중현상

■ 의료의 질적 변화문제

- 환자와 의사의 관계가 비인간화(Depersonalization)되고 있음
 - 문제 : 전인치료의 제약-가족관계, 생활 및 정서적인 면 못 봄
 - 해결방안 : 신체를 자연과학적면에서 관심, 환자의 정서적 감정과 정신상태, 전인적-포괄적 진료
- 자본주의사회
 - 의료의 본질에 수정의 필요적 사고가 높아짐
 - 의료의 사회화 문제가 제기됨
- 의료수가
 - 관에 의하여 결정 관리, 고가 약의 처방제한 등 진료 내용까지 제약이 가해지는 통제시장화
- 종전의 의사와 환자와의 관계
 - 다원적인 개입 → 정부보험자, 수가 심사기관이 관여하고 있음
- 국민의 의료서비스 욕구
 - 의·식·주 다음가는 생존의 기본수요로 인식
 - 의료서비스의 만인균등의 원리가 법제화
 - 폭이 넓어져 의료의 기본권적 권리화 됨
- 의료제도
 - 인간의 생활에 수반되는 생체의 생리적 과정에 대한 모든 장애와 기능부전을 의료문제로 보고 이를 해소하기 위한 국가적, 사회적 노력을 해야 함
 - 국민의료는 크게 세 가지 기본 요소로 구분
 - ☞ 인적 수요 → 의료를 필요로 하는 "국민"과 서비스를 제공하는 "의료인"으로 구성
 - ☞ 물적 요소 → 의료시설과 장비, 재정
 - ☞ 사회의 조직적 마련 → 인적, 물적 요소가 원활하게 움직일 수 있도록 함
 - 정부와 기업주 입장 : 보험 경제문제
 - 보험자와 피보험자 입장 : 의료문제

- 의료관계자 입장 : 의료제도문제
- 환자의 입장 : 의료기술, 의학 중요문제
- 각각 보는 관점이 달라지게 됨
- 자유방임 의료체계
 - 시장경제이론에 입각한 수요공급의 법칙이 의료의 수급을 결정짓도록 하는 것
- 국가계획의료체제
 - 국민의 건강보호와 증진에 관한 일체의 책임을 국가가 지고 직접 관리
- 보건건강 서비스
 - 의, 식, 주 다음 가는 제4의 생활필수품(Fourth Human Necessity)
이유) 국민건강 - "국력 부강의 근원", 국민 각자 - "생활발전의 원동력"
- 건강·의료서비스
 - 사회의 질서유지와 안녕
 - 공공복리의 증진을 위해 필수적인 요인이 건강의 사회화
 - 의료의 공공화
 - 의료비부담의 사회화
 - 의료업무의 사회조직화
 - 의료시설의 민주화의 필요성이 강조되고 의료복지의 요망이 더욱 가중

1. 질병의 사회화

1) 질병의 개념과 그 사회성

■ 건강이란?

- 생물학적 건강

- "생명의 기능이 외부로부터의 자극에 대하여 생명기능을 발휘하는 그 반응의 강도 와 지속이 일정 정도의 조화를 유지하는 상태"

■ 세계보건기구

- "건강이란 단순히 질병이나 허약의 부재상태를 말하는 것이 아니고, 육체적, 정신적, 사회적, 영적 안녕이 완전한 상태"

■ 질병이란 무엇인가?

- 의학에서 질병이란?

- "생체에서 생기는 기질적 내지 기능적 이상 상태"라고 규정짓고 있고 "신체의 온갖 기능의 장애", "육체적 또는 정신적으로 건강을 상실한 상태", 그리고 "신 체적 기능과 과정의 부조화"
- 구체적인 질병의 설명- 미국국립보건연구소의 이환(罹患)의 정의
 - ☞ 육체적, 정신적인 건강의 이탈현상
 - ☞ 자신의 질병으로 인식하거나 일상생활에 제한을 가져오는 경우,
 - ☞ 타인이 인정하는 경우

- 생체를 인체에 한정해서 생각하더라도 인간은 생물적 존재임과 동시에 사회적 존재임을 알 수 있음

- 한 개인의 생체내의 이상 현상으로 파악된 질병이 일종의 사회적 현상으로서 존재하고 있다는 것도 이해할 수 있음

■ 질병은 시대와 사회에 따라 변화하는 사회성을 갖고 있음

- 중세사회에서는 페스트나 나병, 천연두, 발진티푸스
- 근대사회에서는 콜레라, 결핵이 많은 인명을 빼앗아 갔음
- 오늘날에는 암, 심장병 등의 성인병과 정신병에 최대 관심을 갖고 있음

■ 질병이 가진 역사적인 특성

- 그 시대를 지배한 사회구조에 의해 만들어진 질병의 공간성이 존재하고 있다는 것을 알 수 있음
- 그 시대의 생산구조에 의해서 인간생활이나 노동조건, 생활환경의 변화와 의료발전이 관련되어 그 사회의 여러 가지 의미를 가진 질병으로도 규정될 수 있음
- 질병은 그 발생과정에 있어서 이중의 의미로 사회와의 연관성을 가지고 있음
- 질병의 결과가 초래한 문제로 사회성이라는 면에서 질병과 사회관계를 이해할 필요가 있음

■ 질병의 영향

- 신체적으로나 정신적으로 악조건을 초래할 뿐 아니라 인간생활을 어렵게 할 수 있음
- 만성적 질병인 경우는 환자가 속해 있는 계층에 있어서 생활 곤궁과 직업상의 문제를 일으키고 생활의 기반을 파탄케 하는 사례가 있음

2) 질병에 대한 접근방법

- 의학적 접근과 사회문화적 접근으로 살펴보고자 함
- 의학적 접근과 사회문화적 접근 모두 의료의 사회적 기능을 전적으로 혹은 부분적으로 인정

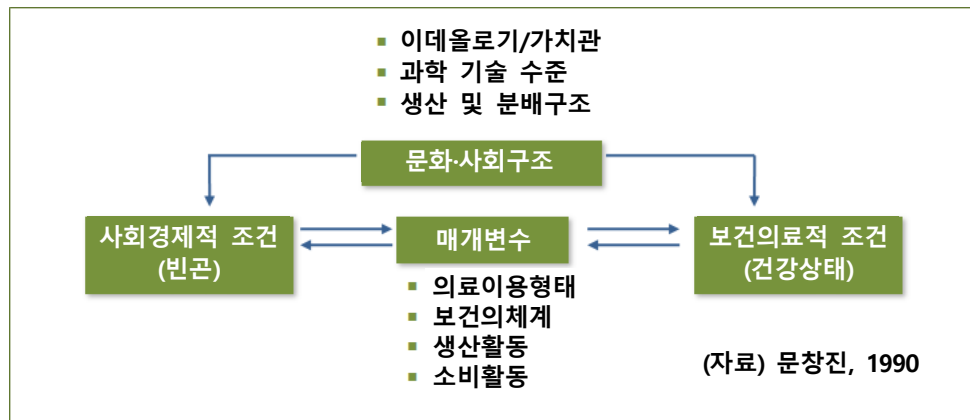
■ 건강과 질병의 판단기준

- 의학적 접근
 - 생리학적 또는 심리적 증세 등의 절대적 기능에 의존
- 사회문화적 접근
 - 사회적 기능 역할수행 상태 또는 규범으로부터의 이탈 정도에 의존
- 의학적 접근의 판단
 - 생의학적 검사와 진단을 기초로 하며, 판단의 주체가 사회적 주도적 집단 또는 준거집단이 됨
- 의학적 접근의 분류에 속하는 질병모형
 - 인체질병의 원인을 병원체감염에 두고 있는 세균이론과 생의학적 모형

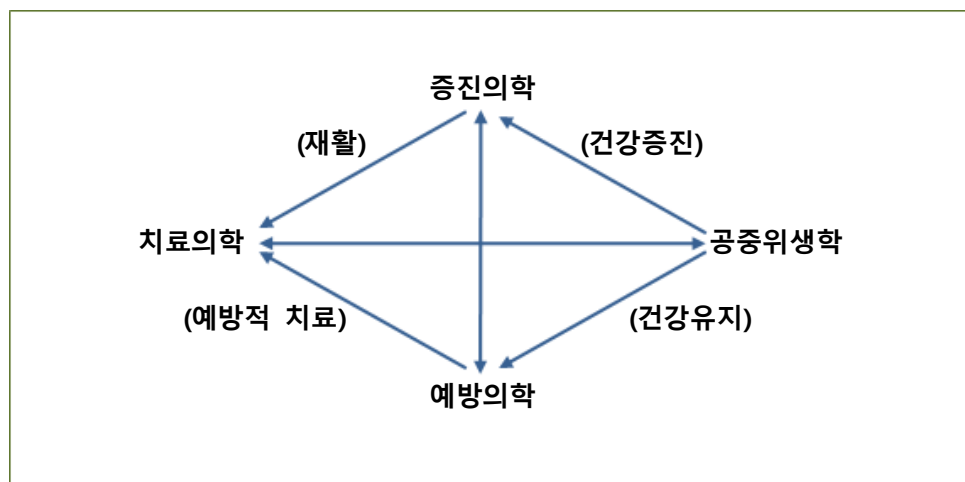
■ 사회문화적 접근

- 사회적 검증을 기초로 함
- 사회문화적 접근의 예로서는 사회 환경을 질병과정의 결정 요인으로 보는 심리사회적 모델(Psychosocial Model), 낙인론(Labeling Theory), 생의학적 모형에 심리사회적인 접근을 가미한 신생의학적 모형(New Medical Model)
- 의학적 접근과 사회문화적 접근은 상이점들을 가지고 있으나, 긍정적으로는 상호 배타적 관계에서 상호보완적 관계로 전환될 수 있음
- 전통적 생의학적 모형에 대한 반성과 아울러 사회 심리적 접근과 의학적 접근을 조화시키고자 하는 움직임이 태동되면서 통합모형이 등장
 - 통합모형의 하나인 생리-심리-사회적 모델(Bio-psycho-social Model) 질병 또는 질병의 증세와 관련된 변수를 폭넓게 수용하고, 환자는 자신의 문제를 스스로 해결하지 못하는 상태에서 무엇이 잘못되었는지도 모르고 의사를 방문
 - 의사 : 환자의 요구가 무엇이던 간에 적절한 조치를 취하여야 함
 - ☞ 사회치료를 필요로 하는 경우도 있음
 - ★ 의사는 단순한 의학적인 것 뿐 아니라 사회적, 사회심리적인 것까지도 포괄하여야 함
 - 건강상태를 포함한 보건 의학적 조건은 개인의 보건의료 이용 행태와 가계소비활동 및 경제활동에 영향을 미침으로써 사회경제적 상태를 변경시키게 함

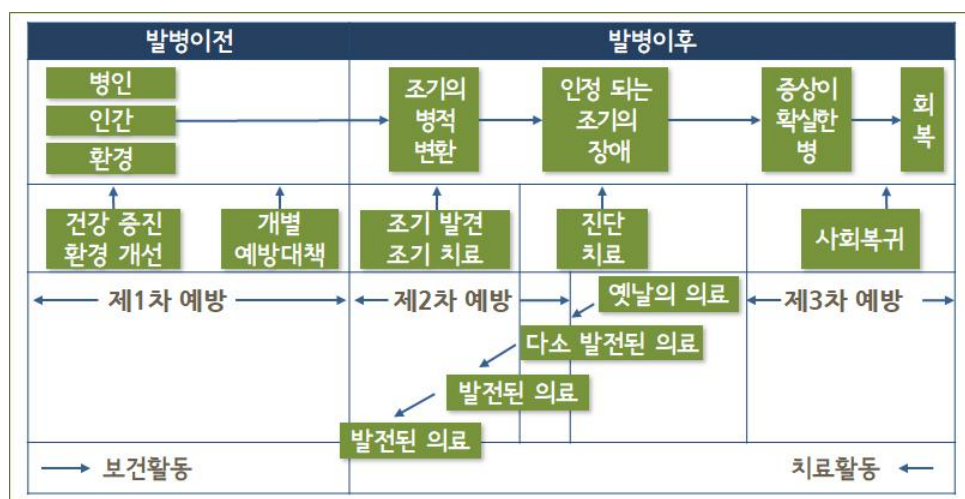
- 개인의 사회경제적 조건은 의료보장여부 및 의료서비스 전달체계, 의료비 지불 부담 능력 등의 매개변수를 통하여 변화시키고 건강에 영향을 미치게 됨



[그림 2] 빈곤과 건강의 기본관계 모형



[그림 3] 의학의 영역



[그림 4] 의료의 개념

(자료) Leavell

2. 의료복지와 의료기회

1) 의료의 사회적 정의

■ 의료복지란?

- 국민의료에 관련된 사회문제에 대응하기 위한 각종 사회제도
- 의료복지정책은 국민의 보건복지를 위한 각종 사회 정책적 방법(예 : 의료보험, 의료보호 등)을 말함
- 의료사회복지는 사회사업기술을 의료복지 영역에 적용시키는 것을 말함

■ 의료기획의 확대와 평등화

- 사회복지의 중요한 측면
- 인간의 삶의 질을 구성하는 여러 구성요소들
 - 물질적 자원, 건강, 환경, 주택, 공안, 교육 등의 요소들 가운데에서도 건강은 가장 기본적인 요소라고 할 수 있음
- 신체적, 정신적 건강은 삶의 기본조건
- 질병은 인간의 생존 그 자체를 위협하기 때문

■ 의료복지의 중심과제

- 질병으로부터의 보호(보건)와 질병의 진료를 포함하는 의료기회가 모든 사회성원들에게 골고루 분배되도록 하는 문제

■ 의료의 중요성

- 개인에게 있어 삶 그 자체와 삶의 기본조건을 충족시키는 의의를 가질 뿐 아니라 사회적인 관점에서도 매우 중요한 의의를 지님
- 첫째, 질병은 사회의 인적 자원을 유휴(遊休)시키거나 낭비하는 결과를 가져오기 때문에 질병의 예방과 진료는 효과적인 인적 자원의 공급을 위해서도 불가결한 사회적 기능을 수행
 - 예) 한 사람의 인적 자원을 확보하기 위해서는 장기간에 걸쳐 사회적 비용의 투자가 선행되기 때문에 질병에 의한 사망, 불구, 요양 등으로 인한 노동력의 유휴(遊休)는 사회적 손실
- 둘째, 질병으로 인한 유휴 인력은 사회적 부담을 가중시키는 결과를 가져옴
 - 예) 질병의 진료를 위해 소비해야 하는 의료비 불구, 요양, 또는 질병으로 인한 실업인구를 부양하는 부담을 결과적으로 사회가 지게 됨.
 - 질병으로 인한 경제활동 불능자가 가구의 생계를 맡고 있는 가구주인 경우는 그 가족원 전체가 사회보호의 대상이 됨

2) 의료기회의 사회적 책임

- 인간은 누구나 자신의 건강을 유지하고 질병으로부터 해방되기 위해서는 질병의 예방이나 치료의 모든 활동에 참여할 수 있는 능력과 기회가 있어야 함

■ 보건 및 의료기회의 불평등에 영향을 주는 가장 중요한 요인

- 개인소득의 불평등
- 개인의 의식구조와 의료관행
- 의료공급체계의 문제점 등
- 의료 기회 불평등의 요인으로서 경제적 불평등을 볼 수 있음
 - 첫째, 절대빈곤층에 속하는 개인들은 자신의 건강을 유지하는데 필요한 최소한도의 영양을 섭취하는 데에도 어려움을 느끼는 경우가 있음
 - 둘째, 경제적 빈곤은 개인으로 하여금 청결하고 위생적인 환경을 유지하기 어렵게 하며 그 결과 빈곤층인구의 질병이 환율을 높이는 효과를 가져옴
 - 셋째, 경제적 빈곤은 개인의 교육 정도에 영향을 미침으로써 그들의 낮은 교육수준은 보건위생 및 의학에 관한 그들의 관념과 형태에 간접적인 영향을 미치게 됨
- 의료기회의 불평등은 개인의 의식구조와 의료관행에 의해서도 영향을 받음
 - 의료형태도 하나의 사회적 선택행위이기 때문에 개인의 보건과 의료의 수단을 선택하는 행동은 그 개인의 가치관과 관행에 의해 영향을 받는 것
예) 개인에 따라서는 의료비부담능력이 있거나 사회보장제도가 잘 갖추어져 있는 경우에도 질병의 치료를 전통적인 민간요법이나 미신에 의존하려는 경우도 적지 않은 것
- 의료기관의 불평등은 의료공급체계와 사회보장제도에 의해서 크게 결정되어짐
 - 첫째, 의료자원의 절대 부족은 의료기회 불평등의 원인이 됨
☞ 의료인원과 시설의 절대적 부족은 자연히 의료서비스를 제한된 대상에게 제공할 수밖에 없게 된다. 의료수요의 충족은 불가능하게 하기 때문
 - 둘째, 의료자원의 지역적 분포에 있어서의 편중은 의료기회 불평등의 중요한 원인이 됨
예) 의료자원이 도시에 집중 - 농어촌주민은 의료자원과의 접근 가능성에서 제한을 받게 되며 또 더 많은 간접비용을 부담하게 함
 - 셋째, 의료인원의 지나친 전문화도 의료기회 불평등의 원인이 되고 있음
예) 대부분의 의사가 전문의가 됨으로써 의사의 도시 집중을 가중시키고 의료비를 필요이상으로 높게 하는 현상을 빚고 있음
 - 넷째, 사회보장제도의 미비도 의료기회 불평등의 중요한 원인이 되고 있음
예) 우리나라의 경우, 공적 부조로서의 의료보호는 극히 제한된 수의 기초생활 수급권자와 저소득계층에게만 혜택을 주고 있어 실제로 경제적인 어려움을 겪고 있는 빈곤 등의 가족 원들은 사회보장의 혜택에서 제외되고 있는 실정

의료사회복지의 발달 1 / 3주차 1차시

1. 의료사회복지의 기원

1) 병원(Hospital)의 기원

■ 퀸(Stant A. Queen)의 어원정의

- 중세 말엽, 주요한 구제기관(구빈원, 종교단체, 개인의 시혜를 주던 곳)을 십자군과 연관하여 창설된 구빈원 제도에서 Hospital의 기원을 찾음

■ 퓨이(Raymond de Puy)

- 빈자와 병자를 보호하는 시설형태의 사업은 그 기원을 사원 숙박소에서 찾을 수 있음
- 처음에는 순례자 환대장소로 쓰였으나, 노쇠자 · 병자 · 과부 · 유아 등의 주거지로 사용됨

■ 오늘날 병원의 무료시설운영은 Hospital의 원형적인 기능에 속함

2) 의료사회복지의 기원적인 활동

비조직적인 봉사 (UnorganizedService)	• 종교적 지도자들에 의한 원조 • 14세기 초, 병원형태의 수도원과 구빈원이 설립됨 • 빈곤자, 노동 불가능자, 맹인, 노인, 등 수용보호 • 런던시 자선진료소 설립(JohnWesley) • 자선조직협회(C.O.S)의 가정방문을 통한 치료와 생활원조
간호사들의 봉사활동 (NursingCare)	• 전통적인 간호사의 기본업무 중에 환자에 대한 사회적, 정서적 원조가 포함되어 있었음 → 조직적인 의료사회복지의 기원에 해당 • 1869년. 뉴욕시, 1887년. 보스턴, 시카고에서 전개됨 • 1893년. 뉴욕 헨리가 인보관활동 • 오늘날에도 사회복지과정에 상호 협동적 역할수행
부녀봉사원들의 활동 (LadyAlmoner)	• 1875년. 런던 자선조직협회의 로크 경의 선도적 역할로 활성화 • 1895년. 런던 왕립시료병원(Royal Free Hospital)에서 처음 채택 주된 업무) 자선수혜조건을 사정하고, 사회조사를 통해 빈곤한 환자를 타 기관에 의뢰하는 것 • 알모너(Almoner) -19c. 영국의 자선사업가, 봉사원, 의료사회복지가의 원형 • 병원과 자선조직협회간의 긴밀한 업무협조를 요청하여 환자와 그의 가족에 대한 생활원조를 제공(상호보완적 봉사활동)
정신병 환자의 사후지도 (AfterCareofInsane)	• 1880년 초. 영국의 사회복지단체의 주동으로 시작됨 • 퇴원 후에도 갈 곳이 없는 환자들을 위탁가정이나 요양원 등에 위탁 → 정신보건사회복지의 원초적 활동이 됨
의과대학생들의 봉사활동	• 1902년. 볼테모어의 존 홉킨스대학의 에멀선 박사에 의해 시작 • 의과대학생들의 환자에 대한 전반적인 이해(심리, 사회, 경제적)를 돕기 위해 시작

3) 의료에서 사회복지의 개입

■ 경제적 원조에 대한 활동

- 무료 또는 의료비 부담을 덜어주는 형태로 등장
- 이후 단순한 경제적 원조는 환자의 총체적인 문제를 해결하기에 역부족함을 깨닫고, 환자를 둘러싼 가족의 생활환경이나 생활태도의 개선에 관심을 갖게 되었음

■ 질병의 예방적 활동

- 질환에 따르는 근본적인 원인을 불건전한 주거환경, 유해한 노동조건 등에서 찾음
- 전염병 예방활동의 필요성과 질병과 사회 환경과의 관련성에 주목하게 됨

■ 질병의 종합적인 측면을 다루는 활동

- 질병의 생물학적, 심리학적, 사회적 측면을 통합적으로 이해하고 치료해야 한다고 인식됨

2. 구미 의료사회복지의 발달

1) 초기영국의 Almoner

■ 역사적 흐름

- 초기의 의료사회복지는 영국에서 싹틈
- 정신병원에서 퇴원한 환자의 사후보호를 목적으로 한 가정방문이 이미 행해짐
- 1880년 정신병환자사후지도협회 설립
- 1895년 런던의 영국왕실시료병원에 스튜어트(Mary Stewart)가 S. W'er로 채용됨으로써 시작
- 1896년 오늘날 개별사회사업(casework)과 지역사회사업조직의 선구가 되어온 자선조직협회 설립 ①자선적 주제의 조직화 ②결식생활자의 저지 ③ 빈민생활상태의 개선을 목표로 최초로 런던에서 설립

■ 등장 배경

- 19c 후반. 산업혁명으로 인한 대규모의 공장지대형성. 슬럼지역의 거대화 양산
- 자본주의의 발전과 더불어 극심한 경기변동으로 빈곤자들의 생활은 점차 악화됨
- 당시 각가지 구제활동이 있었지만 서로간의 연락조정이 미비하여 비효율적인 원조에 그침
- 자선조직협회의 기존 원조활동 중, 의료구제를 위한 시설과 활동들이 있었으나, 낮은 의료서비스 만족도로 비효과적임

• 이유

- ☞ 급증하는 환자를 충당할 의료적 공급에 한계가 있어, 환자를 선별할 수밖에 없는 고충이 있었고, 이에 따라 환자들의 입장에서 불만을 야기하게 됨
- ☞ 무지하여 의사의 지시를 이해하지 못하는 환자나 처방된 약을 가족과 함께 복용하는 환자 등 기존의 의료시스템으로는 효과적인 의료를 기대할 수 없었기 때문

■ 대표적인 알모너

- 알모너(Almoner)란?

- 14c 초 경. 수도원이나 왕실의 성문에서 빈곤한자에게 도움을 주는 자를 일컫는 말
- 입원희망자를 허가하거나, 거절하는 주요한 권한을 갖고 있음

찰스 로크 (CharlesS.Lock)	• 1869년. 무질서한 진료개혁에 큰 영향을 끼침 - 자선조직협회의 총 간사가 됨 • 헌신적인 개혁을 거듭 역설함. 1880년. "외래 진료부에는 아직도 악귀가 남아있다"고 보고함 • 진료개혁의 근본을 제시(환자의 사정방법, 치료비지불 대상자선정 기준) • 왕실시료병원에 수련된 S.W를 채용함
메리 스테와르트 (MaryStewart)	• 자선조직협회(C.O.S)의 노스샌트 팡그라스 지구에 서기로 근무 • 왕실시료병원의 S.W로 채용 • 빈곤문제에 대한 많은 지식의 보유자 • 의료관계직원들의 불신에도 불구하고 헌신적으로 일함 • 결국, 의료관리에 대한 확신과 S.W로서의 가치를 조금 씩 인정받음 • 1897년. 의료사회복지의 서비스 확장을 위한 두 명의 S.W를 추가 채용 • 환자의 색인을 만드는 작업(약 5000케이스) • 런던 시내 7개의 병원에서 알모어를 채용함 • 성 조르지 병원의 머드의 제안으로 월 1회씩 알모어 간담회를 가지게 됨 • 알모어의 능력에 따라 점차 상담작업 실시함
안 크민스 (AuneCummins)	• 35세에 성 토마스병원의 알모너로 채용됨 • 자선조직협회의 오랜 경험을 가짐 • 1898년, 년세이, 1901년 머드가알모너로채용 • 위생교육에 대한 필요성 역설 • 교육지도나 생활환경의 개선조정의 필요성 • 1909년. 노스코드의 기부금으로 사회복지서비스를 전개. 결핵환자를 위한 원조활동 전개 • 결핵환자의 인식개선에 힘씀 • 지역주민의 조직화를 통해 의료사회사업에 활용하도록 함. • 모자를 위한 복지활동, 결핵과 임산부를 위한 가정방문, 미혼모의 임신 등에 대해 원조활동 • 1929년 퇴직. 1936년 서거함

의료사회복지의 발달 2 / 3주차 2차시

1. 구미 의료사회복지의 발달

1) 미국의 개척자들

리차드 카보트(Richard C. Cabot)

- 1905년
 - 크민스가 의료사회복지사로 채용된 같은 해에 미국의 유능한 의사였음
 - 개별사회복지사의 역할을 맡음
- 영국에서 발달한 사회복지서비스를 미국의 특성에 맞게 발전시킴
- 1900년대 이후. 급속도의 공업발달로 도시사회 생성
 - 미국으로 수많은 사람들이 이주. 곤궁한 상태에서 불건강한 밀집지대 형성 국적별 이민 지역사회형성.
 - 비위생적인 주거·연소자 노동·결핵·정신질환 등 발생
- 1898년
 - 보스톤의 메사츄세츠 종합병원의 외래 진료부 의사가 됨
- 그는 질병의 근본적인 원인이 환자가 처한 사회 환경과 깊은 연관이 있음을 파악함
- 환자의 가족에 대한 교육지도가 필요함을 역설
- 의사지만, 사회적 어려운 문제에 대해 깊은 이해를 가지고 있었음
- 주립여자산업학교의 상담의 로도 활동한 바 있음
- 메사츄세츠주의 비행소녀를 다룸에 있어 새로운 방법을 사용함

가드네 펠톤(Garnet I. Pelton)

- 메사츄세츠 종합병원의 외래진료부에 채용
- 데니슨 하우스 인보관의 간호사로 재직한 경험이 있음
- 의사소통에 부자유스런 환자나 빈곤한 환자를 돌보아 주고 의사들과도 협력관계를 구축함
- 열악한 환경 속에서도 사회복지를 잘 파악하여 결핵환자를 위한 서비스를 제공함
- 결핵에 대한 공포, 질병의 본질에 대한 무지, 치료에 대한 의심을 가진 환자들에게 안정을 주고 신뢰할 수 있도록 도움
- 그러나 6개월 후. 질병으로 인해 퇴직
- 전문사회복지사업 업무의 조직화에 공헌
- 의료사회복지의 확립과 발달에 큰 공헌을 남김

이다 케논(Ida M. Cannon)

- 냇가의 빈민굴에 있는 환자를 방문하여 원조활동을 벌임
- 결핵으로 고생하는 과부, 심장병의 소녀, 알코올 중독 노동자들 등을 지속적으로 원조함
- 1907년
 - 졸업 후 런던과 파리 등의 병원을 방문
- 메사츄세츠 종합병원의 정식 직원으로 재직
- 1905~1906년
 - 환자의 신체적 상태와 정신적, 사회적 상태와의 관련성에 대해 사업 보고함
- 1906년, 뉴욕시의 벨레뷰 병원에 의료사회복지협회가 시작되어 사회사업부가 설치됨
- 1908년, 발티모어시의 존 홉킨스 대학병원에서도 사회복지부를 설치함
- 알모어들은 의사들의 몰이해와 무관심 속에서도 곳곳이 새로운 일을 개척해 나감
- 케논은 카보트 박사를 포함하여 명의 의사들과 협력관계를 맺어 케이스별로 문제를 해결해 나가기 위해 협력함

- 의사는 환자의 질환에 관심을 가지지만, S.W는 질환에 관련된 사회문제를 조사하여 적절한 서비스를 제공하는 것을 목표로 함
- 카보트박사의 보고서, 강연 등에 힘입어 의료사회복지는 서서히 발전하였고 모든 병원에 S. W'er를 두게 됨
- 의료에서도 도덕적, 정신적 문제를 다루어야 함을 느끼게 되고, 질병의 근본적인 원인이 대부분 환자의 주변환경, 무지, 피로, 빈곤 등임이 밝혀지면서 의료사회복지의 필요성이 인정되기 시작함

2) 미국의 초기발달

- 병원사회사업(Hospital Social Work)이라는 이름으로 의료사회복지사업이 실천됨
- 결핵·매독·임질 등으로 인해 발생한 각종 질병환자들을 돌보고, 빈곤환자들에게 봉사하는 역할
- 종합병원, 정신병원 등에서 S.W를 채용하면서, 환자들의 퇴원 후 사후지도 및가족력을 사정하고 원조하는 일이 가능해짐
 - 연혁
 - 1893 : 시카고 헐 하우스에 의료시료원 개원(by 제인 아담스)
 - 1902 : 결핵예방을 위한 위원회의 지도하에 공중보건운동이 시작
 - 1905 : 메사츄세츠 종합병원의 카보트 박사가 전문직으로 S.W 를 채용
 - 1907 : 존 홉킨스 병원에 브로던이 사회복지사업을 시작되었고, 여러 병원으로 확대됨
 - 1919 :미국 병원사회복지사협회 결성
 - 1925 : 아동상담소에서 S.W 를 다수 채용
 - 1926 : 정신보건사회복지사협회 결성
 - 1928 : 파리에서 국제사회복지회의 개최

- 1929 : 일본에서 최초로 사회복지부 창설
- 1933 : 연방긴급구제법 제정
- 1935 : 사회보장법 제정
- 1955 : 전국사회복지협회 결성·통합
- 1940 : 의료사회복지 잡지 출간. 정신보건사회복지협회의 전문잡지 출간
- 1950년대 : 개별사회사업의 새로운 영역(절단수술환자, 척추장애자, 심장장애자들의 재활)이 생김
- 1960년대 : 의료사회복지사가 전문직으로서 인정받기 시작함. 의료보험과 의료보호의 서비스에서 중요한 역할을 담당함
- 1970~80년대 : 행동수정, 분석치료, 자아 심리적 기술, 위기개입 등 다양한 접근 시도
가족계획, 태교, 성상담 등 예방적 프로그램 강조

• 1930년대

- ☞ 대공황으로 인한 경제불황으로 극도의 공포, 걱정, 불안이 야기됨
- ☞ 사람의 정신상태나 감정들이 신체의 기능에 장애를 줄 수 있음을 인식하기 시작하면서, 신체와 정신의 상호관련성이 연구됨
→ 의료사회복지가 환자 내적 문제에 주목할 수 있었던 계기가 됨
- ☞ 제2차 세계대전 이래로 재활의 중요성이 강조되었다. 국립 및 주립의 직업적 재활정책과 지도 계획이 설정되고 전국의 사회복지시설에 S.W가 채용됨

■ 미국의 의료사회복지사 자격조건

- 대학원 수준의 사회복지학교나 대학원의 2년간 교육을 마쳐야 함
- 보건국이나 사립의료기관 또는 병 치료의 연구실이나 의과대학 교수로 채용되기도 함

■ 미국의 의료사회복지 발전의 원인

- 카보트박사와 같은 유능한 임상의학의 과학적 요구가 있었기 때문
- 의료사회복지의 필요성을 인식한 의사들의 노력이 있었기 때문
- 유능한 임상 의학 양성을 위해 의료사회복지를 의학교육과정 중 하나로서 교육한 점이 있었기 때문

의료사회복지의 발달 3 / 4주차 1차시

1. 한국의 의료사회복지의 발달

1) 의료사회복지의 발달배경

- 우리나라에서도 유럽의 구빈원과 비슷한 제도가 거의 같은 시대에 설치된 바 있음
 - 고대에서부터 오늘날까지 위정자들은 빈민의 구제와 가난한 병자의 사료를 위하여 적절한 제도를 마련해 왔음
- 고려조에 와서는 빈곤한 환자들에게 의료의 혜택을 베풀기 위한 의료구제사업기관이 발달
 - 제11대 문종(1047-1082)은 빈민의 병자를 구호 요양하기 위하여 개경과 서경에 의료구제사업기관으로 동·서 대비원을 창설
 - 예종(1106-1122)은 일반서민에게 의약의 혜택을 펴기 위하여 혜민국을 창설하였다(1112), 공양왕(1390-1392) 3년에는 이것을 혜민전약국으로 개칭한 바 있음
 - 이들 기관에서는 빈민환자에게 의약, 의복을 내주고 무료로 치료를 해줌
- 현대적 의료사회복지의 시작은 1883년 캐나다 선교사에 의해 무료진료를 하였던 세브란스 병원의 여전도회 회원 활동에서 찾을 수 있음
 - 부녀 알모너의 기원이 됨
 - 구체적 연혁
 - 1958 : 7월 13일 한·노병원에서 사회복지사인 레케보의 지도하에 결핵 환자와 그 가족을 위하여 캐나다 유니테리안 봉사회에 인적, 물적 자원 의 보조로 돕기 시작
 - 1959 : 4월 국립중앙의료원이, 9월에는 원주기독병원의 개원과 동시에 의료사회 복지가 시작됨
 - 1962 : 국립정신병원에서도 의료사회복지 시작
 - 1962년 : 카톨릭 대학 의학부 부속 성모 병원에서 사회복지사가 처음으로 일하게 되었는데, 신경정신과 과장인 김종은 교수의 요청에 따라 병원의 허락을 얻어 천주교 사회복지사업기관의 협조로 정신병환자의 진단과 치료 및 사후지도를 위한 팀워크의 일원으로 일하게 됨
 - 1966 : 가톨릭대학 의학부 부속성모병원에서 S.W를 채용함. 초기에는 주로 신경정신과 소속으로 일하고 자살예방센터에 오는 환자의 심리사회적인 문제의 조사와 해결을 위한 업무를 함
 - 1968 : 의료사회복지과가 독립부서로서 분리됨. 신경정신과, 산업재해병동, 자선진료소, 원무 및 일반의료, 재활의료, 지역사회의료 등에 활동하고 있음

- 우리나라 의료사회복지의 초창기 주요활동

- 1964년 ~1974-5년
 - ☞ 빈곤한 환자들에게 물질적인 원조를 제공하는 것으로서 종교단체의 인적·물적 후원
 - ☞ 병원 내에 사회업과나 실이 정식으로 병원기구에 편성
- 1964년 1월
 - ☞ 연세의대 부속 세브란스병원에서는 미구감리교 세계선교부에서 파송해 준 한국인 여비서 1 명으로 사회복지과를 시작
 - ☞ 그 후 여전도사의 사임으로 기독교 세계봉사회에서 1명의 사회복지사를 파견해 주어서 1965년 말까지 근무
- 1965년 1월병원의 정식직원으로 2 명이 채용되어 오늘날 사회사업실은 사회복지사가 신경정신과, 일반의료, 재활원, 지역사회보건영역에 활동하고 있음
- 1965년 계명의대 부속 동산의료원은 당시 원장직무대리였던 시브리박사에 의하여 사회복지사 1명이 자원봉사자로 종사하다가 1968년 중단
- 1970년 신경정신과 신경준 과장에 의해서 정신보건사회복지사 1명(김기태)이 채용 되어 활동
- 1974년에는 2명으로 증원되어 신경정신과외 일반의료까지 확대하여 활동
- 1976년 7월에 사회사업과 신설되어 신경정신과 2명(김형길, 김규수)과는 별도로 의료사회복지사 4명(김상규, 이명수, 서태숙, 김현숙)으로 구성되어 활동
- 1982년 9월 20일자로 계명대학교 동산의료원 사회사업실(현조장래실장)로 승격되어 정신보건 영역(현 박인태), 재활의료영역(현 이명숙),전문사회복지사가 4명, 행정사무요원이 활동하고 있음
- 1968년 전주 예수병원에 사회사업과가 신설(10월 7일)되어 구호와 자선업무로 시작하여(이건우 과장 시작으로 현 신기수) 1977 년에 재활의학과 설치(현 강종구)함 께 활동하게 되었으며, 정신과는 1979 년부터 파견근무(현 정향숙) 1982년에는 암환자 후원회와 의료서비스 기금마련을 위해서도 노력
- 1968. 중앙대 부속 성심병원, 고려병원 등에서 사회사업업무가 시작
- 1971년에는 한강성심병원, 안양정신병원, 혜동의원(정신과)등에서 시작
- 1974년 이화여대의료원 부속병원(현, 이정일), 서울기독병원 안양정신병원, 고려대 의대부속병원
- 1975년 서분도병원
- 1976년 가톨릭의대 부속산업재해병원 서울 백제병원
- 1977년 대구파티마병원, 국립보운명원 등에서 사회복지실이 편성되기 시작
- 1973년에 9월 20일
 - ☞ 대통령령 제 6863호로 개정 의료법시행령이 공포
 - ☞ “종합병원에 환자의 갱생·재활과 사회복지를 위해 상담지도하기 위하여 사회복지사업법이 규정하는 유자격을 1일 이상 둔다”고 규정

- 1978년 부산한 병원(정신과 전문)
 - 1979년에 부산 메리놀 병원
 - 1980년에는 부산 아동병원
 - 1981년 한림대 부속 신립종합복지과
 - 1982년 인제대부속 부산백병원
 - 1983년 서울적십자병원, 연세의대부속 영동병원(현, 이숙자), 목포 성골롬반병원, 마산 고려병원 등에서 의료사회복지의 활동이 시작
 - 1973년 의료사회복지의 활동이 시작(회원32명, 최대회장 이덕규)가 설립
 - 1981년 4월 뉴스레터 및 학술지인 계간지『의료사회복지』창간호(제1권 제1회)를 발행
- 전문학술활동
- 제1차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1981.10.9.-10.11, 강원도 용평스키장 주화관과호텔),
주제 : 의료사회복지의 본질과 직무
 - 제2차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1982.9.25.-9.26, 경기도 버들캠프장),
주제 : 만성질환과 의료사회복지
 - 제3차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1983.11.19.-11.20, 서울삼성동성결회관),
주제 : 의료사회복지사의 재교육
 - 제4차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1984.10-10.14,전북여성회관),
주제 : 의료사회복지의 임상실제
 - 제5차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1985.10.11.-10.13, 경주유스호스텔호텔),
주제 : 감수성 훈련의 이론과 실제
 - 제6차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1986.6.19-6.21, 부산 애린유스호스텔),
주제 : 의료사회복지의 가치와 전문기술
 - 제7차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1987.6.4.-6.6, 안양신경정신병원),
주제 : 의료사회복지를 위한 감수성 훈련의 이론과 실제
 - 제8차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1989.11.16- 11.18 일산 홀트복지타운),
주제 : 의료사회복지의 임상실제
 - 제9차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1989.1.9-1.21 서울대 병원),
주제 : 단기가족치료
 - 제10차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1989.11.16.-11.18, 대구힐사이호텔),
주제 : 전국 의료보험실시와 의료사회복지사의 역할로 개최

- 1990년대

- 제11차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1990.11.9-11.11, 전주 삼성 생명 연수원),
주제 : 의료사회복지의 활성화를 위한 제도적 보완
- 제12차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1991.11.15.-11.17, 숭실대 사회봉사관),
주제 : 의료사회복지의 전문화와 및 자질향상방안
- 제13차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1992.11.26-11.28, 부산 동래금강유스
호스텔),
주제 : 정신보건법 제정에 따른 의료사회복지사의 역할
- 제14차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1994.3.3-3.5 서울 반도 유스호스텔),
주제 : 의료사회복지실습 표준화
- 제15차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1995.11.16-11.18, 전북 대둔산관광호텔),
주제 : 의료수가와 의료사회복지의 질 관리
- 제16차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(1996.3.19-3.20, 대전 한남대),
주제: 의료사회복지의 전문성 확립을 위한 제도적 방안 모색

- 2000년대

- 제19차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(2000.3.31-4.1, 용인 콜비하우스),
주제 : 21세기의 의료사회복지사의 새로운 역할 모색
- 제20차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(2001.3.30-4.1, 경주 교육문화회관),
주제 : 21세기 의료사회복지사의 새로운 방향 모색(2)
- 제21차 대한의료사회복지사협회 워크숍 개최(2002.2.29-3.30, 대전 유성 리베라호텔),
주제 : 의료사회복지의 실천과 가족
- 2003년 5월에 대한의료사회복지사협회 30주년 행사를 개최
- 1977년 7월 1일부터 실시되는 의료보험에서 정신의학사회복지사의 치료활동에 대한
보험수가를 청구할 수 있게 규정
- 1993년2월13일 정신보건법의 입법예고
 - ☞ 정신보건영역의 사회복지사들이 정신보건사회복지영역의 전문화와 전문이력양성은
물론 정신장애인의 정신사회재활을 목적으로 한국정신보건사회사업 학회 창립총회
및 세미나(연세대 알렌관 : 초대회장 김규수)로 창립
 - ☞ 정신보건법의 시행으로 정신보건사회복지사 수련제도(연간 150시간의 이론교육과
850시간의 임상수련 과정)
- 1998년 7월
 - ☞ 97명의 정신보건사회복지사 2급 자격증 취득을 시작
 - ☞ 2008년 2월 현재 정신보건사회복지사 1급 222명, 2급이 1,173명에 이르고 총
1,395명(수련생 233명)
- 1994년 전문학술지인『정신보건과 사회사업』이 창간

- 2000년 8월 25일
 - ☞ 학회지 평가를 신청하여 한국학술진흥재단 등재후보지로 지정
 - ☞ 2003년 12월 30일 1차년 통과하여 제16집을 발간
 - ☞ 학회원 999명의 회원으로 학술대회를 춘추로 연 2회씩 개최
(한국정신보건사회사업학회 내부 자료, 2004.2.29 현재).
 - ☞ 연세대학교 세브란스병원『의료사회사업』의 사례집을 발간
- 1997년
 - ☞ 『의료사회복지사의 직무표준화를 위한 연구』와 한림대학교 의료원 사회사업과에서 『의료사회복지의 실제』를 통하여 업무규정과 업무지침 사례 출판
 - ☞ 1997년 연세대학교 원주기독병원 사회사업과 『의료 사회복지의 활동보고서 (1959-1997)』를 통하여 연역, 업무활동, 사례연구 출판
 - ☞ 의료사회복지사의 수련 및 실습 슈퍼바이저 교육 및 수련교육
 - ☞ 1년 과정의 의료사회복지사 수련과정

2) 의료사회복지의 분야별 발달현황

정신보건사회복지	일반의료사회복지
• 필요성은 정신의학자의 요청에 의해서 대두되기 시작함 • 정신적 장애를 가진 환자와 그 가족을 대상으로 여타의 정신관련 의료 기관에서 활동 • 개별사회사업을 기본으로 환자의 사회화 내지는 재사회화하는 활동을 함 • 1945년. 정신의학회 조직. 청소년문제의 연구시작 • 당시. 미군병원의 한국 정신과 의사들의 임상경험이 쌓이게 됨 • 1958년. 서울시립아동상담소 개설을 시작으로 지속적으로 정신의학사회사업 활동이 전개됨 • 1977년. 의료보험제도의 실시로 정신보건사회복지사의 보험수가를 청구할 수 있게 됨 • 1993년. 정신보건사회사업학회 창립. 정신보건과 사회사업 전문학회지 출간. 정신보건 전문요원 자격제도	• 환자의 치료과정에 악영향을 주는 심리사회적 문제, 빈곤환자의 재활문제, 퇴원 후의 생활문제 등을 대상으로 전문적인 서비스를 제공함 • 수술환자의 상담지도. 만성질환자의 심리사회적 지도. 입원비 문제해결 • 퇴원 후 사후지도나 사회복지 지도의미약함을 보완하기 위해 앞으로는 인적, 물적, 제도적 모든 자원 활용으로 직업지도나 보도에 노력해야 함

재활의료사회복지	자선진료사업
• 재활의료시설이나 재활기관에서 장애의 기능회복과 잠재능력의 향상을 통한 적극적인 사회참여를 꾀함 • 주로 심리사회적·직업적·교육적 재활 • 1962년. 삼육재활원 • 1974년. 연세의대 부속 세브란스병원 • 1976. 메니폴병원 등에서 시작됨 • 사후적인 성격이 강함 • 기존의 인적·물적·사회제도적·법적 자원의 동원화가 시급함 • 1994년. 재활의료영역에서의 재활의학적 사회복지서비스에 대한 반대급부인 의료수가를 개인력 조사, 사회사업상담, 가정방문 부분에 청구할 수 있게 됨	• 빈곤한 환자를 위한 무료 또는 의료비 지원 • 1953년. 아동자선병원에서 무료진료 시작 • 1956년. 대구 파티마병원의 무료진료소 운영 • 1967년. 가톨릭 중앙의료원의 자선의료사업 부서발족 • 1974년. 성모자선진료소 개소 • 1983년. 목포 성 골로반 병원에서의 의료시혜 활동 • 전주 예수병원에서 지속적인 후원을 하고 있음
지역사회보건사회사업	
• 자발적 조직적인 지역사회주민의 노력에 의해 지역주민의 전체적 건강을 촉진시키는 예방의학적 목적 • 모자보건사업, 전염병관리, 환경위생, 보건교육 재활의료봉사 등 • 1967년부터 대구동산기독병원의 지역주민을 위한 보건사업을 실시 (기독교적농촌의료 시혜사업) • 전주예수병원-전라북도 완주군 용진면 지역 보건시범사업 • 1969년. 연세원주의대 부속 원주기독병원의 간질환자를 위한 순회진료사업 • 1972년. 연세의대 부속연회보건소 • 1975년. 강원도 동원탄광 주관 하의 지역사회보건사업. • 1977년. 순천향병원에서 충남 서산군을 대상으로 징거사회보건개발사업 실시. • 1981년. 한림대학부속 신림복지관에서 저소득층을 위한 의료 및 보건 사회사업서비스, 사회교육실시 • 정신의학분야와 일반의료분야에서의 양·질적 향상과 함께 지속적인 발전과제를 가지고 있음	

1. 의료전달체계의 필요성

1) 의료전달체계의 필요성

■ 의료전달체계

- 국민 모두에게 동등한 수준의 접근도를 유지하면서 체계적으로 의료 수요자에게 제공하기 위하여 병원과 의원의 배치, 기능과 상호관계 등의 의료공급체계를 말함

■ 의료계획 및 의료 정책적 차원

- 정부의 보건계획과 의료정책의 가장 기본적인 목표 국민모두가 필요할 때 최소한의 의료를 지불능력범위 내에서 용이하게 제공 받을 수 있게 의료를 조직한다는 데 있음
- 이것은 의료의 기본개념이 권리화 되었기 때문.

■ 의료적인 차원

- 횡적인분화로 여러 전문분야가 생기고, 종적인 분화로 1차 진료, 2차 진료, 3차 진료 분화되어 분업하게 됨

■ 우리나라의 의료전달체계의 문제점

- 의료인력 간의 기능분담이 거의 이루어지지 않고 있음
- 의료비의 상승
- 고급인력의 낭비
- 의료이용상의 혼란

예) 종합병원 환자집중현상으로 → 의료이용질서의 혼란 → 국민의 의료비 부담을 가중
→ 종합병원의 고유의 기능인 연구 및 교육활동을 제한 → 국민보건증진의 선도적 역할을 저해

2) 의료전달체계의 기본요건

■ 진료권의 설정 및 의료의 지역화

■ 의료이용 예측 및 의료시설 배치계획 수립

■ 의료시설 기본형의 개발 및 기능분담

- 의료기관의 기능에 합당한 병상규모, 인력, 시설 및 장비의 기본형을 개발함으로써 의료전달 체계의 확립과 장기적 의료시설 공급의 기본계획수립을 응용하게 할 수 있음

■ 합리적 후송 의뢰체계의 확립

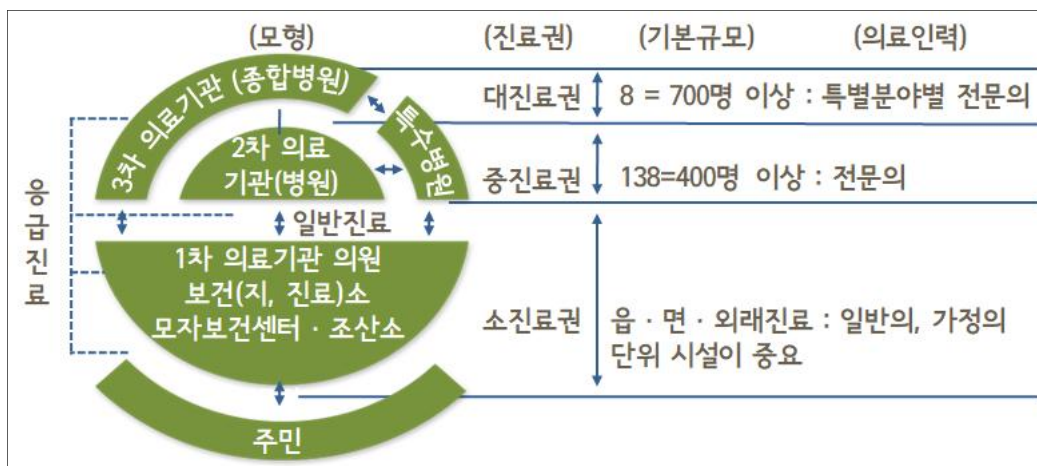
2. 의료전달체계의 모형

1) 정부시안의 두 가지 특성

- 첫째, 전국보건의료망(한국인구보건연구원)편성 확정된 전국의 8개 대진료권과 138개 중진료권별로 의료시설의 배치를 적정화하기 위한 지원책으로 의료전달체계 모형을 활용하고 있음
- 둘째, 인력과 시설간의 기능 조정을 위하여 보건의료전달체계의 원칙을 도입하되 이를 강제로 실시하지 않고 의료계의 자율성에 맡겨서 점진적으로 추진해 나가며, 종합병원의 환자 집중을 억제하겠다는 의도

2) 1차 진료단계

- 질병이 발생하여 처음 진료 담당하는 것을 1차 진료기관
 - 역할
 - 예방과 진료가 통합된 서비스 제공
 - 외래만 담당(2차 의료기관 접근도가 낮은 지역은 응급입원 인정)
- 일반의, 개업의, 전과의, 초진의 GP(general practitioner)



[그림 5] 보건의료전달체계 기본모형

3) 2차 진료단계

- 2차 진료기관
 - 해당과 전문의 진료를 말하며 병원급
 - 군, 소도시(내과, 외과, 소아과, 산부인과 등 기본 4개과) 100병상, 중소도시-대도시 200~300병상의 종합병원급

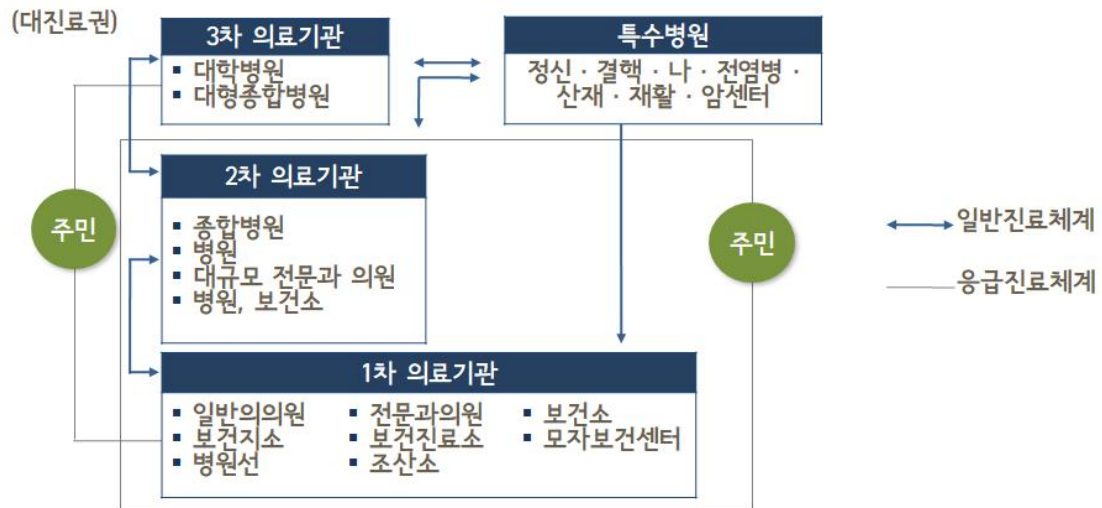
4) 3차 진료단계

- 3차 진료(Tertiary Medical Care, Sub-specialist Care)란 의과대학 부속병원 기능에 준하는 병원에서 하는 분야별 전문 진료를 말함
- 500병상 이상의 의과대학 부속병원 또는 그에 준하는 시설과 인력을 갖춘 병원, 기본형은 700병상으로 함

- 3차진료기관 환자의 진료, 의학연구, 의료인 교육훈련 및 개업의사의 보수교육 기능을 수행

5) 특수진료

- 일반병원에서 진료가 어렵거나 격리 또는 장기요양 및 치료가 필요하여 특수방사선치료나 동위원소치료, 정신병 등 특수치료와 같은 전문적인 시설이나 인력을 갖추 필요가 있는 특수병원 설치를 말함
- 특수병원의 유형
 - 정신병원, 결핵병원, 나병원, 재활원, 산업병원, 암 센터 및 전염병병원 등 14개 병원이 있음



<그림 환자1진료 및 후송의뢰체계도>

3. 포괄수가제

1) 포괄수가제(Diagnosis Related Group)의 정의 및 배경

■ 정의

- 질병 단위별로 진료비를 결정하는 방식으로 진료를 시작한 날부터 종료시 까지를 진료기간으로 하는 것
- 실제 입원 기간 동안 의료서비스의 양과 관계없이 해당 진단명 기준 별로 지불하기로 결정된 액수만큼 진료비가 지불되는 제도
- 같은 상병이라고 하더라도 환자의 인적 속성이 질병의 증상에 따라서 진료의 기간에 큰 차이가 있고 이 방식을 독립적으로 적용하기에는 어려움이 있기 때문에, 진료행위별 수가제 보완기능으로 활용하는 것이 바람직함

■ 장점

- 진단명 기준별 진료비를 지급하는 신속성으로 청구, 심사 및 지급에 모두 유리한 점을 가지고 있음

■ 단점

- 의료서비스량과 관계없이 진료비를 지급하기 때문에 이에 따른 진료의 저질화, 의료기관의 진료원가를 고려하여 중증환자나 장기환자의 기피현상 우려 내포

■ 배경

- 행정비용의 과다소요로 인한 문제점

2) 진료비 심사제도의 발전과정과 의의

■ 발전과정

- 의료보험연합회 → 진료비 공동심사위원회 → 시범요양기관제도, 자체심사제도
→ 진료비 심사의 전산화

■ 의의

- 보건·의료서비스 제공에 대한 보수를 일정한 기준에 의거 심의, 사정하여 결정하는 행위

3) DRG 지불제도의 개발

■ 개념

- 입원환자를 대상으로 한 포괄수가제도로써 환자가 어떤 질병의 진료를 위해 입원 했었는가에 따라 환자에게 제공되는 의료서비스의 양에 관계없이 DRG별로 미리 책정된 일정액의 진료비를 지급하는 제도

■ 기대효과

- 의료자원이 최적배분과 의료비의 절감이 가능하다는데 있음
 - 불필요한 의료서비스를 최소화하여 과잉진료나 의약품 오·남용을 방지하고, 재원기간을 단축시켜, 불필요한 검사 등을 줄일 수 있음
- 보험관리비용의 절감이 가능. 왜냐하면 질병단위 별로 청구·심사하기 때문에 심사 업무량이 줄어들어 인력과 시간의 낭비를 줄일 수 있기 때문
- 보험자와 의료기관의 갈등을 완화시킬 수 있음
 - 의료기관들은 산출물(질병치료)에 대한 가격이 이미 결정되어 있기 때문에 그 산출물에 투입되는 비용을 최소화하여 이윤을 극대화시키고자 의료기관의 특화 및 전문화를 촉진케 되어 영업 합리화를 기할 수도 있음
- 의료비의 절감, 행정비용의 절감, 보험자와 요양기관의 갈등 완화, 적정량의 의료서비스 제공

■ 문제점

- 진료의 왜곡현상을 초래, 질적 수준을 저하시킬 가능성
 - 진료에 투입되는 요소를 줄여 이윤을 극대화 하려는 요인을 갖게 될 것이며, 의학적으로 적절한 진료에 필요한 검사 및 투약 등을 회피할 것이 우려
- 이로 인해 적절한 치료를 받고자 하는 수요자는 이중 진료를 받을 수 밖에 없으며, 결과적으로 국민의료비의 증가를 가속화시킬 가능성이 있기 때문

■ 구체적 문제점

- 진단명에 따라 진료비가 지급되기 때문에 의료공급자가 이윤을 극대화시키기 위해 진단명을 부풀리거나 분리 청구할 가능성이 있음
- 입원 또는 효과를 볼 수 있는 경중도의 질환은 진료하고, 비용 효과적이지 못한 중증 등의 질환은 기피하거나 타 기관으로 이용할 가능성도 배제하지 못함
- 포괄수가제가 적용되지 않는 부분의 진료비가 대체 될 가능성이 높음
- 입원진료비가 줄어드는 대신 외래진료비가 증가할 우려가 높고 진료서비스의 규격화로 신규기술 이전에 대한 보상대응책이 적절치 못할 때 신기술 개발이나 임상 연구 분야의 장애가 예상되며 환자의 건강 보호라는 양질의 의료서비스와 의료기관이 수입간 균형을 보장 할 장치가 내재되어 있지 않으므로 의료의 질을 유지하려 할 때 의료기관의 경영이 악화될 수 있음

4) 의료보험 진료비 산정방식의 향후 전망 및 개선방안

■ 향후전망

- 의료보험을 비롯한 의료보장제도의 확충에 따라 사망률이 감소하고 만성병 질환이 늘고 있음
- 인구노령화 현상이 가소됨에 따라 고질적 성인병이 지속적으로 증가하고 있음
 - 의료기술이 발전되지 않았을 때는 사망할 수 밖에 없었던 이러한 만성적 질환, 노인성 질환자들이 근자에 이르러서는 환자를 사망에 이르게 하지 않고 단순한 생명 연장의 효과 밖에 없는 진료를 계속 받게 하였음
 - 그 만큼 진료원가 상승하여 국민 총 의료비 증가함

■ 개선방안

- 1차보건의료에서 인두제를 시범 사업하거나 의료보험의 진료비 산정 및 보수 지불제도 중 건강유지제도와 진료비 선불제도가 불필요한 의료서비스를 의료인 스스로 철저히 배제하기 때문에 국민 총의료비를 감소시키는데 큰 기여를 할 수 있기 때문
- 확립된 의료전달체계위에서 1, 2차 진료에서는 인두제나 진료과목별·질병별 포괄수가제 활용하고, 3차 진료는 고급의료를 필요로 하기 때문에 의료기술발전에 대한 동기부여를 해주기 위해서라도 현행 진료행위 별 수가제를 보완 및 유지토록 하는 것
- 단, 의료이용의 편의도와 질을 높이고 의료자원 활용의 효율성을 제고하기 위하여 주치의 등록제를 조속히 시행하여야 함

의료사회복지의 실천 환경 2 / 5주차 1차시

1. 병원에서의 사회복지

1) 의료사회복지의 법적 근거

■ 법적근거

- 1973년 9월20일 개정의료시행령(대통령 제6863호) 제24조 2항 5호에서부터 1992년 1월 16일 의료법 시행규칙 제28조의 ②의 6(의료인의 정원)에서 종합병원에는 사회복지사업법의 규정에 의한 사회복지사자격증을 가진 자중에서 환자의 갱생, 재활과 사회복지를 위한 상담 및 지도를 담당하는 요원을 1인 이상둔다라고 규정하고 있음
- 종합병원 승격 시 필요 조건화
 - 종합병원이나 신경정신의학과 그리고 재활분야의 전문병원에서 자격을 갖춘 자를 채용하고 있음
- 의료사회복지사 채용 확대의 필요성
 - 의료사회복지 유자격 전문가가 의료사회복지서비스를 할 수 있는 종합병원은 물론이지만 전문병원, 일반병원 수준 즉, 최소한 2차 진료기관까지 편성하여 전국민을 대상으로 하는 환자의 진료에 사회복지서비스를 줄 수 있게 확대되어야 함
 - 의료사회복지서비스는 종합병원뿐만 아니라 입원시설을 갖춘 병원 및 특수병원까지도 요구되고, 오히려 전문병원에서 더 큰 수요가 있을 수도 있음
 - ☞ 의료사회복지사 1인에 환자 100명의 법제화를 추진하고 있음
 - 의료사회복지 서비스가 입원환자의 심리·사회적 치료에 더욱 중요하기 때문
- 의료사회복지의 확대문제
 - 개정의료법시행령에 명시된 대로 최소한 종합병원 수준에 1인 이상의 의료사회복지사를 채용토록 되어 있는데 현재 사회복지사를 채용하고 있음
 - ☞ 현재 사회복지사를 채용하고 있는 종합병원 중 국공립병원은 서울대학병원, 국립보훈병원, 국립정신병원 그리고 국립대병원이 공사로 전환되면서 부분적으로 도입하는 것을 제외하고는 선교, 포교를 목적으로 하는 비영리병원 등에서 확대 운영되고 있음
 - 대한병원협회에서 실시하는 신임평가와 의료기관서비스 평가를 통해 의료사회사업서비스를 평가하고 있으며, 보건복지부와 병원협회에서 주관하는 병원인증평가에서는 더욱 강화된 의료사회복지서비스 평가를 하고 있음
 - ☞ 병원인증평가는 종합병원뿐만 아니라 노인요양병원까지 확대하여 실시하고 있음
 - 대학병원협회에서 실시한 「병원신임평가」(대한병원협회 1983년도 병원표준화심사요강, C. 지원부서「Social Work Service」부문내용)

<표> 의료사회복지

다음 항목은 현지심사시에 준비되어 있어야 한다.

- ① 의료사회복지부문과 관련된 병원의 기구 조직표
- ② 지원현황(사회복지사 자격증 사본, 대한의료사업가협회 회원증 사본 등)
- ③ 업무규정
- ④ 의료사회사업 상담 집계표, 진료비 지원실적(예산 집계표, 지원서철),
외부 자원동원비 지원 집계표, 자원봉사 활동 집계표와 교육실적
- ⑤ 의료사회사업부분의 질관리(QI) 활동 보고서
- ⑥ Case 등록부, 사회사업기록 사본 5부, 사회사업 협의질료기록지 사본 5부

※ 다음의 문항은 병원의 업무현황을 설명하는 내용으로 구성되어 있습니다.
귀 병원의 경우 다음 각 문항 중에서 실제로 해당되는 3문항에 대해서는
근거에 의거하여 해당 □안에 x 표를 정확히 기입하여 주시고 특별히
추가하여 보충 설명할 필요가 있을 때에는 이 부분의 문항이 모두 끝난
다음에 있는 보충 및 해설란에 설명하고자 하는 문항의 번호를 먼저 명시한
후 내용을 기술하여 주시기 바랍니다. 문항에 대한 응답은 이 부분의
담당책임자가 작성하여야 하며, 서명란에는 반드시 성명, 직위, 작성일자를
명기하여 주시기 바랍니다.

1. 직원현황(명)

구분	인원		고용조건		비고
	남	여	정규직	비정규직	
사회사업가					
기타직원 (직)					
계					

2. 의료사회사업부분은 병원 편제상 다음 부분에 속한다.

- ☐ Y ☐ N ☐ ① 진료부서
☐ Y ☐ N ☐ ② 진료지원부서
☐ Y ☐ N ☐ ③ 행정부서
☐ Y ☐ N ☐ ④ 기타(내용 설명) _____

3. 의료사회사업부분은 병원 편제상 다음 부분에 속한다.

- ☐ Y ☐ N ☐ ① 아니오
☐ Y ☐ N ☐ ② 예

4. 의료사회복지부문의 업무규정은 문서로 되어 있으며, 다음 사항이 포함되어 있다.

☐ N·A	☐ 해당없음(업무규정이 없으므로)
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ① 사회사업의 업무 범위와 직원의 직무분장
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ② 사회복지사의 개입 문제 목록과 활용 가능한 서비스 유형
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ③ 사회사업 서비스 대상 환자 선정 기준
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ④ 자문(Consultation)과 <u>협진</u> (Collaboration), 의뢰절차
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ⑤ 사회사업 기록(Recording)과 보존/통계, 보고서의 작성에 관한 사항
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ⑥ 사례의 진행 과정과 개입 방법에 관한 사항
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ⑦ 환자의 퇴원계획에 관한 사항
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ⑧ 환자나 가족의 비밀보장에 관한 사항
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ⑨ 활용의 가능한 외부자원에 대한 정보체계 및 기관의 List
☐ Y ☐ M ☐ N	☐ ⑩ 질 향상(QI)을 위한 방법에 관한 사항

5. 의료사회사업 부문의 기록은 다음과 같이 관리한다.

☐ N·A	☐ 해당없음(업무규정이 없으므로)
☐ N·A	☐ ① 의무기록으로 보관된다.
☐ N·A	☐ ② 사회사업 부문의 기록으로 관리한다.

6. 의료사회사업 상담 실적

구 분		건 수
개 별 상 담	심리사회·정서적 문제	
	사회복귀 및 재활 문제	
	경제적 문제	
	지역사회자원 연결 문제	
	기 타	
집 단 상 담	회	참석자: 명
계		
사회복지사 1인당 연간 상담 건수		

6.1 개별상담을 실시한다.

☐ Y ☐ N	☐ ① 아니요
☐ Y ☐ N	☐ ② 예

6.2 개별상담의 실적은?

☐ N·A	☐ 해당사항 없음(상담을 실시하지 않으므로)
☐ Y ☐ N	☐ ① 실적의 제시 근거가 분명하다.
☐ Y ☐ N	☐ ② 실적의 제시 근거가 있으나 내용이 미약하다.
☐ Y ☐ N	☐ ③ 실적의 제시되어 있으나 근거가 제시되어 있지 않다.

6.3 집단상담을 실시한다.

☐ Y ☐ N ☐ ① 아니오

☐ Y ☐ N ☐ ② 예

6.4 집단상담의 실적은?

☐ N·A ☐ 해당사항 없음(상담을 실시하지 않으므로)

☐ Y ☐ N ☐ ① 실적의 제시 근거가 분명하다.

☐ Y ☐ N ☐ ② 실적의 제시 근거가 있으나 내용이 미약하다.

☐ Y ☐ N ☐ ③ 실적의 제시되어 있으나 근거가 제시되어 있지 않다.

7. 진료비 지원 실적

구 분	진 수	금 액
병원예산		
외부자원 연결		
계		

7.1 병원의 예산을 사용하여 진료비를 지원한 실적은?

☐ N·A ☐ 해당사항 없음(병원 예산을 사용하여 진료비를 지원한 실적이 없으므로)

☐ Y ☐ N ☐ ① 실적의 제시 근거가 분명하다.

☐ Y ☐ N ☐ ② 실적의 제시 근거가 있으나 내용이 미약하다.

7.2 외부자원을 연결하여 진료비를 지원한 실적은?

☐ N·A ☐ 해당사항 없음(외부자원을 연결하여 진료비를 지원한 실적이 없으므로)

☐ Y ☐ N ☐ ① 실적의 제시 근거가 분명하다.

☐ Y ☐ N ☐ ② 실적의 제시 근거가 있으나 내용이 미약하다.

☐ Y ☐ N ☐ ③ 실적의 제시되어 있으나 근거가 제시되어 있지 않다.

8. 사회사업부문에서 활용하고 있는 자원봉사자의 수와 활동시간 및 교육시간은?

자원봉사 활용분야	자원봉사자 수	활동시간(년)	교육실시 시간(년)
()개 분야	실인원		
	연인원		

8.1 자원봉사 활동에 대한 실적은?

☐ N·A ☐ 해당사항 없음(자원봉사자를 활용하지 않으므로)

☐ Y ☐ N ☐ ① 실적의 제시 근거가 분명하다.

☐ Y ☐ N ☐ ② 실적의 제시 근거가 있으나 내용이 미약하다.

☐ Y ☐ N ☐ ③ 실적은 제시되어 있으나 근거가 제시되어 있지 않다.

8.2 자원봉사자에 대한 교육실적이 있다.

☐ Y ☐ N ☐ ① 아니오

☐ Y ☐ N ☐ ② 예

9. 사회사업부문은 다음의 질 향상 사업을 시행한다.

☐ Y ☐ M ☐ N ☐ ① 사회사업 기록 분석

☐ Y ☐ M ☐ N ☐ ② case conference

☐ Y ☐ M ☐ N ☐ ③ 사회사업 만족도 조사

10. 의료사회사업부문에 대한 질관(QI)를 정기적으로 실시하며, 다음 내용을 포함한다.(시범)

구 분		병원직성당			조사자 확인란		
사회사업 기능의 수행 여부		☐ 조직상 분리 ☐ 기능만 수행 (기능수행부서 :) ☐ 기능수행 안함			☐ 조직상 분리 ☐ 기능만 수행 (기능수행부서 :) ☐ 기능수행 안함		
사회복지사수		☐ 있다(1급 : 명, 2급 : 명) ☐ 없다 ☐ 미해당			☐ 있다(1급 : 명, 2급 : 명) ☐ 없다 ☐ 미해당		
기 능		수행여부	총건수		수행 여부	총 건수	
		예 아니오	외과상담	자발적 내원상담	예 아니오	외과상담	자발적 내원상담
상담실적	심리사회적 상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전
	경제적 문제 상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전
	퇴원계획 상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전
	지역사회자원연결 상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전
	계활상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전
	장기이식 상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전
	이용자불편불만 상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전
	집단상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전
	종교상담	☐ ☐	전	전	☐ ☐	전	전

■ 사회복지서비스에 대한 진료수가

- 1977년 7월 1일부터 의료보험에서는 정신보건영역에서 정신보건사회복지사
- 1994년부터 재활의학영역에서 재활의료사회복지사가 수가를 청구할 수 있으며, 일반의료사회사업에서는 장기이식순수성평가와 당뇨환자 교육 시 규정에 따라 청구할 수 있음
- 의료기관 서비스 평가 지침서

분류번호	코 드	분 류	점 수	금액(원)
아-1		개인정신치료 Individual Psychotherapy 주 : 1. 「가」, 「나」를 도시에 산정할 수 없다. 2. 외래의 경우 「가」, 「나」를 합하여 주 2회 이내만 산정한다. 3. 입원의 경우 「가」, 「나」를 합하여 주 6회 이내만 산정하되 「나」는 2회이내만 산정한다.		
	NN011	가. 지지요법 Supportive 주 : 정신과적 평가하여 환자의 건전한 방어 기전들을 강화하고 심리적 장애요인을 억제하여 정신장애를 해소 내지 경감 목적으로 10분정도 치료한 경우에 산정한다.	146.44	9,109
	NN011	나. 집중요법 Intensive	299.01	18,598
		다. 심층분석 요법 Intensive Analytic 주 : 환자의 무의식 내용에 대하여 증상의 완화, 성격구조 및 방어방어 양상의 수정 목적으로 45분이상 심층적으로 분석하는 경우에 산정한다.	451.15	28,062
아-2		집단정신치료 Group Psychotherapy		

아-11		정신의학적 사회사업 Psychiatric Social Work 주 : 1. 「가」는 치료기간 중 1회만 산정한다. 2. 「나」, 「다」, 「라」는 각각 주 1회 산정하되, 치료기간 중 2회 이내만 산정한다.		
	NN0111	가. 개인력 조사 Individual History Taking	111.61	6,942
	NN0112	나. 사회사업지도 Social Work Guidance	98.15	6,105
	NN0113	다. 사회조사 Social Investigation	98.15	6,105
	NN0114	라. 가정방문 Home Visting	323.57	20,126

※ 보건복지부 제2007-117호

- 이학요법료

분류번호	코 드	분 류	점 수	금액(원)
아-128		재활의학적 사회복지 Rehabilitational Social Work 주 : 1. 재활의학적 치료목적으로 사회복지사가 직접 실시한 경우에 한하여 산정한다. 2. 「가」는 치료기간 중 1회만 산정한다. 3. 「나」, 「다」는 각각 주1회만 산정하되 치료기간 중 2회 이내만 산정한다.		
	NN0141	가. 개인력 조사 Individual History Taking	103.25	6,422
	NN0142	나. 사회복지 상담 Social Work Counseling	103.25	6,422
	NN0143	다. 가정방문 Home Visiting	356.42	22,169

* 보건복지부 고시 제2007-117호

2) 병원체계에서의 사회복지부서

■ 사회복지부서의 행정원리와 기준

- 병원에서의 사회복지의 기능을 원활히 수행하기 위해서는 병원 전체의 진료체제에서 조직적인 기구편성과 부서 편성의 원리와 기준이 마련되어야 함
- 1949년 미국 의료사회복지사 협회에서 결정한 병원, 진료소, 요양소 내에서 사회복지부서의 행정원리와 기준을 보면 다음과 같음
 - 사회복지는 기관의 규정된 부서로서 조직되어야 함
 - 보건 의료기관의 모든 사회복지사는 기관의 정규직이나 임시직원으로 직무를 수행하거나 간에 하나의 부서에 조직되어야 함
 - 사회복지예산은 보건의료기관에서의 일부이어야 함
 - 모든 사회복지사는 확고한 교육 수준과 능력에 따른 전문적 자격을 갖추어야 함
 - 시설(사무실, 전화, 면접실, 회의실 등)은 전문적 기능을 수행하는 데 충분해야 함
- 1976년 병원인정기준프로그램을 위한 병원인정기준에 관한 공동위원회에서 결정된 병원의 인정기준을 보면 병원에서 사회복지서비스의 실무원리와 기준이 매우 상세하고 실제적으로 규정되어 있음
- 사회복지 서비스의 실무 원리
 - 환자의 사회적 기능을 적절히 촉진시키고
 - 환자 및 가족에 대한 질병, 장애 또는 입원으로 인한 충격을 최소화시킴
 - 적절한 지역사회자원에 대한 연계와 관련 서비스를 제고해 주기 위해 치료를 받는 환자 분 아니라 가족에게 까지 유용하게 해줌

■ 사회복지 서비스의 실무 기준

- 사례발견
 - 모든 사회복지사는 환자와 가족의 욕구를 이해하고 예견하는 활동적이고 초기적인 사례발견 프로그램을 가짐
- 퇴원계획
 - 사회복지서비스에 의한 퇴원계획은 입원 기간 동안 활성적인 사회복지사례로 판단되어진 모든 환자에게 해당됨
- 감독
 - 사회적 서비스의 전달은 유자격 사회복지사의 감독하에 수행됨
- 사회문제의 사정
 - 모든 사회복지사는 사회문제의 사정에 필요한 체계를 확립시켜야 함
- 기록
 - 모든 사회복지의 사례기록은 문제 지향적 의료기록(The Problem Medical Record: POMR)의 기록형을 따름
 - 그 밖의 모든 입원 또는 외래환자의 기록 역시 이러한 형이 유용

■ 사회복지부서의 편성

- 사회복지사가 활동하고 있는 병원의 대부분이 사회복지부서를 임상학과 동일하게 진료부에 과수준의 과나 실로 편성하여 환자나 그 가족에게 전문적인 서비스를 하고 있음
- 진료부서의 임상과와 동등하게 과(실)로 편제되어야 함
 - 독립적인 전문성에 대한 주체감을 주어야 함
 - 병원의 정책결정에 동등하게 참여할 수 있어야 함
 - 사회사업의 자원과 능력에 대한 권위를 갖게 함
 - 교육, 치료프로그램에 독특한 협력적인 팀웍이 이루어지게 함
 - 사회사업의 전문적인 실천과 프로그램개발을 용이하게 함

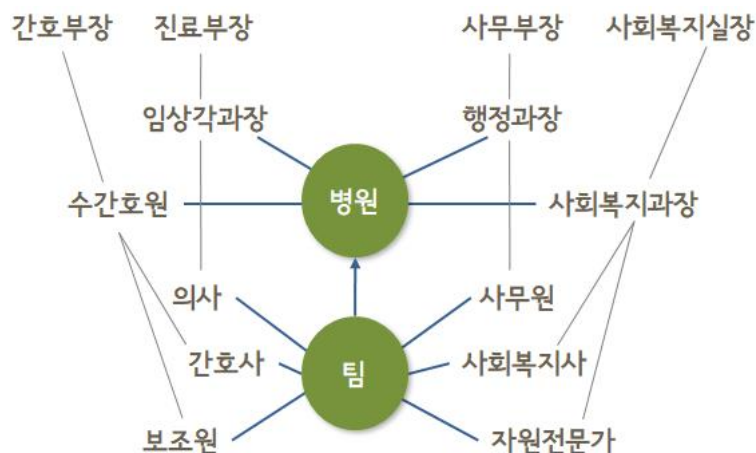
☞ 사회사업과의 위치

환자들이 많이 왕래하며 쉽게 접근할 수 있는 장소 1층

■ 미국 베스 이스라엘 병원의 의료팀

- 편성
 - 110명의 보건진료체계에 하나의 운영팀과 넷의 진료팀으로 구분
 - 운영팀에는 진료부장, 간호부장, 사무장, 사회복지실장으로 구성
 - 병원 전체를 위하여 프로그램계획에 특별한 책임을 갖게 됨

[병원행정팀]



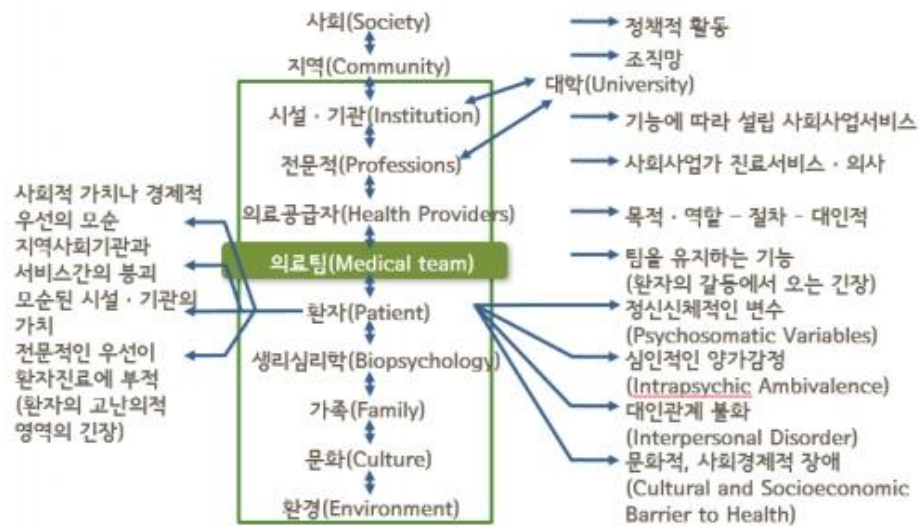
■ 보건의료의 수요공급체계

- 편성
 - 워크접근에 있어서 효과적인 진단과 치료를 하기 위해서 진료팀은 수요공급체계를 이해해야 함
 - 병원의 운영 행정팀 : 의료공급자에서 지역사회까지
 - 진료팀 : 시설기관에서 가족까지 각 그 활동 및 책임영역이 있음

[진료팀]



[보건의료의 수요·공급체계]



2. 병원에서 의료사회복지사 정원

1) 우리나라 병원의 병상규모별 사회복지사수

- 미국의 사회복지사 1인당 18명에 비해 우리나라는 사회복지사 1인당 200명 이상의 입원환자에게 서비스를 주고 있어 전문적 서비스를 줄 수 있는 직무의 양에 어려움이 있음
- 대한의료사회복지사협회는 의료사회복지사 1인에 환자 100명의 법제화를 추진하고 있음
- Lurie의 임상분야별 사회복지사 수(1983)
- Holsteen의 사회복지 직원 구성원(1983)
- 보훈병원 의료실과 진료소의 사회복지사 정원(1983)

2) 의료사회복지사 정원 책정에 따른 요인

- 임상규모나 임상별 산정기준에 따른 중요하고도 결정적인 요인
- 시설 기관적인 요인
 - 보건·의료장비의 규모가 사회복지직원기준에 중요한 타당성을 갖고 있음
 - 병원의 병상수, 평균 외래환자수, 병실활용율
- 환자의 요인
 - 환자와 그 가족들이 요구하는 사회복지서비스의 양상, 질병에 관련된 그들의 사회문제의 양과 질적 심각성, 그들의 병적 심리·사회적 문제 등이 직원의 업무의 양에 관련됨으로 직원산정에 영향을 줌
- 의사의 요인
 - 의사의 사회복지에 대한 신뢰와 태도
 - 그들의 진료에 있어서 심리·사회적 요소를 중요한 것으로 인식
- 사회복지실(과) 자체요인
 - 직무, 기능, 수준, 직원의 규모, 직무 우선순위, 책임인식, 사회복지의 일차적인 치료기능의 정도

1. 의료사회복지사의 직무

1) 의료환경 변화에 부응한 의료사회 직무의 표준화

■ 의료사회복지의 최초 전문직화

- 1905년 메사추세츠종합병원의 캐버트박사
- 주요활동
 - 의사가 정확한 진료를 행하는데 필요한 환자의 질환배후에 있는 생활조건 조사
 - 질환의 경과에 영향을 미치는 환경 조건이나 시기적 문제의 해결을 원조하고, 환자 진료에 저해되는 요인을 제거, 경감하는 역할
 - 질병에 관계되는 생활문제에 대한 사회적 대책의 확대 강화, 즉 질병이 가지는 사회성에 대한 인식, 그로 인해서 생기는 생활문제의 가중성에 대한 인식, 주체적으로 문제를 극복할 수 있도록 개별적인 생활지도(인격발달, 사회기능향상 회복)
- 보건·의료분야에서 사회복지이론을 최초로 체계화시킨 바틀레트는 사회복지의 원칙을 제시
 - 사회복지가 어떠한 실천분야에서도 적절한 역할을 수행하기 위해서는 그 분야의 문제해결을 위하여 계획된 프로그램상의 인간의 욕구 또는 상황의 심리·사회적인 측면을 이해하여야만 함
 - 사회복지는 해당기관과 그 기관에서 각 프로그램으로 해결하려는 욕구에 대한 초점과 일반적으로 목적을 같이 함
 - 사회복지에는 또한 자체의 목표를 갖고 있음
 - ☞ 즉, 자체의 독특한 주체성(Identity)이 허용되지 않는 환경에서는 효과적으로 기능할 수 없음
 - 사회복지서비스는 특별한 분야에 대한 중심적인 관심과 서비스의 성격적인 문제에 대한 심리·사회적인 측면에 초점을 둠
 - 사회복지서비스는 기관내의 보호하에서나 또는 그 밖의 방법으로 프로그램이 개인과 집단에게 제공되어짐
 - 사회복지사는 사회복지활동의 모든 주요단계에서 기관이나 행정 및 전문직의 직원과 협력함

■ 직무의 표준화와 정착화를 위한 기본적인 원칙

- 의료사회복지사가 아니면 환자와 그 가족에게 충족될 수 없는 욕구는 어떤 것인지를 알아냄
- 그 대상 문제 내지는 클라이언트의 욕구를 정확하게 탐색
- 그 욕구는 전문적인 지식과 수련을 통해서만 획득
- 다른 사람들이 했을 때 사회적으로나 전문가 측면에서 제재나 그에 대한 사회적 책임이 따를 수 있도록 제도화, 또는 규정화해야 할 것

■ 직무의 명료화를 위해서는 요구조건

- 사회복지의 서비스를 요구하는 환자나 그 가족에 관한 직무 내용
- 의료팀에서 요청하는 가정·환경적인 요인을 사정
- 퇴원계획
- 환자나 그 가족의 심리·사회적 욕구의 인식과 관심
- 정서적·사회적 또는 경제적 스트레스로부터 야기된 위기상황이나 장애를 평가하고 처치하는 일
- 의료 내지 보건사업을 위해 타 요원을 돕는 일원으로서 기초적인 것을 명료화하는 일이 중요

■ 고려해야 할 질과 양적 요소

- 사회복지사는 다양한 분야에서 다양한 수준으로 수련업무의 정확성 내지 정착화를 필요로 하며, 의료 분야에 있어서도 특수한 지식과 기술이 요구되게 됨
- 지식과 기술에는 질과 양이 서로 밀접한 관계가 있음
- 표준화, 정착화, 특히 새로운 프로그램에서 고려해야 할 양적인 요소 존재
 - 얼마나 많은 사람들이 여러 가지 현재의 서비스를 필요로 하는가?
 - 얼마나 많은 시간으로 서비스를 제공하는가?
 - 적절한 인사형태에서 인도될 수 있었던 양과 비교해서 얼마나 많은 서비스의 양을 제공하여야 하가?
- 질적인 요소
 - 수혜자 대상은 사회복지의 서비스를 필요로 하는 자들인가?
 - 서비스는 바람직한 효과를 가져오게 제공되는가?
 - 바람직한 서비스의 실천에 기여하는 철학이나 수용된 신념에 따라 서비스가 전달되어지는가?

■ 직무의 표준화 필요성

- 전문직인정, 의료서비스의 비효율성예방, 임상적인 고급화된 직무를 개발하거나 설정
 - 처우개선과 사회복지의 역할기능에 자긍심을 가져야 함

2) 의료사회복지사의 핵심적 직무(환자대상 임상직무)

■ 심리·사회·정신적 문제해결 : 환자 가족에 대한 상담

■ 사회복지 문제해결 : 정보제공과 의뢰, 퇴원계획, 지역사회연계

■ 경제적 문제해결 : 경제적 원조 및 조언

■ Team Approach : 의료진에게 케이스 자문

[의료사회복지사의 핵심직무]

조사 직무분류	Nationwide survey of Hospital Social Work Practice	Colmery-O'neil VA Medical Center(Holsteen)	미국 병원인가 기준
심리·사회·정신적 문제해결	환자와 가족에 대한 상담		사회사업 서비스를 요하는 환자와 가족의 조기 발견
			담당의사 요구가 있을 때 가정환경 조사
			환자 및 가족에 대한 사회·심리적 욕구의 인식제고 및 관심환기
			정서적 사회적 경제적 긴장으로부터 오는 위기상황과 무능력의 평가 및 치료
사회복귀 문제해결	정보제공과 의뢰	정보제공과 의뢰를 포함하는 퇴원계획	퇴원계획
	퇴원계획		
	지역사회의회	지역사회 정착 및 복귀	
경제적 문제해결	경제적 원조 및 조언	재정계획을 포함하는 환자와 가족에 대한 상담	의료부조환자 퇴원시의 정부부조 자격 여부 심사
Team Approach	병원 직원에게 케이스 자문		타 의료요원의 치료계획 원조

3) 문제유형에 따른 직무(순위별)

- 심리·사회·정신적 문제해결 직무
- 교육 및 연구조사 직무
- 행정사무
- 사회복귀 및 재활 문제해결 직무
- 지역사회자원과 연결 직무
- 경제적 문제해결 직무
- 기타직무

[한국 의료사회복지사 직무의 우선 순위 변화(1978-1985)]

	1978년	1985년
1	심리·사회·정신적 문제해결 직무	심리·사회·정신적 문제해결 직무
2	경제적 문제해결 직무	교육 및 연구조사 직무
3	사회복귀 및 재활 문제해결 직무	행정사무
4	지역사회자원과 연결 직무	사회복귀 및 재활 문제해결 직무
5	행정사무	지역사회자원과 연결 직무
6	교육 및 연구조사 직무	경제적 문제해결 직무
7	기타 직무	기타 직무

4) 서비스 대상집단에 따른 직무(미국사회복지사협회 : NASW)

■ 사회복지서비스로

- ① 개인·환자가족, 환자의 주변인물에 대한서비스
- ② 특별한 집단, 지역사회 그리고 건강과 관련된 프로그램 서비스
- ③ 교육체계의 서비스를 포함해야 한다고 규정하고 있음

■ 환자집단에 대한 구체적 직무

- 사회사업서비스 욕구측정
- 입원계획, 퇴원계획
- 개인, 가족, 집단에 대한 직접 서비스와 치료
- 사례발견 및 out-reach
- 정보와 의뢰
- 재정적 어려움에 대한 주의를 포함하여 조직 내·외에서의 환자 옹호
- 환자의 권리와 자격에 대한 보호
- 장·단기 계획
- 건강과 정신건강의 유지와 증진
- 예방적, 치료적, 재활적 조치
- 의료체계의 접근과 효과적인 활용을 보장하는 치료의 연속성 제공

■ 지역사회에 대한 서비스

- 의료서비스를 통해서 충족되지 못한 욕구 발견 및 서비스를 수혜 받지 못한 집단 발견
- 위험집단의 발견과 이들에 대한 서비스
- 클라이언트의 보호와 건강의 증진에 대하여 외부조직과 전문가들과 자문 및 협조
- 지역사회 연결 서비스
- 지역사회 계획과 조정 활동
- 심리·사회/건강교육과 증진

5) 직급에 따른 직무

- 스세스니(Scesny, 1991)는 의료분야에서 사회복지 서비스의 부서장들을 위한 지침인 Essentials에서 부서장, 선임사회복지사, 일반사회복지사의 세직급별로 각기 다른 내용 및 직무수행 기준을 제시하고 이 중에서 일반사회복지사의 직무는 문제 유형별로 다시 분류하고 있음

6) 의료사회복지사 직무 분류 기준비교

직급 직급분류	부서장	선임사회복지사	평사회복지사
임상직무	환자와 환자 가족에 대한 모든 사회복지서비스와 퇴원계획 감독	- 임상활동의 일부 - 임상 슈퍼비전	- 직접서비스 : 환자와 환자가족을 위한 면접, 사정, 계획, 상담, 의뢰, 퇴원판정, 사후치료 - 간접서비스 - 업무분담의 조직 - 환자와 치료과정 기록 - 지역사회자원에 대한 정보의 발굴 및 유지 - 환자의 치료에 관하여 다른 전문직과의 의사소통 - 서비스 영역에 대한 계획에 참여
행정직무	- 부서의 목적과 목표의 개발, 수행, 평가 - 재정담당 - 업무분담조절	- 부서의 정책과 계획결정에 참여 - 운영경비 조사 - 인력관리	- 보고서 및 통계보고 - QA프로그램 참여 - 직원회의 등을 포함한 부서의 의무수행
대인관계 직무	- 병원의 다양한 위원회 참여 - 다양한 지역사회에 대하여 병원을 대표 - 부서의 목적성취를 위해 타부서와 협동	직원간 협동적 문제해결의 촉진	- 환자, 가족, 다른 전문직, 병원 직원과의 긍정적 관계 유지 - 지역사회기관과 긍정적 의뢰관계 유지 - 부서의 효율성 저해하는 장애요인 발견 및 갈등 해결에 지도력 발휘
교육/연구 직무	- 직원개발 프로그램의 운영 - 직원들에게 자문 제공 및 평가 - 부서의 교육프로그램 개발, 수행, 평가	부서의 서비스 프로그램 개발, 계획, 평가	- 부서의 직원을 상대로 한 발표 - 연수(In-service) 교육프로그램 참여 - 연구 참여

분류기준 직무		병원크기 (AHA)	문제유형 (유수현)	서비스대상	직급	부서장
					직급	선임사회복지사
						평사회복지사
사회복지임상직무	심리·사회·정신적 문제해결 직무차원	심리·사회적 평가, 환자와 가족의 상담	심리·사회·정신적 문제해결	서비스 욕구평가, 개인, 가족, 집단에 대한 직접서비스와 치료정보와 의뢰 장/단기계획	환자와 그 가족에 대한 모든 사회복지 서비스와 퇴원계획 감독	
					임상활동의 일부 임상 슈퍼비전	
	경제적 문제해결 직무차원	경제적 문제해결 직무차원	경제적 문제해결	재정적 어려움에 대하여 조직 내외에서의 클라이언트 옹호	직접서비스 : 환자와 환자 가족을 위한 모든 사회복지 서비스와 퇴원계획, 사후치료 간접서비스 : 업무분담, 치료과정 기록, 지역사회연결, 팀 접근, 서비스 참여 계획	
	지역사회 자원연결 직무차원	지역사회 자원연결, 지역사회 기관에 사례 자문	지역사회 자원과 연결	지역사회연결 서비스	-	
	사회복귀 및 재활문제 직무차원	퇴원계획	사회복귀 및 재활 문제 확인	퇴원계획 및 재활조치	-	
	Team Approach 직무차원	타 전문직 사례 및 프로그램 자문	-	클라이언트에 대해 전문가들과 자문협조	-	
행정직무	행정직무차원	재정적 지원, 병원계획, 활동	행정사무	지역사회 계획과 조정	부서의 목적과 목표의 개발, 수행, 평가, 재정업무담당	
					부서의 정책과 계획에 참여, 인력관리	
					행정사무, 직원회의	
교육및연구직무	교육 및 연구 직무차원	서비스 검토 과정에 참여, 연구조사	교육 및 연구조사	-	직원교육프로그램 개발, 수행, 평가, 직원들에게 자문제공	
					서비스프로그램계획,개 발, 평가	
					교육 및 연구참여	

기 타	기타직무 차원	입원 전 계획, 사례발견 이자 사회적 위험 요소의 발견 병원서비스 활용촉진, 건강교육, 지역사회 서비스활동	기타직무	입원계획, 사례발견, Out Reach, 클라이언트에 대한 보호, 건강교육과 증진, 위험집단의 발견 및 서비스	위원회참여, 병원을 대표 타 부서와 협동
					직원 간 문제해결
					환자, 가족, 타 전문직, 병원직원과의 관계유지, 지역사회기관과의 의뢰, 관계유지

7) 대한의료사회복지사협회 등의 연구보고

■ 핵심직무 선정

■ 4개 집단별 최종표준 직무선정

- 대학 부속병원 일반 / 재활의료 표준직무선정
- 대학 부속병원 정신보건 표준직무 선정
- 종합 / 병 / 의원 일반 / 재활의료 표준직무 선정
- 종합 / 병 / 의원 정신보건 표준직무 선정

[최종 선정된 집단별 표준직무]

대학병원 일반/재활의료 직무		대학병원 정신의료 직무	
12. 내원객의 욕구에 의한 환자의 개별상담 13. 사회보장 및 법적제도에 대한 정보제공과 지원 14. 지역사회와의 새로운 자원개발 및 정보망 조성 15. 수집된 기존 지역 사회의 자원체계에 대한 정보 제공		12. 치료계획에 의한 환자의 가족치료 13. 수집된 기존 지역사회와의 자원체계에 대한 정보 제공 14. 질병에 의한 고위험 환자의 발견	
		15. 실습생지도	
핵심 직무			
심리·사회·정신적 문제해결 직무차원		1. 심리·사회적 문제의 원인 조사 및 사정 2. 치료 계획에 의한 환자의 개별치료 3. 환자와 환자가족의 교육 4. 환자와 환자가족에게 질병에 대한 정보제공	
경제적 문제 해결 직무차원		5. 후원자(단체) 연결금 등을 통한 병원 의적 자원과 연결◆	
지역사회자원과 연결 직무차원		6. 지역사회 자원과 연결◆	
사회복지 및 재활 문제해결 직무차원		7. 퇴원계획 상담	
Team-Approach 직무차원		8. 사례분석 평가◆	
사회복지부서의 순수행정 직무차원		9. 보고서 및 업무일지의 기록 10. 사회복지부서의 운영에 관한 회의	
교육 및 연구 조사 직무차원		11. 전문성 제고를 위한 교육참여	
12. 사회보장 및 법적 제도에 대한 정보제공과 지원 13. 병원내의 자원을 이용한 진료비 지원 14. 지역사회와의 새로운 자원개발 및 정보망 조성 15. 수집된 기존 지역사회의 자원체계에 대한 정보제공		12. 내원객의 욕구에 의한 환자의 가족상담 13. 집단활동지도 14. 사회생활 훈련지도	
종합/병/의원 일반/재활의료 직무		종합/병/의원 정신의료 직무	

* 자료 : 대한의료사회사업가협회·연세대 사회복지연구소, 1997.

의료사회복지의 대상 1 / 6주차 1차시

1. 의료의 수요 · 공급자관계

1) 의료인과 환자의 관계

- 의료복지를 다루는데 있어서 의료기술과 제도보다 중요한 문제
 - 인간의 생명을 존중하고 병약자를 도우려는 의료인과 환자와의 인간관계
- 오늘날 의료인과 환자의 관계
 - 정밀기계와 기술, 각종검사, 컴퓨터 가동 등 기계화와 의료의 진보로 오히려 인간관계를 방해함
 - 병원의 합리적인 경영으로 인한 환자와의 접촉시간이 제약됨
 - 의료의 전문화와 세분화가 때로는 관계를 비인간화하고 있는 실정
- 전문화되고 분화된 현대 의학 기술로 인하여 각종 전문적인 지식과 기술을 가진 전문가들로 구성된 의료진이 요청
 - 의료진을 통하여 환자의 질병에 따른 의료문제는 의사가 맡음
 - 심리·사회적 및 경제적 문제는 사회복지사가 돕는 등과 같이 환자에 대한 전인적 이해를 바탕으로 한 의료행위가 행해져야 할 것

2. 질병에 대한 환자 · 가족의 정서적 문제

1) 환자의 심리적 반응

- 심리반응
 - 환자는 의사의 진찰 결과를 통해 병이 있음을 알게 되면서 심리적 반응이 달라짐
 - 심리적 반응은 질병에 따른 것으로 그 반응을 어떻게 처리해 나아가며, 어떠한 방법으로 그것을 방어하는 환자의 성격이나 경험에 의해 결정되는 수가 많음
- 환자의 심리적인 반응과 성격특성에 따른 반응
 - 심계병적 경향
 - 사람이 건강할 때는 자신의 신체에 대하여 관심을 갖지 않다가, 어떤 질병에 걸리게 되면 지나치게 걱정하고 염려하게 되어 질병과는 전혀 관계없는 증상이 나타나기도 함
 - 불안과 공포의 반응
 - 환자가 자신의 병에 대한 과대적인 생각, 신체손상에 대한 두려움, 가족관계에 대한 불안감, 병원생활에 대한 두려움(노인, 소아)
 - 의혹성을 갖는 경우
 - 진단에 대한 초기진단이 확정되지 않았을 때 흔하게 볼 수 있는 경우로
 - 진단이 확정된 후에도 여러 사람들을 찾아가 자신의 질병에 대해 물음
 - 환자 자신이 안심할 수 있도록 이해시킬 필요가 있고 의료진에서는 일관성 있는 태도가 요청

- 부정의 반응
 - 과도한 불안을 방어하기 위하여 질병 그 자체를 전적으로 거부하는 경우
- 피암시성
 - 일반적으로 가지는 심리적 특성이지만 질병에 걸리면 피암시성이 높아짐
예) 의사의 말씨나 태도가 환자에게 암시적 효과가 커서 좋은 점도 있으나 자칫 잘못된 언행이 환자에게 불안의 원인이 되기도 하고 의원적 질환을 유발시키기도 함
- 애정욕구와 퇴행 현상이 강하게 나타남
 - 질병에 걸리면 애정에 대한 욕구는 더욱 강해져서 개인생활에도 많은 변화를 가져옴
예) 의사나 간호사로부터 애정적 욕구를 충족하려고 노력하나 여기서 충족되지 못하게 되면 병을 과장하거나 합리화시켜 가족이나 간호사의 애정을 끌려고 함(불필요한 진찰을 청하고 지나치게 개인적 관심을 보일 때 특히 조심하여야 함)
- 공격성 현상
 - 환자는 자기질병에 대하여 과민해져서 조그마한 일에 대해서도 불만을 표시하고, 가족, 의사, 간호사에게 공격적 태도를 보이고, 건강한 사람에 대해서 질투를 느끼게 됨
예) 자기애적 경향이 강한 경우나 결핵 같은 만성병환자에게 흔히 볼 수 있음
- 기타
 - 질병의 진단이 확정되기 전에 질병에 대한 여러 가지 엉뚱한 환상을 갖는 것이 보통이고, 장애인에게는 우울, 수치감, 고독감 등이 심해져서 공상이 많아지고 퇴행이 따르기도 함
 - 수술에 대해서는 생명의 위협을 느끼고 특히 전신마비를 두려워함
- 입원환자의 성격유형에 따른 반응
 - 의존성 성격
 - 의사를 항상 찾고, 지시를 기다리며 그렇게 해주지 않으면 화를 내고 지나치면 우울, 분노, 무감동, 정서적 반응 일으킴
 - 강박적인 성격
 - 시간관념철저, 병에 대한 책을 많이 읽음, 환자로서 임무에 빈틈이 없고, 양심적, 완고
 - 히스테리 성격
 - 질병을 결점, 약점으로 생각, 겁내고 과장적, 연극적
 - 편집적인 성격
 - 싸움만 걸려고 하며 매사를 의심, 의사의 지시에 불복종
 - 자기애적 성격
 - 우월감, 거만, 과장만 찾고 젊은 의사와 경쟁하려 함
 - 피학적 성격
 - 불운하고, 겸손과 사양, 타인의 동정을 바라고 오히려 상대를 불쾌하게 만들
 - 분열성 성격
 - 어린 시절의 실망과 상실 재현을 두려워 함

■ 의료사회복지사의 역할

- 환자가 병원에 입원하였다가 가정, 지역사회로 옮김에 따라 계속적으로 문제해결의 관점에서 그를 뒤따를 수 있는 유일한 전문요원

2) 만성질환자의 심리적 반응

■ 심리반응

- 만성질환의 경우 완전 치유가 어려움으로 성공적인 재활은 환자의 감정반응을 적절히 인식하고 처리하는데 있음
- 우울, 부정, 무기력, 열등의식의 과잉보상, 자기연민으로 무기력하게 되거나 제한된 생활에 적응이 어려워 자살시도, 주위사람들에게 공격반응을 보이기도 함
- 만성환자가 겪는 건강상실로 인한 심리적 문제를 극복할 수 있도록 감정의 발산, 방어기제의 건전한 사용을 도움
- 임종환자가 갖는 고독에의 불안, 가족이나 친구 상실에 대한 불안, 두통에의 불안, 주체성의상실에 대한 불안 등을 극복하고 죽음을 받아들일 수 있도록 도움

■ 의료사회복지사의 역할

- 만성질환자가 성공적으로 자신의 환경에 적응하기 위해서는 환자가 그 질환을 가진 채로 제한된 생활 내에서 최대의 생활을 하면서 살아갈 수 있도록 도와주는 것
예) 증상과 예측에 대한 충분하고 현실적인 지식을 가지고 환자의 역할을 기꺼이 받아들이고 협조하는 것
- 증상과 결함으로 인한 어려움이 있음에도 불구하고 가능한 최대의 자신이 되고자 하는 강한 의지와 동기를 갖게 하며, 장애를 최소로 줄이고자 작은 것에서부터 성취만족으로 자존심과 긍지를 갖게 하는 것

3) 수술환자의 심리적 반응

■ 심리반응

- 수술이 작든 크든 우리 몸의 어떤 부위의 형태를 변형시킬 뿐 아니라 기능에 있어서도 변화가 오는 것은 당연함
 - 신체상이나 신체자아에도 영향을 미치기 마련이고 나아가 자아기능에 변화를 주게 됨
 - 수술이란, 실제적이든 환상적이든 건강에 대한 신체적 손상의 두려움뿐 아니라 생명자체의 파괴에 대한 두려움의 대상으로 여기게 됨
 - 수술을 받기로 예정된 환자가 겉으로 드러내는 심리적인 반응은 철저하게 태연한 상태를 유지하거나 심리적 공황에 빠지거나 현저한 정신병적 상태에 빠지는 사람에 이르기까지 다양함

- 수술환자의 심리적 반응
 - 일반적으로 환자가 어떠한 장기이든 수술을 받아야 한다는 것을 알게 될 때
 - 일어나는 방어기제를 크게 4가지로 나누어 살펴보면 다음과 같음 부정
 - 질병자체를 부정하기도 하고, 두려움을 부정하기도 함
 - 예) 장기의 엉뚱한 부위가 불편하다고 호소하거나 진단을 믿지 못하여 이 병원, 저 병원을 다니며 검사를 받거나, 자신의 병에 해로운 일만하려 하고, 엉뚱한 사람에게 화풀이를 하기도 함
- 우울
 - 수술 전 일부 환자는 부정의 기제로도 자신의 수술에 대한 두려움을 방어하지 못하면 우울함에 빠지기도 함
 - 예) 자신이 병에 걸렸다는 사실과 그 사실에 대한 두려움을 견디지 못하는 자신의 무기력이 우울을 조장
 - 부정의 방어기제가 성공하지 못하면 반작용으로 현실 사실 이상으로 과장되게 받아들여서 절망감에 빠지는 수도 있음
- 자신감의 결여
 - 우울이 더욱 심하면 자신의 의사를 전혀 표현하려고 하지 않고 모든 것을 남이 하는 대로 맡기고 내버려두는 수도 있음
 - 심한 경우는 대수롭지 않은 수술임에도 불구하고 자기 인생을 마무리하려는 태도를 보이거나 자신의 과거 일에 후회하고 심한 죄책감에 빠지게 됨
 - 사소한 일에도 쉽게 주위 사람들이 자기를 서운하게 대한다고 불평하기도 하고 자격지심에 빠지거나 원망할 때도 있음
 - 우울과 자신감의 결여가 결국 수술 자체나 수술 후에 여러 가지 장애를 일으켜 수술경과를 나쁘게 할 수도 있음
- 정서적으로 건강한 사람
 - 처음에는 자신의 병이나 수술에 대한 두려움과 불안을 부정하다가 결국은 이 과정을 거쳐서 자신의 현 상태를 있는 그대로 받아들이고 그에 대한 두려움도 솔직히 인정하게 됨으로 안정을 되찾아 평안한 자세로 수술을 받을 준비를 하게 됨
- 수술부위에 따른 정서적 반응
 - 백내장수술
 - 쉽게 정서적 혼란에 빠짐 밤낮을 구별할 수 없는 것과 주위에 일어나는 상황을 청각이나 촉각으로 파악 할 수 없기 때문에 심리적 공황(Panic State)
 - 자궁수술
 - 비록 생식능력이 없음 경우라 일지라도 여성다움의 상징을 상실했다는 데서 오는 우울을 겪거나, 신경증을 보이며, 심하면 편집증이 되거나 일상생활이 힘들게 되는 경우도 있음

- 유방수술
 - 여성다움의 상징, 즉 어머니로서의 자부심을 갖게 하는 의미가 있음
 - 특히 젊은 여성이나 아직 어린아이를 키우고 있는 어머니의 경우 수술 후 심한 우울증이 나타나기도 함
 - 또한 간단한 불임 수술도 같은 상실로 받아들이기도 함
- 심장수술
 - 우리 몸에서 가장 중요한 부분으로 인식하고 있음
 - 따라서 심장 수술을 앞둔 한자는 자신의 수술에 대한 두려움이 커서 히스테리, 건망증, 해리현상, 흥분상태, 강렬한 부정을 나타내는 수가 많음
- 장기이식수술
 - 환자에게 심한 스트레스로 작용하여 여러 가지 문제가 야기될 수 있음
 - 사체로부터 장기이식 받은 환자는 심한 죄책감, 기증자가 살아있는 경우 기증자에 대한 의존심, 죄책감, 적개심 등으로 방황하게 됨
- 소화기관
 - 소화기관에 궤양환자의 위절제술, 대장염수술의 경우는 정신지체장애가 잘 생기는 것으로 그 근본이 되는 정신적인 갈등의 해소 없이 장기절제수술을 하면 소화장기의 증상은 없어질지 몰라도 그 근본이 되는 심리적 갈등으로 인하여 정신적 장애를 가져올 수도 있음
- 절단수술
 - 내부장기 절제수술과는 또 다른 의미가 있음
 - 절제수술은 내부라서 직접적인 확인이 안 되고 기능성의 장애로만 인지할 수 있는 것이지만 절단은 지형적 기능의 장애가 있기 때문에 신체상의 결함과 신체자아의 불안정을 유발하기 때문에 사지절단인 경우 펜텀(Phantom) 현상이 대부분 나타남

4) 환자질환에 대한 가족의 반응

- 환자의 질병에 대한 가족의 반응은 가족의 건전성과 가족관계, 의사소통, 부모의 정서체계 그리고 환자의 질병 특성 등에 따라 다르나 일반적인 반응은 다음과 같음
- 초기의 충격과 부정
 - 가족의 정서적인 반응을 행동적으로 살펴보면 우선 공통적으로 어떤 가족의 일원이 병에 걸렸을 때, 첫 단계반응 충격으로 인해 무엇을 어떻게 반응해야 할지 모르는 멍한 상태이며 다음에는 "그럴 수가 있을까요?", "믿을 수가 없어요"라는 반응을 관찰
- 불안과 공포
 - 부정이나 믿지 못하겠다는 태도는 곧 정서적인 격동기로 이어지는데 이들은 불안, 공포 등이 주종을 이루고 이 병으로 인하여 죽진 않을까, 병신이 되지 않을까? 영구적으로 어떤 기능을 상실하지 않을까 하는 불안과 공포에 사로잡힐 수 있음

- 죄책감과 책임감
 - 이것이 누구 때문인가? 혹은 내가 잘못해 주어서 생긴 일이 아닐까? 등의 죄책감과 그리고 그 병든 가족구성원에 대하여 잘못했던 일, 못해 주었던 일에 대한 후회 등을 느끼는 시기가 있음
- 화냄과 분노
 - 왜 하필이면 내 자식이, 내 남편이 무엇을 잘못하였다고 등이 분노의 감정이 나타날 수 있고, 이 때문에 의사들에게 화를 내고 항의를 하고 부적절한 요구를 하는 수가 많음
- 우울
 - 이런 시기를 지나면 슬픔과 우울 단계에 빠짐
- 수용
 - 현실적으로 병을 받아들이고 이에 대한 적절한 조치를 취하게 되는 단계
- 이와 같은 반응들은 또 다른 가족의 여러 요인에 따라 많은 영향을 받게 됨
 - 가족 생활주기에 있어서 어떠한 단계에 있는지가 영향을 줌
 - 환자의 가정에서의 역할이 어떠냐에 따라서 가정에서 질병의 영향이 크게 다를 수 있음
 - 질병의 성격차이에 따라 가족의 반응은 다름
 - 가족이 지나치게 불안을 갖거나 의식하게 되면 환자에게 투사되어 불안을 증대시키고 지나친 의존심으로 퇴행케 하여 질병치료에 악영향을 주게 됨
 - 가족의 불안이나 죄책감은 환자에게 지나친 부담을 주어 질병치료나 회복에 나쁜 영향을 줌
 - 만성질환이나 임종, 노인의 간호에 대한 조기 포기 등 관심의 소홀
 - 환자에게 불안감, 고독감, 가족의 상실, 분노, 죽음에 대한 두려움 등 치료에 중대한 영향을 미침
 - 배우자나 자녀의 신체적 손상이나 기능마비를 부정하거나 현실적인 수용하지 못하면 의료인과 환자의 치료적 관계에 대한 저항과 환자의 비현실적인 기대, 그리고 치료에 대한 방황 등으로 어려움을 갖게 됨
 - 환자가 때로는 보호자에게 원망과 공격적인 반응을 보일 때 부모와 자녀 간, 부부관계가 악화되어 특수한 문제를 낳게 되고, 보호자의 심리적 부담과 갈등은 환자에게 과잉보호를 하거나 불합리적 감정을 품을 수도 있음
 - 환자가 사회적 낙인에 대한 두려움이 있을 경우 간질환자에 대한 편견, 화상환자나 수족절단 환자들이 괴로워하는 모습과 사회적으로 불구에 대한 편견에 대한 반응
- 의료사회복지사의 역할
 - 가족의 심리적 반응이 환자의 질병치료에 방해적 요소로 작용하는 것을 배제시키거나 가족이 환자의 정서적인 지원을 계속할 수 있도록 심리사회적 문제를 해결하는데 주력하는 것이 사회복지사가 도와야 할 중대한 과제 중 하나

의료사회복지의 대상 2 / 6주차 2차시

1. 사회·경제적 문제

1) 직업에 대한 문제

- 질환이 발생하면 환자 자신은 물론 그 가족들에게도 사회적, 경제적 문제를 초래하게 됨
- 직업에 대한 문제
 - 환자가 입원하게 되면 실업에 대한 걱정으로 불안해하고 자신의 질병에 장기간 요양을 필요로 하는 경우에는 직업을 바꿔야 할 경우도 있음
 - 노동조건에서 임금, 과중한 업무에 필요 이상의 긴장을 요하는 직업영역으로 전환되지 않을까 하는 우려와 새로운 직장에 대한 과도한 긴장 및 번민 등이 있을 수 있음

2) 사회복지의 문제

- 환자가 퇴원하게 되면 좌절감, 소외감, 열등의식을 갖게 되고, 주거, 생활, 직장환경 또한 사회적응상의 문제를 가져올 수도 있음
- 만약 준비 되어 있지 않으면 좌절감과 소외감, 열등의식을 갖게 됨
 - 가정과 직장, 그리고 근린관계에서 인간관계의 불화, 불안, 불안정 상태 등에 놓임
 - 질병으로 인한 심리적·정서적 장애문제에 직면하게 됨
- 환경문제로서 환자를 둘러싼 물리적·정신적 조건이 생활환경 문제가 됨
- 주거환경을 보면 통풍, 채광, 습기 등 비위생적인 불안한 환경, 협소한 방, 공동화장실, 공동취사장, 심장병 환자나 신체 장애인의 경우 고층거주, 입원으로 거주권이 상실되는 주거, 주거비용이나 위치가 부적당한 주거, 불법건축물 비교육적이고 불량하고 우범적인 거주 등이 질병의 악순환을 가져올 수 있음
- 주거환경 못지않게 직장환경 또한 중요한 문제임 즉, 주로 중소기업에서 작업환경이 비위생적이고 위험한 직장(공기의 오염, 기계, 약품으로부터의 해독, 유행광선, 경음, 진동, 불량 조명, 이상온도) 고용관계, 업무과중, 통근한계 후생복지 등이 병원의 재발이나 사회적응상의 문제를 가져올 수 있음

3) 경제적 문제

- 질병에 따르는 경제적 문제로는 치료비와 입원비의 조달문제, 생활비와 자녀교육비 등이 질병치료에 필수적 요인이므로 환자에게 여러 가지 어려움을 갖게도 할 수 있는 문제
- 수입의 주가 되는 가족원, 남편이나 부인이 입원하게 되는 경우는 더욱 심각한 문제가 될 것
- 사회복지사가 다루어야 할 중요한 과제
 - 질병에 따른 신체적, 심리적, 정서적 고통, 생활상의 고통, 그리고 사회관계상의 어려움 등이 질병 치료에 장애적 요인으로 작용할 수 있기 때문에 이러한 심리·사회적 문제는 의료문제 못지않게 질병치료에 병행되어야 할 중요한 문제

4. 질병으로 인하여 파생되는 의료문제 외의 문제

- 심리적 문제, 사회적 문제, 경제적 문제, 환자에 대한 가족의 반응 등을 들 수 있는데 이러한 문제가 질병의 치료에 장애적인 요소로 작용할 수도 있고 때로는 질병의 악순환적 요소로 작용할 수도 있다.
- 환자의 의료문제는 의사를 중심으로 처치하지만, 심리·사회·경제적 문제는 사회복지적 기능이 요청되는 문제
 - 특수질환의 심리·사회적 문제는 아주 중요한 문제가 아닐 수 없음
 - 예) 만성질환자, 임종에 이르는 환자, 수술환자 등은 질환에 대한 혼자 자신의 수용과 재활에 대한 준비 태세는 의료적 처치보다 우선적인 문제로서 사회복지적인 기술과 서비스를 더욱 필요로 하는 것

2. 정신신체질환의 심리적 문제

1) 정신신체의학의 질환개념

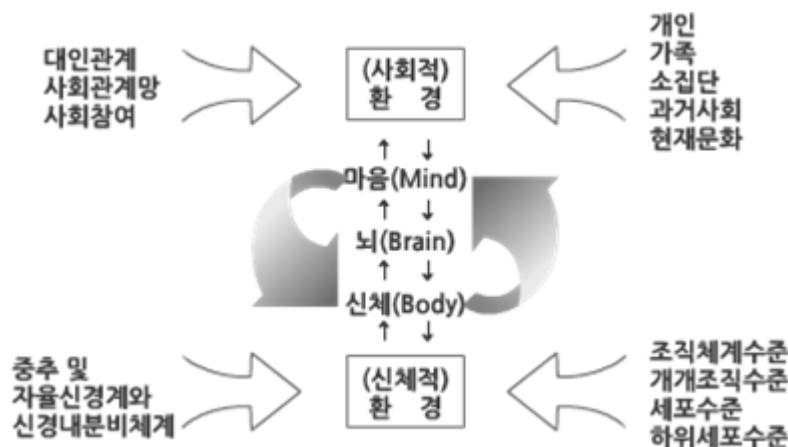
- 인간의 질병에 대한 개념의 변천
 - 질병의 단일화 원인의 추구로부터 유기체의 항상성 유지를 깨뜨리는 모든 조건들 중 정신적 요소의 중요성을 인식하게 되면서 정서와 감정이 내장의 기능적 장애를 가져올 수 있고, 때로는 질병을 가져올 수 있는 심신의 불가분적 연관성을 가지고 있기에 종합적으로 규명하고 이해하려는 경향에 이르렀음
- 정신신체의학에서 정신에너지의 경제적 배경
 - 프로이드의 정신분석학이론으로서 현실적으로 용납 할 수 없는 충동이 무의식 내에 억압되었다가 정서를 수반하여 복합으로 의식면으로 표출할 때는 변형된 형태로 나타나는데, 즉 신체적 또는 정신적 증상으로 나타냄
 - 이는 곧 정신과 신체의 상호 관련에서 심신을 일차적으로 구명하는 체계
- 정신신체질환(Psychosomatic Disease)을 설명하는 정신분석학적 개념
 - 첫째, 개인에 관한 모든 정보에서 무의식의 중요성, 신체부위와 기능의 상징적 의미, 무의식적 동기와 갈등들에 대한 지식을 제공하는 중요한 기반을 이루는데 기여함
 - 둘째, 생물학적 연구와 지견, 즉 정서나 스트레스가 시상(視床), 자율신경계통 및 내분비계통을 통하여 신체의 각 조직의 기능과 조직에 미치는 영향을 증명한 일련의 지견인 것
- 정신신체의학은 정서나 감정이 질병형성에 결정적인 역할을 하고 있다고 보고 있음
 - 환자의 개성과 정서가 병의 발생이나 경과에 미치는 영향
 - 의사와 환자의 인간관계
 - 질병이 환자의 의사(意思)와 행동에 미치는 영향
 - 일정한 치료방법에 대한 환자의 정서적 반응을 이해하고 이것을 물리학적 또는 화학적 요소와 같이 중요시 하는 넓은 의미로 받아들여지고 있음

■ 현대 정신신체의학의 조류

- 개인이 역동성을 중요시하던 면이 줄어들어 대신 환경의 자극들에 대한 정신생리반응을 강조하는 것이 특징. 즉, 정신신체의학의 이론적인 측면이 넓혀져서 건강에 대한 사회적 요소의 영향을 포함하게 된 것

■ 리포스키 등(Lipowski, Lipsitt, Whybrow)

- 가족 간의 상호작용과 가정의 붕괴, 직업에 관련된 조건들과 그 연관성, 도시화, 빈곤, 아주 급변하는 가치체계와 생활양식들이 정신생리적 기능과 건강에 충격을 주는 사회적 요인들로 받아들이게 됨



[그림 10] 생리·심리·사회적 면(Bio-Psycho-Social Field)

■ 메닝거

- 정신신체의학은 인간의 정서적, 신체적 나아가서는 사회문화적 요소의 불균형이나 항상성 유지에 위협을 주는 요인을 고려하여 환자의 심리, 사회학적 문제를 치료하는데 필수적인 것

■ 정신신체장애의 특징

- 유기체에 손상을 주고 지능장애를 가져옴
 - 이점이 정신장애와 다른 점
- 정서적 장애가 병 발생과 증상의 재발 또는 악화에 필수적인 역할을 함
 - 이점은 순수한 기질적 장애와 구별됨
- 단계적 과정을 가진 만성적 장애가 있음
- 다른 정신신체장애와 연상되는 경향이 있음
 - 이는 가족 내에서나 한 환자의 생활주기에서 나타냄
- 성별에 따라 출생률에 큰 차이가 있음

2) 정신신체질환의 심인성(心因性)

■ 심인성(心因性)

- 인간의 질병은 신체적, 생리적, 정신적 및 사회문화적 요소들이 복잡하게 상호 관계되어 영향을 받는 것
- 스트레스에 의하여 생긴 생체의 스트레스 반응을 이해하기 위해서는 스트레스 상황 하에서 뇌가 어떠한 변화를 보일 것인가에 대하여 먼저 이해하는 것이 중요함

■ 정신신체장애란?

- 정신적·정서적 요인에 의해서 신체기능의 장애가 초래되거나 악화되는 경우를 말하고 기질적 병리의 2차적 증상으로서 정신장애를 나타내는 신체정신장애(Psychosomatic Disorder)와는 구별되어야 함

■ 셀리(Selye)의 스트레스와 면역과의 관계

- 흥선 및 림프기관의 위축
- 위궤양 및 십이지장 궤양
- 부신 비대

■ 면역 기능

- 감염, 알레르기, 자가면역질환, 암 등에 대한 생체 측의 저항을 담당하고 있으며 스트레스는 면역계를 통하여 이들 질환에 영향을 미침
예) 인간에 있어서 비애, 우울, 불안상태나 행동 양식에 의한 스트레스는 자가의 면역능력에 영향을 주어 생체의 저항을 저하시켜서 발병을 촉진시키거나 예후를 악화시키게 됨
- 예전에는 스트레스와 생체의 반응 체계로서 자율신경계와 내분비계가 중심 되었으나, 근래에는 여기에 면역계를 더하여 호메오스타시스의 삼각형(the Triangle of Homeostasis)으로서 스트레스 병의 발병기전에 새로운 견해를 나타내고 있음

■ 면역질환이 발생하기 쉬운 심리적 요인에 대한 연구

- 류마티스성 관절염에 대한 보고
 - 발병의 선행 요인
 - ☞ 걱정, 일에 대한 중압감, 부부간의 불화, 육친과 이별
 - 증상악화
 - ☞ 경제적 어려움, 분노, 대수술, 이혼 친족의 죽음, 능력의 소실, 치열한 경쟁

■ 라자러스(Lazarus)

- 근래의 심리사회적 측면에서의 연구동향을 다섯 가지로 구분하면서 스트레스 자극과 개인 간의 상호교류 모형을 제의
 - 첫째, 스트레스 자극이 누구에게나 같은 반응이나 대처행동을 일으키는 것이 아니라 개인차가 있음
 - 둘째, 스트레스 자극과 신체 질병의 관계에 관심을 두고 있음
 - 셋째, 인간의 생활 변화 스트레스뿐만 아니라 인간의 생활주기에 따른 특정한 스트레스에 관심을 기울이고 있음

- 넷째, 스트레스 해결법으로서 인지행동 치료프로그램의 개발과 이의 효과에 관한 연구가 이어지고 있음
- 다섯째, 환경적, 생태학적 요인에 관한 연구가 대두됨

■ 위장계통

- 정신신체질환에는 소화기계 장애가 대단히 많음
- 식욕부진, 구갈, 오심, 구토, 소화장애, 복통, 가스, 설사, 변비 등이 포함됨
 - 소화성 궤양 : 강한 구강적 의존욕구의 좌절로 인한 무의식적인 배고픔과 분노
 - 궤양성 대장염 : 대인관계에서 중요한 인물의 상실, 배신, 좌절감 등 구강공격적 충동이 좌절될 때 설사 증상이 나타남
 - 신경성 식욕부진 : 대체적으로 지적 수준이 높고, 내성적, 이기적, 완변주의적인 젊은 독신여성에게 많음
 - 비만 : 정신역동적으로 구강적 고착이나 퇴행 때문에 형성되는 것으로 보며, 부모의 과보호 때문에 독립심과 자존심이 결여되어 있음

■ 심장혈관계통

- 심장의 기능이 정서와 밀접한 관계가 있음은 주지의 사실
- 정서의 변화에 따라서 심장박동율, 박동량, 심장박출량, 말초저항력 등의 변동을 수반함
- 심장에 어떤 질환이 있을 때는 다른 장기보다 생명에 직접적인 위험과 관련지어 불안을 갖게 됨으로써 정신적인 요인이 신체기능에 영향을 주는 상호간에 악순환을 형성하기 쉬운 점으로 미루어 볼 때 심인적인 반응이 가장 현저하게 나타나고 또 중요한 것으로 생각됨
- 호흡곤란
 - 심장질환에서 가장 흔히 나타나는 질환 중 하나(욕구불만, 갈등, 불안, 분노 등의 상태에 있어서 심장기능부전과 호흡부전이 나타남)
- 고혈압
 - 내적 긴장이 고혈압을 일으킨다고 봄(성격적 특징은 겉으로 온화하고 상냥하나 내적으로 공격적 증오를 감추고 있어 권위자에게 의존적인 태도를 보임. 강박적, 완벽추구성, 억압된 분노에 의함)
- 편두통
 - 강박적인 성격자, 완벽을 기하고 야심이 만만, 경쟁심이 강하고 책임을 남에게 맡기 못함, 부모에 대한 억압된 적개심과 억압된 성적 욕구 그리고 관련된 불안, 분노, 또는 우울 등, 정서적 스트레스나 과로 또는 피곤, 공복 등에 의해 발작 형성

■ 호흡기계통

- 호흡기 계통에 나타나는 정신신체질환으로는 호흡과다증후군을 들 수 있는데 이는 급성적 불안상태에서 초래가 많으나 대인관계 장애로 인한 분노나 적개심, 도는 성적 충동의 표현으로 인식하고 있음

- 과호흡

- 갑작스런 불안, 대인관계에서의 갈등, 꿈이나 악몽에 의한 심리적 갈등, 또는 감정적 스트레스 등에 의하여 호흡이 지나치게 빨라지고 이것이 지속되면 심계항진 및 어지럼증 등이 나타나고 얼굴과 손발이 마비되거나 경련을 일으키며, 더 심한 경우에는 전신 경련과 함께 의식이 소실되는 질병
대상) 주로 사춘기 젊은 여성에게 많이 발생하고, 심장이나 호흡기계 검사에서 아무런 이상을 발견할 수 없으며, 뇌파 검사에서도 정상 소견을 보임
증상) 예민하고 신경질적인 사춘기에서 불안, 긴장, 욕구불만 등의 상태에 이를 때 자주 나타남

- 기관지천식

- 자율신경계의 불균형에 의해서 나타나는 질환으로 기관지 횡문근을 이완시키는 부교감 신경계의 기능이 우월할 때 발생
- 기관지 천식의 유발인자 감염이 40%, 알레르기 30%, 정서적 원인 30% 따라서 기관지 천식의 원인으로 심리적인 인자를 등한시해서는 안됨
예) 천식의 발작 증상은 어머니와 헤어지는 것에 대해 저항과 울음을 통해서 어머니와의 관계를 재수립하려는 소망을 나타내는 것
즉, 어머니에게 의존적이고, 민감하며 자신감 없고, 소극적이며 불안해하고, 내적 적개심이 있는 사람이 어머니의 상실에 대한 두려움과 보호에 대한 강한 소원 등을 가질 때 천식발작이 발생
☞ 천식을 유발하는 심리적 인자
 - ★ 동생의 출생 또는 그 후에 발달한 형제간의 경쟁관계
 - ★ 여자 어린이에서 상징적으로는 어머니와의 분리를 의미할 수도 있는 초경
 - ★ 남자 어린이에서 어머니와의 의존관계를 위협하는 외디프스적 갈망
 - ★ 직접적으로 어머니를 향한 공격적이고 도전적인 충동

- 폐결핵

- 원인에는 소질적 요소와 결핵균의 감염이 중요하고 그 밖에는 영양부족과 치료 등이 있음
- 정서적 문제 : 식용분제, 식습관, 영양상태에 관하여 전신쇠약을 초래하여 폐결핵으로 발전의 소지를 갖게 됨

■ 내분비계통

- 스트레스는 만성 질병, 감염, 수술, 외상, 기아 등의 신체적 스트레스와 고도의 불안 또는 긴장상태 등의 정신적 스트레스도 나누어 생각할 수 있음
- 스트레스
 - 당뇨병의 발병을 촉진시킬 뿐만 아니라 이미 당뇨병으로 진단된 환자에서도 혈당 조절을 악화시킨다고 알려지게 되었음
 - 당뇨병의 악화 인자로서 스트레스가 거론되고 있지만 그 정확한 기전에 대해서는 아직도 분명하게 밝혀져 있지 않음
 - 스트레스가 당뇨에서는, 스트레스가 제 1 형 당뇨병의 발생과 연관이 있음
예) 실험동물의 활동을 제한하는 스트레스를 사했을 때 췌장의 일부 중 25~28%에서는 일시적인 혈당 증가나 당뇨병이 발생하였으나 정상적일 때는 이런 변화가 관찰되지 않음
- 갑상선기능
 - 스트레스로 인해 갑상선에서 갑상선 호르몬이 과다하게 분비되어 갑상선 중독이 나타나 갑상선 기능이 항진되거나 또는 갑상선이 중독되는 경우가 있음
 - ☞ 갑상선기능저하 : 갑상선 호르몬이 부족하게 되는 경우이다. 의욕이 없고 기억력이 감퇴되고, 현기증, 두통 등을 호소하고 경력, 혼수에 빠지는 경우도 있음
 - ☞ 갑상선기능항진 : 신경이 매우 예민해져, 사소한 일에도 자주 흥분하고 화를 잘 내게 되고 또한 정신집중이 되지 않고 안절부절하며 불안해지고 체력소모가 심해지고 쉽게 피로를 느끼게 됨
 - 스트레스가 갑상선의 기능에 영향을 미치는 기전
 - ☞ 갑상선 기능을 조절하는 시상하부 등의 상부조절기구 이상
 - ☞ 면역계의 변화
 - ☞ 스트레스로 인해 증가된 에피네프린에 다른 기능 항진증의 유발 등이 연관이 있음
 - 내분비기능 중에서 정서적요인과 상호관계가 가장 큰 것 중에 하나가 갑상선기능
 - 성격적으로 예민하고 불안정한 사람에게 심한 감정의 상처나 반복적 인스트레스가 주어지면 갑상선 기능 항진증이 나타날 수 있음(이런 환자는 과거에 정서적 불안정이나 적응곤란의 문제를 가졌던 사람이 많음)

■ 피부

- 피부질환이 심적 측면과 많은 연관성이 있음은 잘 알려져 있음
- 일련의 통계에서 피부과 환자 의 75%가 치료과정 중 정신적 요인의 영향을 받은 것으로 나타난 사실이 이를 잘 말해주고 있음
 - 인공피부염 : 자신의 피부에 자기 스스로 자해를 가함으로써 피부에 여러 형태의 병변이 발생할 수 있는 이상한 형태의 궤양이 나타나는 질환

- 발모벽 : 주로 어린아이에게 많이 나타남, 자기 스스로 머리를 뽑는 것이 주요 증상
- 안면 홍조증 : 보통 수치심이나 분노로 인하여 일반인에게도 일시적으로 잘 나타나는 것이나, 지속적으로 강도가 심하면 안면 홍조증이라 칭함
- 두드러기 : 여러 가지 상이한 원에 의하여 발생, 많은 원인들 중 스트레스 유발인자는 두드러기를 악화시키는 것으로 알려져 있음(만성 두드러기에 있어서는 정서적인 요인이 특히 중요하다고 알려져 있음)
- 습진 : 접촉피부염 중 직업적으로 발생하는 것은 정신적 요인으로 악화되는 경우가 있음
- 아토피 피부염 : 습진의 일종, 유전적 소인이 관여될 수 있는 질환, 정신적 스트레스도 질병 경과에 많은 영향을 미침

■ 비뇨생식계통

- 유뇨증은 만 5세 이후에도 소변을 의지적으로 가릴 수 없는 경우를 말함
- 크게 지속성 유뇨증과 퇴행성 유뇨증으로 구분
 - 지속성 유뇨증 : 소변을 가릴 시기가 지나서도 1 년 이상 소변을 가리지 못하는 경우 (부모의 훈련이 적절하지 못할 때, 정신적 스트레스가 원인, 유전적 요인, 중추신경계의 미성숙, 방광의 부분적인 기능장애 등)
 - 퇴행성 유뇨증 : 소변을 잘 가리던 아이가 어떤 사건이나 주위 환경의 변화로 인해 다시 소변을 가리지 못하게 되는 경우
- 유뇨증은 복합적인 원이 관련되나 어린이에서 심리적 갈등이 발병 원인 경우
 - 놀이치료와 부모 및 양육자의 심리사회적 치료가 병행되어야 함
- 심인적 요인에 영향을 많이 받는 장애
 - 남성 : 성교불능, 조루증, 배뇨장애,
 - 여성 : 불감증, 성교 시 통증, 월경장애 등
- 비뇨생식 장애의 정서적인 면
 - 근친상간적 갈등, 잠재적인 동성애, 성기에 대한 거세공포, 음경선망, 성 역할의 양가감정 등
- 가정을 비롯한 환경에서 비롯된 비뇨생식 장애
 - 성 표현의 죄악시, 순결성에 대한 강박적인 집착, 도덕교육과 성교육학습상의 문제 등

■ 근골격계

- 근육의 긴장도, 골격이 이루는 형태, 전신의 자세가 개인의 정신상태와 감정을 표시
정서적인 불안, 긴장, 분노 등의 상태에 있는 자는 불가피하게 근골격계의 긴장상태를 초래함
 - 이것이 장기간 지속되면 습관적인 체위 또는 자세로 변화를 가져올 수도 있음.
개인의 감정이 근골격계를 통하게 되며 내적 긴장이 근육운동을 통하여 발산될 수 있는 것(류머티스성 관절염, 골관절염, 비관절성 류마티즘, 요통, 섬유 근육통)

■ 이상에서 의료사회복지사의 기능적 대상문제는 크게는 둘로 볼 수 있음

- 첫째, 질병으로 인하여 파생된 문제가 질병치료에 역기능적으로 작용할 수 있는 문제
- 둘째, 인간의 심리·사회적 문제가 신체화, 즉 신체적 질병을 유발시키는 정신신체장애의 문제. 이는 정서나 스트레스가 시상, 자율신경계통 및 내분비계통을 통하여 신체 각 조직의 기능에 장애를 주는 것을 말함. 특히 무의식적 갈등, 심리·사회요인이 정신역동학적으로 작용하는 경우가 많은데, 이는 의학적 처치도 필요하겠으나 근본적인 치료는 심인적인 치료에 있기 때문에 고도의 심리·사회적 치료가 요구되는 대상문제

의료사회복지의 기능과 역할 1 / 7주차 1차시

1. 의료사회복지의 기능

1) 의료사회복지기능

■ 병원에서의 사회복지 기능(미국병원협회)

- 환자의 병 치료나 회복에 관련되는 사회적, 경제적, 정서적인 요인의 중요성을 의료팀이 이해하도록 도움
- 환자나 그 가족들에게 질환에 영향력이 있는 요인을 이해시켜 의료적인 서비스를 건설적으로 활용하도록 도움
- 환자와 그 가족의 복지와 사기를 진작시킴
- 의료팀 가운데 다른 전문가의 교육적 활동에 참여함
- 다양한 서비스를 통해서 보다 양질의 의료적인 처치가 되도록 병원을 도움
- 환자나 그 가족들의 욕구를 충족시키기 위하여 지역사회 자원이 건설적으로 사용될 수 있도록 도움

2) 의료사회복지의 본질적 기능

■ 의료팀과 협동

- 합리적이고 전인적인 진료를 위하여 의료팀을 구성하여 활동하는 것이 바람직함
 - 의료팀 : 의사, 간호사, 의료사회복지사, 물리치료사, 작업치료사, 언어치료사로 구성
 - 의료사회복지사는 환자의 신상에 관해 정확하게 파악하고 사정 평가하여 의료팀 구성원들에게 정보를 제공하여 이해시키며 협동적인 진료계획을 설정하는데 상호협동함

■ 환자 및 그 가족에 대한 직접적인 서비스

- 환자에 대한 이해를 위해 정보를 수집, 사정, 평가하는 심리사회적 접근을 함
- 가족이나 직장 및 사회관계자와 함께 환자 치료에 협력적인 체계를 구축하고 환자가 자신의 병에 대해서나 병원 및 진료진에 대한 태도와 그 반응을 연구하여 주어진 상황에 잘 적응할 수 있도록 도움
- 환자의 병으로 야기되는 정서적 문제나 사회문제에 관하여 도움
- 사회복지사는 경제적으로 문제가 되는 환자엔 무료진료의 적격여부를 가정하고 요구 환자에 대한 제도적 자원의 활용방안을 모색함
 - 퇴원 후 계획, 만성병, 성인병에 대한 환자 및 그 가족들에 대한 심리사회적인 서비스
 - 재활을 요하는 환자, 정신질환자, 정신신체증 환자에 대한 심리적 문제에 대한 서비스

■ 병원 내의 프로그램계획에의 참여

- 의료사회복지사는 사회복지의 전문적 지식과 경험을 비롯하여 보건의료의 전달체계와 병원행정이나 병원서비스가 지역사회복지자원으로서 대내외적인 기능을 다 할 수 있도록 병원의 정책 결정과정에 참여하여 보건 및 보건 및 사회복지적인 서비스를 위한 프로그램의 제안이나 설정에 개입함

■ 지역사회자원조직에 참여

- 보건의료나 예방사업 활동
- 지역사회의 보건의료기관이나 행정당국의 유기적인 관계
- 진료 및 예방사업의 다양화와 양질의 서비스를 지역주민에게 제공
- 지역사회의 관련자료를 체계화하고 동원할 수 있도록 조직하고 계획하는 활동을 함
 - 정신질환자의 사후지도를 비롯한 재활 및 사회복지를 위한 직업보도
 - 각종 의료 사고로 인한 사회적·직업적 재활에서 자원활용은 다른 전문가보다 독특한 사회복지의 기능 중 하나임

■ 교육프로그램에 참여

- 수련병원에서 특별히 의과대학생, 간호학과 학생, 사회복지학과 학생들의 보건·의료영역의 전문적인 교육과 임상 실습을 하는 데 참여
- 의료팀의 일원으로서 사회복지사의 기능과 역할을 소개함
- 전인적인 진료를 위한 다양한 프로그램을 지도함

■ 의료에 관련된 조사연구에 관여

- 보건분야에서 사회복지활동의 개입에 필요한 수요를 측정함
- 이러한 욕구에 따라 새로운 프로그램을 계획하거나 수정함
- 주어진 서비스의 효과를 측정 평가하는 일을 함
- 병원기능이나 의료전달체계의 활용에 따른 과학적이고 합리적인 기초자료를 탐색함
- 의료복지에 관한 문제를 제시함
- 개선을 위한 자원을 탐색, 조사함

■ 의료사회복지의 독특성

- 질병이나 신체적 장애나 의료적 처지에 관련된 사회적 욕구와 그 문제에 핵심을 두고 있음
- 의료기관에서 타 전문요원과 협동적인 활동으로 다양한 서비스를 창출해 내는 일
- 지역사회의 의료적·사회복지적인 서비스를 조정하고, 지역사회자원을 연결시키는 점

■ 미국의 의료에 있어서 의료사회복지의 최저기준으로서의 기능

- 의료개별사회사업(Medical Case Work)
- 의료기관의 내부에 있어서 의료사회문제와 관련된 사업계획의 실현
- 지역사회에 있어서 보건·의료의 사회문제에 대한 대책 활동에의 참여
- 각종 전문가 교육에 참여
- 의료사회문제에 대한 사회조사연구 등을 규정하고 있음

■ 영국의 의료사회복지의 기능(의료사회복지사협회 전국협의회)

- 환자 개인에 대한 사회사업 서비스의 제공
 - 단순한 물질 원조 및 환자의 복잡한 사회심리적 문제를 개별사회복지방법에 의해 해결함
- 지역사회활동(Community Work)
- 교육활동
 - 의학, 간호학, 사회사업(복지)학의 학생에 대한 교육과 훈련
- 조사연구활동
 - 의학의 사회적 측면에 대한 연구 및 개인과 환경과의 상호관계 등을 규정하고 있음

3) 의료사회복지의 핵심적 기능

■ 미국사회복지사협회가 정한 11가지 기능

- 사회사업서비스에 대한 욕구의 사정
- 입원계획과 퇴원계획
- 개인, 가족, 집단에 대한 직접적인 서비스와 치료
- 케이스 발견 및 탐색활동
- 정보제공과 의뢰
- 치료비 절약에 대한 관심을 포함하여 병원내외에서의 환자의 대변
- 환자의 권리와 자격의 보호
- 사회사업 서비스 제공환자에 대한 장·단기의 계획
- 신체적·정신적 건강의 촉진과 유지
- 예방적·치료적·재활적 조치
- 치료의 기회에 접근하고 그 기회를 활용할 수 있도록 보장해 주는 것을 포함하여 치료의 연속성 제공

■ 「미국 의료사회복지실제에 관한 전국 조사」

- 사회복지사의 반응에서 응답자 92%~93%가 다음의 기능을 답함
 - 환자와 그 가족에 대한 상담(99%)
 - 정보제공과 의뢰(98%)
 - 퇴원계획(97%) - 지역사회기관 의뢰(97%)
 - 경제적 원조 또는 처리(92%)
 - 병원 직원과 케이스 상의(Consultation)(92%)
 - ☞ 정보제공과 의뢰, 상담(Counseling), 퇴원계획, 지역사회에 의뢰, 경제적 원조로 이것이 병원사회복지의 기본적인 핵심기능임

4) 의료사회복지의 확대적 기능

■ 현대병원사회복지의 19항의 기능

- 정보와 의뢰(Information and Referral)
 - 이용할 수 있는 지역사회자원의 유형에 관한 정보를 환자와 그의 가족에게 제공함
- 지역사회기관 의뢰의 촉진(Facilitating Community Agency Referral)
 - 단순한 정보이상의 원조는 적절한 자원에 환자의 접근을 확실히 함
- 입원 전 계획(Preadmission Planning)
 - 환자와 그 가족의 문제에 대한 상담은 직접적으로 병원입원을 위한 계획과 조정에 관계됨
- 사례발견 혹은 사회위험심사(Case Finding or Social Risk Screening)
 - 잠재적으로 사회사업서비스가 필요한 환자를 가려내거나 그런 서비스의 대비를 위한 조직된 프로그램
- 퇴원계획(Discharge Planning)
 - 환자의 문제에 직접적으로 상담하는 것은 입원기간 동안 유익한 것이 많도록 하여 퇴원 후 치료를 계획하고 조정하는데 관계하는 것
- 병원서비스 이용의 촉진(Facilitating Use of Hospital Service)
 - 병원의 모든 부서와 직원들을 상대로 해서 환자와 가족을 대신하여 변호역할을 함
- 환자와 가족상담(Counseling of Patients and Families)
 - 상담은 환자와 그 가족들을 도와서 건강과 의료에 관련되어 있는 상황을 보다 효과적으로 처리해 나갈 수 있도록 하는 것을 목적으로 함
- 심리사회적 평가(Psycho-social Evaluation)
 - 환자의 사회적·심리적·문화적·환경적·경제적인 상황에 관한 정보 수집과 심리사회적 평가와 치료계획 또는 공식적 보고서 작성을 위한 정보의 활용이 필요함
- 건강교육(Health Education)
 - 구성되어진 프로그램을 통하여 환자와 가족에게 사실적인 지식을 제공해 줌으로써 환자의 지식향상 즉 가족계획, 산아제한, 빈혈증, 알코올중독 등의 지식을 제공해 줌
- 재정적인 원조(Financial Assistance)
 - 병원 사회복지실에서 직접적으로 재정적 EH는 다른 구체적인 보조를 제공함
- 재검토의 활용(Utilization Review)
 - 공식적인 병원 재검토과정에 참여하는데 이는 PSRO(전문적 표준 재검토 기구)의 요청과 관련되어 있음
- 병원직원과의 사례자문(Case Consultation to Hospital Staff)
 - 구성되어진 회의에서 다른 의료진에게 환자의 심리사회적인 문제, 수속, 서비스에 관련된 상세한 지식을 제공해 줌

- 지역사회기관과 사례자문(Case Consultation to Hospital Staff)
 - 구성되어진 회의에서 다른 외부의 보건직원들에게 보다 적극적으로 환자의 심리사회적인 문제들에 관한 특수한 지식을 제공함
 - 병원직원들에게 프로그램자문(Program Consultation to Hospital Staff)
 - 충족되지 못한 욕구를 확정하기 위하여 환자집단을 평가하고 부서를 이용하기 위하여 환자보호문제에 관한 정보를 조사하며, 환자와 가족의 권리에 관련된 병원방침과 수속에서의 변화를 찾아내고 조언을 줌
 - 지역사회기관과의 프로그램자문(Program Consultation to Community Agencies)
 - 회의를 통하여 기관에 상세한 지식을 제공해 줌
 - 병원계획활동(Hospital Planning Activity)
 - 지역사회 서비스와 관련된 단기·장기계획과 프로그램개발에 관련된 조직화된 활동과 기관의 메카니즘에 관련된 활동을 함
 - 지역사회 건강계획 활동(Community Health Planning Activities)
 - 지역사회와 그 기관이 힘을 모아 환자와 가족들의 욕구를 충족시키기 위해 필요한 프로그램과 지역사회자원을 개발하는 일을 함
 - 지역사회 서비스활동(Community Service Activity)
 - 충족되지 못한 욕구를 확정하기 위하여 환자집단을 평가하고 부서를 이용하기 위하여 환자보호문제에 관한 정보를 조사하며, 환자와 가족의 권리에 관련된 병원방침과 수속에서의 변화를 찾아내고 조언을 줌
 - 조사(Research)
 - 환자의 관심과 욕구의 심리사회적인 요소를 조사하기 위한 조직화된 체계
 - 병원과 사회복지과의 환자보호의 평가 및 자체조사
 - 프로그램의 일부로서 제공되는 사회사업서비스의 질적인 조사를 위한 조직체제를 마련하는 일
- 핵심서비스 5가지 외에 사회복지사들이 수행하는 기능은 13가지 정도가 제시
- 병원직원에 대한 사회복지케이스 자문
 - 사회·심리적 평가
 - 병원에 대한 지역사회자원체계의 관리
 - 지역의 사회복지기반에 대한 케이스 자문
 - 병원서비스에 대한 시민의 활용 촉진
 - 심각한 문제케이스의 발견
 - 병원에 대한 프로그램 자문
 - 지역사회의 보건계획수립의 참여
 - 병원 기획 업무 참여
 - 병원 시설의 환자들에 대한 편의와 융통성 검토
 - 지역사회에 대한 프로그램 자문

- 입원계획
- 기타
- 미국 병원 환자가 요구하는 사회복지서비스 중 두드러진 것
 - 경제적인 문제를 돕는 일
 - 가족이나 또는 부부간의 불화에 대한 서비스
 - 불구 또는 만성질환자의 치료계획에 가족원이나 친구를 돕는 일
 - 정신병 또는 정서장애환자가 있는 가족의 보호와 원조를 찾는 일
 - 퇴원 후 환자의 보호(care)를 위한 일을 돕는 일
 - 환자의 입원으로 인하여 야기된 가정문제를 해결토록 돕는 일
- 1979년 Colmery-O'neil V.A. Medical Center
- 사회복지사들이 타전문직이 기대하는 의료사회복지의 기능을 조사한 결과그 기대하는 순
 - 경제적 문제 즉, 복지에 관련하여 환자와 가족을 돕는 일
 - 의사가 요청할 때 환자의 사회력(Social History)을 조사 획득하는 일
 - 퇴원이나 지역사회에 정착 회복하는데 따른 문제를 돕는 일
 - 가족에게 의학적, 정신의학적 정보를 제공하는 일
 - 지역사회자원을 찾아내거나 의료팀을 대신하여 활용할 수 있는 기관에 의뢰하는 일
 - 의료팀의 집담회와 회의에 참여하는 일 등
- 이상에서 여러 견해에 따라 의료사회복지의 기능을 열거하였음
- 의료사회복지사가 의료기관에서 수행하는 가장 핵심적인 기능
 - 환자와 그 가족에 대한 질병의 성질, 그들의 가족적 상황 및 사회환경 등이 어떠한 상호관계를 맺고 있으며, 그들이 질병에 대하여 가지고 있는 심리적 상태 등을 잘 이해함
 - 그들과 밀접한 대인관계를 통하여 환자의 잠재적 능력과 질병간에 효과적인 조절을 꾀할 수 있도록 함
 - 필요시에는 그 지역사회가 지니고 있는 의료 및 사회복지자원으로 그들이 요구하는 욕구에 조정(Adjustment)하여 도움
 - 환자 및 그의 가족들의 정서적·사회적 제 문제와 그들의 능력을 의료팀(Medical Team)에게 이해시켜 그들로부터의 상호협동을 할 수 있도록 도움
 - 질병의 예방, 건강의 증진, 환자의 갱생지도 및 사회복지귀를 효과적으로 성취시키는 목적에 도달할 수 있도록 필요한 제 기능을 수행하는 데 있음

의료사회복지의 기능과 역할 2 / 7주차 2차시

1. 의료사회복지사의 역할

1) 의료사회복지사의 역할의 기본전제

■ 인간으로서 환자

- 인간은 도움을 요하는 처지에 있거나 환자이거나 또는 건강인을 막론하고 각기 독자적인 인성(Personality)을 소유하고 있음
- 동일한 질병을 가진 사람들에게 있어서도 그 병의 의미는 각기 다른 것
- 의료 장에서 이 병의 의미는 무엇일까, 이해하는 것
- 환자이기 이전에 인간의 존엄을 가진 인간, 사회구성원의 일부로 보아야 함

■ 전인적인 진료체계

- 인간은 신체적·정신적·사회적 존재
- 의료에 있어서 심신의 양대기제는 물론 사회적 요인 또한 중요한데, 왜냐하면 질병의 발생뿐만 아니라 진료과정에 끼치는 영향이 중대하기 때문
- 질병으로 인하여 환자나 그 가족의 심리적 반응이 나타나고 이것이 질병 진료에 좋게도 나쁘게도 영향을 줄 수 있으며, 심리적 요인에 의해서나 사회적 요인이 정신신체증(Psychosomatic Disease)으로 신체가 균형을 잃게 됨
 - 의료팀이란 환자의 진료에 있어서 부합적 요소를 전문영역별로 분담해서 보고 통합적으로 접근하는데 의의가 있음

■ 병에 대한 환자와 가족의 반응

- 인간은 일단 환자로서 진단이 되면 그 순간부터 심리적 반응이 다양하게 비현실적, 공상적 양상으로 나타날 수 있는데, 이는 함께 있는 가족 또한 마찬가지임
- 이러한 심리적 정서반응이 질병을 부인 하거나 부정적으로 보여서 의료팀의 진료를 저해하거나 방해하는 경우가 있음
- 이러한 성격은 병전 성격(Premorbid Personality)을 이해하지 않으면 접근하기 어려움
- 의료사회복지사는 환자나 그의 가족의 반응을 각기 성격에 따라 기술적으로 이해하고 또한 반응을 질병에 긍정적이고 바람직하게 수용하여 환자의 건강회복에 적극적으로 참여하도록 지지해야 함

■ 의료관의 변천

- 질병의 사회성과 의료의 사회화 등의 변화에 따른 의료사회복지사의 활동이 의료기관의 활동을 보건사업, 즉 예방사업, 모자보건사업, 지역사회 보건위생운동에 참여하는 것을 전제로 하여야 함

2) 의료사회복지사의 역할에 대한 견해

■ 존홉킨스 병원의 메이어(Dr. Adolph Meyer)

- 환자의 병원생활 동안 환자에 대한 제반 사실을 알아내고 건강한 상태로 퇴원할 수 있도록 준비시켜야 함
- 퇴원 후 가정에서 계속 건강한 상태로 퇴원할 수 있도록 준비시켜, 퇴원 후 가정에서 계속 건강을 유지시켜야 하는 등 일을 위하여 계속적으로 의사와 접촉하는 것이 의료사회복지사의 역할이라 하였음

■ 리차드슨(Dr Henry Richardson)

- 환자의 외적, 내적 압력에 경감에 있으며 질병의 예방과 건강을 추진하기 위하여 의료를 사용하는 환자 자신의 능력을 최대한 활용할 수 있도록 돕는 것

■ 마르고리스(Dr. H. M. Margolis)

- 환자에게 종합적인 도움을 주기 위하여 의사는 전문적인 사고와 계획을 사회사업가와 상의해야 하고, 환자가 의료적 진단, 치료과정에 안심하고 참여할 수 있도록 돕는 것
- 환자의 사회적 환경에 대한 객관적인 사실을 알아내는 일
- 질병과 관계된 환자의 사회적 욕구를 충족시키기 위하여 지역사회자원을 활용하는 일 등을 위해서 의료사회복지사를 활용해야 함

■ 콕케릴(Mrs. Eleanor E. Cockerll)

- 의료사회복지사는 질환을 만들어 낸 사회적 요인과 질환으로 인하여 발생한 환자의 사회적 문제, 그리고 환자의 치료에 장애를 주는 제반 요인에 제1차적 관심을 두어야 하며, 동시에 2차적으로는 처방된 의학적 치료의 방법을 환자가 보다 잘 받아들이도록 돕는 일

3) 의료사회복지사의 전문적 역할

■ 심리사회적 치료자의 역할

- 질환으로 야기되는 심리적인 문제는 바람직한 의료서비스를 받는데 장애가 되기 쉬움
- 환자가 안정감과 자신감 그리고 용기를 갖도록 지지적인 개별사회사업 치료 역할
- 재활환자의 경우 자신의 과소평가로 인한 문제 등을 집단 사회사업의 활동을 통하여 성취감과 자신감을 갖게 함
- 참여의욕을 증진시켜 당면문제를 해결하거나 완화되도록 돕는 치료적인 역할을 말함

■ 서비스 조정자의 역할

- 치료에 참여하는 여러 다른 전문요원과 함께 각기 다른 전문적인 진단과 치료 및 서비스계획을 수립함에 있어서 심리사회적, 경제적인 정보를 의료팀에 제공
- 환자의 전인적인 이해를 증진시키고 의료팀의 종합적이고도 통합적인 서비스를 위한 협력과 조정을 담당
- 중요한 것은 우리나라와 같이 의료보장제도가 미비한 경우는 환자의 진료비 문제가 중대한 문제가 아닐 수 없음
- 진료비문제를 위한 병원 내적인 조정절차, 또는 외부자원의 활용을 위한 조정이 중요한 과제

■ 자원동원가

- 의료적 치료에 있어서나 재활(의료적, 심리적, 사회적) 과정에 있어서 인적·물적·제도적·병적인 자원을 필요로 하고 있음
- 병원내의 의료적인 제 사회자원의 활용을 극대화하기 위해 자원조직화를 비롯하여 환자의 병 회복과 재활 및 사회복귀를 위한 지역사회의 공·사적인 여러 사회자원을 조직하고 동원하는 것이 타전문가와 다른 독특한 역할

■ 재활치료와 교정자의 역할

- 심리사회적 측면의 조사연구와 평가, 치료, 훈련, 지도 및 서비스의 계획수립에 협력하여 생활지도적, 심리사회적, 직업적 등의 종합적인 재활과정에 참여하여 치료나 교정을 함
- 장애로 생기거나 재활과정에서 파생될 수 있는 심리사회적인 문제나 행동반응
- 자기중심적, 비사회적·퇴행적·자폐적·정서적 불안 등을 치료하거나 교정및 생활지도를 하여 사회기능 회복이나 잠재기능을 개발하도록 도움

4) 지원대상에 따른 역할

■ 의사에 대한 역할

- 환자를 치료하는데 필요한 사회적, 경제적 배경과 가족배경을 조사하고 환자의 사생활에 대한 정보를 수집하여 의사에게 알려줌
- 의사로 하여금 환자의 전인적으로 이해하도록 조력하는 역할을 함
- 환자의 사회환경적 여건에 맞게 치료계획을 세워 팀워크 하는데 필요로 하는 일을 상호조정

■ 환자의 가족원들에 대한 역할

- 환자의 욕구를 가족원들이 이해할 수 있게 하며 환자의 가정복귀계획을 받아들이고 그들의 책임을 이행할 수 있도록 도움

■ 환자에 대한 역할

- 환자의 정서적, 개인적 문제를 다루는 데 있어서 그를 돕기 위하여 적합한 상담요법의 형태로써 케이스워크 서비스를 제공함
- 처방된 치료나 혹은 질병으로 인해 환자를 제한 또는 구속하는 것을 환자가 받아들일 수 있도록 도움
- 환자의 잠재적인 능력을 최대로 개발하기 위해 지역사회자원활용, 또는 사회적 환경에 적응케 하는 관점에서 미래계획을 도움

■ 퇴원계획에 대한 역할

- 퇴원 후 갈 곳이 적당하지 않은 환자를 위해 지역사회조직기관과 협력하여 계획을 수립함에 있어서 의사, 환자 그리고 그의 가족들과 함께 일함
- 퇴원 후 필요한 준비를 하도록 돕고 필요한 의학정보를 제공함
- 3차 진료기관에서 수술이나 치료 후에 주거지의 2차 진료 기관에서 재활 훈련을 의뢰하는 등의 퇴원 계획을 마련함

■ 퇴원 후 사후지도에 대한 역할

- 퇴원 후 가정에서 어떻게 적응하고 있는지, 정상적인 사회인으로 기능하고 있는지를 살펴보고, 적절한 서비스를 제공함
- 병원생활에서 지역사회로 그 환경이 바뀐 환자의 회복 상태와 욕구를 평가함

■ 교육 및 훈련에 관한 역할

- 전공하는 사회복지학과 학생의 실습지도와 의과대학생과 간호대학생의 실습지도 또는 임상강의를 하며 새로 들어온 직원의 교육과 의료사회복지가 자체훈련 및 재교육의 역할을 담당함

■ 보다 구체적이고 전문적인 역할을 수행하는 것에는 다음과 같은 내용이 있음

- 환자의 육체적·심리적·정서적 및 사회적 욕구를 이해하며 환자를 하나의 전체적 인간으로 대할 수 있도록 의료팀을 이해시킴
- 의학적 지식을 기반으로 하여 병원이 혼자에게 미치는 신체적·사회적·경제적 및 생활면의 배경을 전문적인 기술로 이해시킴
- 환자가 나타내는 특정한 문제에 있어서 전인적인 이해를 하여 협동적인 접근책을 강구함
- 환자와 가족 사이에 일어나는 갈등과 불안을 해소시켜 주고 각자의 위치를 지각시킴
- 여러 가지 해결방안에 대한 현명한 자기결정을 환자 및 그 가족이 하게끔 하고 그 결정을 이해하도록 도와줌
- 환자와 의사와의 중개적 역할자로서 환자가 병을 이해하고 의사의 지시를 잘 따르게 함으로써 치료의 가능성과 회복에 대한 욕구를 갖도록 함
- 환자와 치료 팀의 중개 역할로서 경제적 자원을 활용, 원조를 줄 수 있도록 노력함
- 치료 완쾌 후 그 질병이 재발되지 않도록 사후지도에 관심을 가짐
- 치료 후 환자의 재활을 위하여 그도 가정과 사회의 한 일원임을 인식시키고 갱생지도를 통하여 사회복귀를 도움
- 가능한 한 지역사회의 인적, 물적 자원에 대한 활용을 할 수 있어야 함
- 이상의 보건의료사회복지의 기능과 역할은 질병과 보건에 대한 심리사회적 접근을 통한 치료 그리고 건강 향상에 있음

■ 개별화된 심리사회적 치료계획을 전개하기 전에 개인의 신체적 질환의 사정에서부터 질병에 대한 적응과 극복을 위한 개인생활에 있어서 개인적, 가족적, 사회적, 그리고 경제적인 면까지 광범하게 사정해야 하며, 이와 같은 과업에는

- 환자의 독특한 개인력
- 개인의 강점과 약점
- 사회 및 환경적 여건
- 환자 자신이 찾는 의료체계
- 경제적 자원
- 질환문제 대한 환자자신의 반응
- 질병으로 인한 장·단기적인 생활양식의 변화 등에 대한 분석이 요구됨

의료사회복지의 실천과정 1 / 9주차 1차시

1. 의료사회복지사의 전문직화 방안

1) 의료사회복지사의 전문직 요건

■ 전문직 요건

- 의료사회복지사들이 의료복지서비스를 실천하는 데에는 필연적으로 전문가로서 자질이 갖추어져야 함
- 전문적인 서비스를 그 활동으로 하는 모든 전문직은 다음과 같은 요건이 요구됨
 - 전문직의 실천행동에 가장 중요한 가치가 명백해야 함
 - ☞ 의료사회사업에는 사회사업의 일반가치, 보건 및 의료분야의 특수한 가치가 요청됨
 - 지식체계
 - ☞ 의료사회사업의 일반지식, 보건 및 의료, 질병에 관한 지식, 사회생태학, 스트레스, 성격이론, 개인, 가족, 집단발달이론, 의료사회복지실천에 가장 효과적인 지식 기반으로 함
 - 전문적인 교육을 통하여 갖추어진 가치와 지식을 바탕으로 임상 경험을 통해 습득되는 기술(Art)임
 - ☞ 의료사회복지사는 일차적인 대상문제인 질병으로 파생되는 심리사회적, 경제적, 사회복귀적인 재활 등의 문제를 다루고 도울 수 있는 전문적인 기술, 임상의 다원적 접근방법을 획득케 하는 교육과 수련이 요망됨
 - ☞ 이런 기술을 활용하는 기본적인 철학이나 신념이 확립되어지기를 요구하고 있음
- 현재 의료분야에서 전문적 기능과 역할을 수행하는 데는 이러한 면에서 어려움이 많음
 - 의료기관에서 다른 전문 의료진과 같이 전문가의 교육과 훈련에서 획득되는 자격기준의 문제
 - 사회복지사 자격의 제도적 문제
 - 대학과정에서도 의료사회복지나 정신보건사회복지 교과과정을 두고 교육하는 대학이 점차 확대되고 있으나 제한되고 있고, 그나마도 실습을 통한 이론과 실체가 병행되지 않고 있어서 전문적인 교육이 되지 않고 있음
- 해결방안
 - 전문적인 지식과 기술향상을 위한 교육과 수련 필요
- 의료사회복지사가 의료·보건 영역에서 전문직업인으로서의 자질은 다음과 같은 면에서 훈련 및 교육되어 통합체로서 주체성이 확립되어야 함
 - 과학성(지식+객관성)
 - ☞ 의학, 약학, 간호학과 같이 학문적인 이론이 전문직업인으로 발전할 수 있는 지식체계로서 사회복지의 전문지식, 행동과학(생물과학, 정신과학, 사회과학)등의 과학적인 지식체계

- 기술성(지식+수련+감수성)
 - ☞ 지식을 기반으로 하는 수련 즉, 임상경험을 통하여 기술의 완전한 소화력과 그 능숙성을 뜻함
- 인격성(인격의 성숙)
 - ☞ 다른 사람에 대한 사회적 관심, 대상자의 행동, 정서에의 관여, 자기의 인격상, 장·단점, 반응, 자기통제 그리고 자기문제 해결능력, 지식과 기술을 활용할 수 있는 건강한 성장을 통해 완성된 인격 등을 의미함

2) 의료사회복지사의 전문직화 방법

■ 전문직화 방안

- 의료사회복지사의 자질향상에 있음
 - 현재 병원이나 의료시설에서 실천하고 있는 의료사회복지사가 자신들이 의료사회복지의 기능이나 의료사회복지사의 역할에 긍지와 확고한 주체성을 갖고, 전문적 기술을 연마하는 현임훈련(In-service Training)을 강화하고 필수화시켜야 함(습득과 훈련 강화)
- 서비스에 대한 반대급부(Fee for Service) 실현을 위한 노력임
 - 의료수가 기준에서 사회사업가의 서비스에 대하여는 정신보건사회사업과 재활의료영역활동, 당뇨교육, 장기이식순수성평가에서만 의료수가를 청구할 수 있게 되어 있고, 병원 내 다른 부서에서의 활동에는 적용되지 않고 있음
예) 병원에서의 사회복지활동은 환자의 질병치료에 장애가 되는 심리사회적인 문제를 해결하여 환자의 치료에 도움을 줌으로 의료행위의 일부분을 담당하는 것임
 - 문제점
 - ☞ 재활 및 수술환자, 나아가 정신신체증 환자들을 실제로 돕고 있는데도 신경정신과 소속이 아니면 서비스 수가를 청구할 수 없음
 - 과제
 - ☞ 근원적으로 전문적인 지식과 기술을 다하여 사회복지서비스를 주는 일에 의료보험 수가가 산정되지 않고 있다는 점은 시정되어야 할 중대한 과제
 - 대책
 - ☞ 의료사회복지사들의 다양한 기능 및 역할 가운데에 심리사회적 문제와 같이 심인적 요인에 대한 고도의 기술을 요하는 직무에 대해서는 타 전문적인 서비스보다 고가로 청구 할 수 있게 되어야 함
 - ☞ 의료사회복지사의 서비스 질이 향상되면, 이것이 질병 치료 기간을 단축할 수 있을 것이며, 병원경영면이나 의료시설의 유용한 활용에도 좋은 영향을 줄 수 있을 것
- 자격규정과 임상수련을 할 수 있게 제도 보완
- 서비스 질 향상과 의무기록의 표준화와 전산화

2. 의료사회복지의 가치

1) 사회보건서비스의 가치 지침

■ 보혜 등은 사회보건서비스를 위한 일련의 가치 지침제시

- 기본적인 시민 욕구와 안전하고 적절한 사회기능을 보장하는 광범위한 조사가 이루어져야 함
- 의료의 수요·공급자 상호의 참여가 있어야 함
- 수요자가 의료의 선택권으로서 선택할 수 있는 요인
- 유용하고 광범한 보호는 적절한 거리와 시간, 지역사회의 욕구범위에 알맞게 보증
- 인적, 물적 보건차원은 시민의 욕구를 기초로 하여 지역적 연락망 재조직
- 프로그램예산에는 예측적인 요인이 있어야 함
- 의사는 1차 진료를, 2, 3차는 타전문직 등의 전문가가 인력 감독, 지도해야 함
- 예방활동이나 보건교육이 우선적
- 사회보건 체계 내에서 기능하도록 교육되어야 함
- 교육의 목표는 생리, 사회, 심리적인 보호, 건강유지와 예방의 개념에 강조
- 교육은 전문직상호간의 평가와 공동연구 등의 학습
- 조사는 기초과학에 제한될 수 없으나 임상과 지역사회보건서비스에는 필요함

2) 의료사회복지의 가치

■ 가치 차원

- 치료체계에 영향을 줌
 - 첫째, 실천가의 위치에 관한 것
 - 둘째, 대상자인 클라이언트에 관한 것
 - 셋째, 특별한 관계가 있는 위치 등의 세 차원임
 - 클라이언트 자신이 표현한 소원
 - 클라이언트가 필요로 하는 것이나 그에게 유용한 것에 대한 사회복지사의 관심
 - 사회사업가와 같이 클라이언트를 보는 사람들 등의 관심 있는 보호임
- 가치란 모든 전문적인 실천 행동의 필수조건
- 사회복지사는 전문직으로 가치를 가지고 있음
 - 사회복지 전문직으로서의 가치
 - ☞ 개인의 존엄과 가치
 - ☞ 개인이 가진 잠재능력 발휘하도록 도움
 - ☞ 사회복지실체와 의료서비스의 조직적인 체계가 자기결정을 최대한 발휘, 향상시킴
 - 의료사회복지의 가치
 - ☞ 전인적 치료가 진정한 것
 - ☞ 현재의 것을 사정하는 것이 바람직
 - ☞ 생활의 질을 향상시키는데 노력
 - ☞ 스트레스에 처했을 때 필요한 원조와 처치의 개념이 기술체계보다 더 중요

- ☞ 모든 새로운 체계는 질병에 초점을 두는 것보다 사회적 건강이 강조되어야 함.
- 예컨대, 시민을 건강하게 하거나 건강유지와 질병예방을 위한 교육 등
- 의료사회복지사 윤리강령(1961년 일본 의료사회복지협회에서 제정)
 - ☞ 개인의 행복증진과 사회복지향상에 목적을 둔 활동을 함
 - ☞ 본인의사 존중, 비밀보장, 무차별평등의 원칙
 - ☞ 대상자에 대한 전문적인 원조관계를 조성하고 사적으로 이용하지 않음
 - ☞ 의료사회사업의 의의와 기능을 타전문직에게 이해시켜 목적달성 노력
 - ☞ 전문직업적 입장에서 사회활동, 사회자원의 활용 및 개발, 사회보장 달성토록 노력

3) 한국의 의료윤리

■ 의료윤리

- 의료윤리에 대한 관심은 사회적, 의료적 변천에 기인한 것
 - 사회 전반적으로 도덕적 양심의 각성에 대한 관심이 고조
 - 의료공급에 정부 투자와 간섭이 증가함에 따라 비의료인들이 의료정책결정에 참여활발, 의료욕구충족의 필요가 사회윤리의 한 부분으로 부각됨
 - 의료기술의 발전으로 여러 문제와 개인 능력간 격차 확대 등의 문제 발생
 - 의료보험제도의 실시로 의료의 수요, 공급간의 격차, 보험수가간 격차 등 문제 야기
- 의료윤리의 과제
 - 생명과 의료윤리 문제
 - 의료기술과 의료윤리 문제
 - 진료행위와 환자의 인격에 대한 문제
 - ☞ 대한의학협의회 의사윤리 10가지
 - ☞ 병원윤리강령 10가지
 - ☞ 환자의 권리선언 10가지
 - ☞ 환자의 권리장전 10가지

4) 의료사회복지의 윤리

■ 환자의 권리

- 개인의 존엄성 인정과 보호받을 권리
- 개인의 사생활과 자유를 제공받을 권리
- 안전에 대한 확실한 기대를 요구할 권리
- 진료진들로부터 진단치료, 예후 등에 관한 정보를 획득할 권리
- 환자는 본인을 치료하는 의료진들의 직업, 지위, 신원을 알 권리
- 자신의 건강보호, 진료에 수반되는 의사결정에 참여할 권리
- 자신의 능력에 상관없이 질병치료를 처우를 차별 없이 받을 권리

■ 환자의 역할 개념

- 병이란 사회적 기능 작용이라는 관점에서 정의할 수 있는 사회적 실체(인간은 사회적 동물임)

■ 파킨스의 환자역할 개념의 이론적 전제

- 건강의 문제는 사회체계의 기능적 요건에 포함
- 병과 건강은 문화의 한 부분으로 이루고 있으며 사회통제가 필요한 부분
- 보건의료관계에 관한 사회의 역할은 문화적 유형화된 부분의 하나이며 학습화된 행동의 연쇄

■ 병으로 인하여 발생하는 행동의 기대특성

- 정상적인 역할의무로부터 제외 또는 면제
- 환자는 자신의 상태(병)에 대한 책임이 없음
- 건강이 회복되도록 동기가 주어져야 함
- 기술적으로 유능한 자의 도움, 특히 의사에게 협조할 의무 있음
 - 이와 같이 병원과 환자 상호간의 관계에 대한 공동임무관계로 이루어질 때 바람직한 치료가 이행되는 것

■ 의료사회복의 윤리 - 캘리포니아 임상사회복지윤리강령위원회

- 서비스를 받는 집단이나 개인의 욕구 충족
- 개인의 사회적 기능과 정신건강 증진, 개념 고무
- 제공된 서비스의 질에 대한 책임
- 특별히 자아 인식에 대한 책임을 짐으로써 개인적인 욕구가 전문적 관계를 방해하는 것을 막도록 함
- 전문적 지식과 기술을 습득하기 위해 계속해서 노력
- 자격증의 법적 테두리 내에서 일해야 함
- 전문적 자질과 소속협회를 바르게 대표해야 함
- 치료적 관계의 의사소통과정에서 얻어진 모든 자료 보관
- 광고를 통해서 환자를 유혹하지 말아야 함
- 그가 속해있는 기관의 규정과 규칙을 지킬 책임이 있으며 이러한 것의 개선을 위해서 적절한 절차를 사용
- 임상사회복지사의 발언은 기관의 대표로서 공식적인 입장인지 아니면 개인으로서의 입장인지를 분명히 해야 함

의료사회복지의 실천과정 2 / 9주차 2차시

1. 의료사회복지사의 지식체계

1) 기초지식으로서 일반체계이론

■ 의료사회복지가 사회복지실천에서 선택해야 할 기준

- 사회의 요구를 수행하기 위하여 사회구조와 문화가 개인의 자아, 생활구조에 반영되어 왔음
 - 개인의 삶에 대한 대처방식은 모든 사람에게 영향을 끼친다는 사실을 인식
- 인간사회의 발달에서 상이성의 중요성을 지지해 주는 이론을 필요로 함
- 성장과 변화에 대한 인간의 잠재능력에 낙관적인 견해를 가진 기초이론
- 성장을 향한 외형적인 추구와 인간의 상호작용, 상호교류에 의해 발생하는 개인과 집단내부의 변화의 본질에 대해서도 다루어야 함
- 인간행동의 모든 이론들은 동기(Motivation)의 개념을 추구
- 인간의 기능에 대한 이론은 인간의 역기능의 원인에 대해서도 가정

■ 개념적 준거 틀로서의 체계모델

- 체계
 - 상호의존적이며 상호작용하는 부분들로 구성된 전체, 즉 부분들 간에 관계 맺는 일련의 단위들
 - 인과적인 관계에서 직, 간접적으로 관련된 재구성 요소의 복합체
- 개념적 도구로서 체계이론을 고려함에 있어 사회복지사는 다양한 하위체계, 체계수준에 관련하여 활동함에 있어 세가지 중요한 결정을 내려야 함
 - 클라이언트의 체계 확인
 - 변화되어야 할 체계, 체계요소, 하위체계 확인
 - 변화노력에 포함되어야 할 체계의 요소, 혹은 하위체계의 결정, 실천가의
 - 적어도 네 가지 유형의 체계(혹은 하위체계)를 포함하는 것으로 볼 수 있음
 - ☞ 변화매개체계, 클라이언트체계, 표적체계, 활동체계

■ 경계(Boundaries)

- 정의 : 선정된 변수들을 둘러싼 폐쇄된 둘레로서 그것을 넘어서는 에너지가 의사소통의 교환이 적음을 의미
- 개방체계 : 반투과성 경계를 갖고 있는데 “개방성” 혹은 “폐쇄성” 체계에 따라 달라짐
- 사회복지사들은 두 번째 수준의 경계에 대해 관심을 가져야 함

■ 긴장(Tension)

- 인간, 조직에서의 긴장
 - 가끔 일어나는 병리적인 혹은 혼란을 가져오는 요소
- 체계이론에서의 긴장
 - 파과적, 건설적으로 나타나는 것 인정
 - 복잡한 적응체계의 특성, 필수적인 것으로 간주함

■ 피드백과 목적성을 지닌 체계

- 피드백 의미
 - 정보의 투입에 반응하는 행동을 보임
 - 새로운 정보에 자신의 행동변화를 포함시킴
 - ☞ 다음의 행동을 수정하는 의사소통의 조직망
 - ☞ 체계와 환경간의 상호작용
- 피드백 통제체계
 - 목표 지향적
- 소극적 피드백
 - 체계가 목적달성을 어렵게 하는 행동을 정보 전달, 행동수정하게 함
- 적극적 피드백
 - 체계가 목적과 관련하여 올바르게 행동
 - 같은 행동 더욱 요청
 - 사회복지사가 체계의 목표를 아는 것이 중요함
 - 클라이언트체계의 이해를 위하여 중요한 것은 체계가 문제를 어떻게 해결하기 원하며 그 해결책이 체계의 생활 목표 속에서 차지하는 위치를 이해하는 것임

■ 변화와 안정성

- 체계들은 끊임없이 변화와 운동의 과정 속에 있음
- 운동이 유지되도록 내적 질서 향상 외적 자극의 배열과 선정 요구
- 사회복지사의 힘을 체계의 힘과 결합하는 방법을 발견하는데 관심

■ 체계이론의 내재적 가치

- 자료의 수집과 배열
- 다양한 클라이언트에게 똑같이 적용
- 사회문제와 전반적 요소 적용에 필요한 준거를 제공
- 체계들간의 상호교육
- 능동적인 성격(퍼스널리티) 체계
- 원인과 변화의 가능성에 대한 견해 근본적으로 변화시킴
- 자기결정에 대한 관심과 클라이언트 목적에 전문적인 피드백 관련
- 모든 사람에 대한 상호교환 기회 제공, 유지
- 폐쇄체계(고립을 지향하거나 초래하는 사람)에 더욱 많은 관심

- 변화와 긴장, 갈등체계에 더욱 관심 가져야 함
- 체계의 경계개념은 관찰하는 새로운 방법을 제공
- 체계의 일부 변화가 전체에 큰 영양미침을 인정
 - 상호교류 개입의 영향을 인식
- 기관을 사회체계로 사회복지사와 클라인언트를 동일한 상호교류의 장내에 둠
- 사회복지사는 하나의 사회체계이며 사회체계 조직망의 구성요소로 관여되고 있음

2) 기초지식으로서 역할이론

■ 역할의 보완성과 상호성

- 역할의 위치, 지위가 짝을 이룸(예: 부모와 자녀, 아내와 남편 등)
- 역할 파트너 간에 기대의 상호성
- 기대되는 역할 행동의 유형은 지속적인 상태 유지하고자 하는 사회체계의 필요성

■ 역할 세트 및 역할군의 개념

- 특정한 시기에 어떤 한 사람이 갖게 되는 일련의 역할들(Merton)

■ 역할 갈등

- 역할 수행상 어려움을 겪는 상황

■ 사회복지사에게 역할이론의 중요성

- 체계내의 지위와 관련하여 어떤 행동이 제시
- 각 역할은 우리 자신의 기대와 다른 사람의 기대와 능력을 포함
- 역할기대의 개념은 사회적 규범이 있음을 시사
- 사람들이 그들의 역할을 어떻게 수행하는지에 대하여 정서적으로 부과된 가치 판단이 있음
- 사회적 기능은 인간체계에 의하여 수행되는 역할들의 총체로 간주
- 역할, 역할기능, 역할기대 및 역할 상호작용의 개념은 문제 상황 사정을 위하여 지식기초 증진 위해 활용

3) 기초지식으로서 자아심리학

■ 정신분석적 개념

- 인간을 기본적인 충동과 본능으로 구성된 역동적인 에너지 체계로 생각
- 충동과 본능은 환경과 상호작용으로 발달단계를 통하여 성격조직, 발전시킴
- 의식과 무의식세계 존재

■ 자아심리학의 개념

- 에릭슨(Erikson)
 - 초기경험이 중요하지만 성격체계는 전 생애를 통하여 내적 생활경험 및 외적 경험과 상호작용하도록 개방되어 있다고 주장
- 자아심리학자들
 - 성격의 발달이 개인에 의하여 능동적으로 추구되는 환경과의 상호작용의 결과로 간주

■ 능력과 통제

- 하이트(Robert White)
 - 세계를 탐색하고 새로운 경험과 자극을 받아 들이려는 요구에 의하여 환경과 능동적으로 상호작용을 하는 동기를 갖는다는 생각 동기의 힘을 통제를 향한 추진력이라고 봄

■ 동기

- 자아, 능력 및 통제에 관한 개념들로부터 동기 발전
- 인간의 내적 반응과 외부사건에 대한 지배 혹은 통제의 느낌은 인간행동을 동기화하는데 중요한 힘이 됨

■ 사회복지 지식체계에 자아심리학의 기여

- 자아(ego)의 개념은 현재의 생활경험을 지향하는 원조노력에 중요성을 부여함
- 개방체계로서 성격의 개념은 환경과의 상호교류로부터 나오는 일상적인 투입의 중요성에 큰 비중을 둠
- 개인의 능력과 통제의 개념은 사회사업에 인간의 성장, 변화의 가능성에 대한 낙관적인 견해 제공, 사회복지사들이 다른 사회체계와 환경의 조직망으로부터 나오는 투입에 지속적으로 관심 가져야 함
- 자아심리학 개념은 개인이 자신의 운명에 능동적이고 의식적으로 참여함
- 능력과 통제의 개념은 자기 운명의 능동적인 경험, 통제 추구하는 인간 견해를 지지
- '동기'에 대한 생각은 사회사업가에게 클라이언트 체계와 목표와 자기결정의 가치의 중요성을 상기시킴
- 희망의 중요성은 무관심의 의미에 관해 새로운 견해를 사회복지사들에게 제공하며 의존성에 관한 다른 개념들에게 도전적 줌

4) 일반사회복지사의 관점

- 적용 다양한 모델과 이론, 기법을 자유롭게 활용하면서 모든 클라이언트의 상황 접근 원조과정 초기과정에 적절 - 문제의 정의, 사정에 어떤 접근법을 사용할지 결정
사회복지실천은 클라이언트의 유형, 활용방법, 개입의 수준, 사회복지사의 주요 역할

- 기능수행상의 문제 가능수행에서 발생하는 문제에 영향을 미치는 요인들이 다양하다는 것에 초점

- 일반사회복지사는 다음과 같은 클라이언트의 다양한 체계와 활동하도록 준비

- 한 사람과의 일대일 대면 면접
- 전체가족
- 치료 혹은 지지집단과 같은 공식집단
- 위원회 혹은 과업집단들
- 기관, 기관망 같은 공식적 조직
- 입법자, 정책결정자들
- 일반 사회복지사는 클라이언트의 독특한 상황과 관심, 지역사회의 특성들에 자신의 접근방법을 적용하기를 원함

■ 일반사회복지사의 특성

- 슈이츠(Schatz Jenkins & Sheafor, 1990)등의 설명

- 인간문제
 - ☞ 생활환경과 사회적 조건의 상호 관련성 강조하는 다차원적 이론적 지향
- 다양한 배경
 - ☞ 지역 문제들간의 교환 가능한 지식, 가치, 기술기반
- 특정한 이론 혹은 개입 접근에 제한 받지 않는 사정
- 사회복지사의 역할과 전략의 선택
 - ☞ 클라이언트 문제, 목적, 상황, 변화의 표적 체계들의 규모에 기초함

1. 의료사회복지의 기술

1) 의료사회복지기술의 전제조건

- 사회복지서비스 제공에 요구되는 기술
 - 환자와 그의 가족에 대한 심리사회적 평가
 - 가족치료에의 숙련
 - 다양한 정신병유형에 따른 개별적 접근 기술
 - 집단치료에 대한 기술
 - 환자가 퇴원 후 있을 곳과 가족과의 퇴원 계획에 관한 기술
- 의료사회복지기술을 필요로 하는 전제조건
 - 기술을 발휘하게 되는 출발점은 복지의 실태 및 현황을 파악하는 데서부터 비롯됨
 - 기술을 의료복지문제의 해결수단으로 인식하는 일
 - 기술과 제도와와의 관련성을 명확히 인식하는 일
 - 기술을 뒷받침할 수 있는 사상이 있음
- 전제조건을 중심으로 하는 의료사회복지의 기술
 - 개인과 집단에 적용하는 기술
 - 관계직종이나 지역사회집단과의 연락에 관련되는 기술
 - 사회조사의 기술
 - 지역사회에 적용하는 기술
- 기술을 뒷받침할 수 있는 지식은 다음과 같음
 - 의료사회복지문제에 관한 과학적인 지식
 - 기본적 인권에 관한 지식
 - 사회복지, 사회보장제도 및 서비스에 관한 체계적인 지식과 활용에 관한 지식
 - 신체와 정신의 상호관계에 관한 과학적인 지식
 - 인격의 성장, 발달에 관한 교육학적 지식

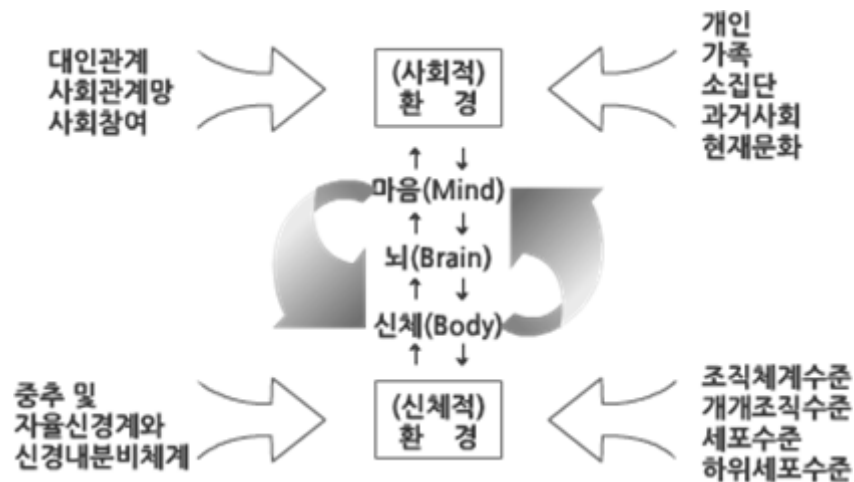
2) 의료사회복지의 적응과제와 기술

- 무스와 트슈는 환자를 다루는 적응과제를 제안하고 이 과제를 수행하는데 필요한 기술 제시
 - 인간행동발달에 관한 지식을 갖고 인간행동을 역동학적으로 이해하는 능력
 - 인간관계에 대한 이해와 사회적 문제를 해결하도록 돕는 능력
 - 면접 기술
 - 사실과 감정을 나타낼 수 있는 능력
 - 건전한 사회적 이해에 입각하여 재치 있게 판단하고, 성격을 바로 파악할 줄 아는 능력
 - 외교술과 재치(Diplomacy and Tact)
 - 타인들과 그들의 문제에 대한 민감성

- 사회적, 개인적 문제에 동정적이면서 현실적 접근 할 수 있는 능력
- 인간생활 및 인간의 권위에 대한 존경심을 가지는 것
- 지역사회와 자원에 대한 지식

■ 가족역동과 질병관계

- 가족역동과 질병의 원인
 - 정상적인 가정의 가족구성원이 병에 걸릴 확률이 적으나 가족이 불안정하고 능력이 부족한 경우는 병에 걸릴 확률이 높아짐
- 가족의 역동과 진단
 - 가족의 역동성이 좋을수록 질병이 생기면 의사를 빨리 찾아오고 역기능적인 가족은 병증상을 무시하거나 적은 신체적 불편도 질병으로 오인 정신신체적 문제 야기
- 가족역동과 질병의 과정
 - 가족역동성에 따라 치료와 가족의지지로 빨리 회복하거나 그렇지 못한 경우 회복 늦어짐
- 가족역동과 증상의 지속내지 병자역할의 관계
 - 역동적인 가족 후유증 없으나 역동성 문제 가족은 증상이 계속됨
- 가족역동과 회복기의 적응 및 사회복귀의 영향
 - 가족역동에 따라 회복기간이 단축되거나 연장됨



[그림 11] 생리- 심리-사회적 면(Bio-Pscho- Social Field)

■ 가족체계의 의료자원

- 경제적 지원-가장 기본적이고 필수적인 자원
- 대변자 및 조정자 역할
- 의학적 처치
- 애정 및 정서적 지원
- 정보 및 교육
- 치료에 적합한 의식주 등의 생활환경

■ 지역사회 의료자원

- 개인차원 : 환자의 가족, 친구, 친척
- 기관차원 : 재정 및 사회적 서비스 기관, 시·군립병원, 보건소
- 민간차원 : 심장재단, 암환자 후원회, 성인병 예방협회, 종교단체의 자선조직 기관, 자조집단 조직, 그 외 각종 봉사기관

■ 전문적 행동체계로서 의료사회복지의 기본 가치, 전문적 지식, 경험을 통한 기술 고찰

- 의료사회복지의 기본적 가치는 인간의 존엄과 가치, 잠재력 개발, 자기결정권, 전인적 건강지향, 사회적 건강에 대한 참여에 초점을 두어 환자의 전인적 이해와 권리보장, 환자와 의료사회복지사와의 관계성, 윤리나 가치체계 마련해야 함
- 지식체계로서 전문적 행동체계의 핵심적인 요소
- 의료사회복지의 독특한 기술로서 전문지식과 기본적 가치를 임상현장에서 경험함으로써 감수성이 수련되고 자각을 통한 사회복지사의 자질을 갖게 하는 것
- 의료사회복지의 전문화와 활성화를 위해서는 전문적 행동체계를 확립
- 의료사회복지사의 자질을 향상시켜 서비스 질이 향상
- 정당한 대가를 청구할 수 있는 전문가로서의 자격이나 권위를 인정받는 질적, 양적, 제도적 체계가 이루어지도록 노력

1. 의료사회복지의 실천모형

1) 전문사회복지의 실천

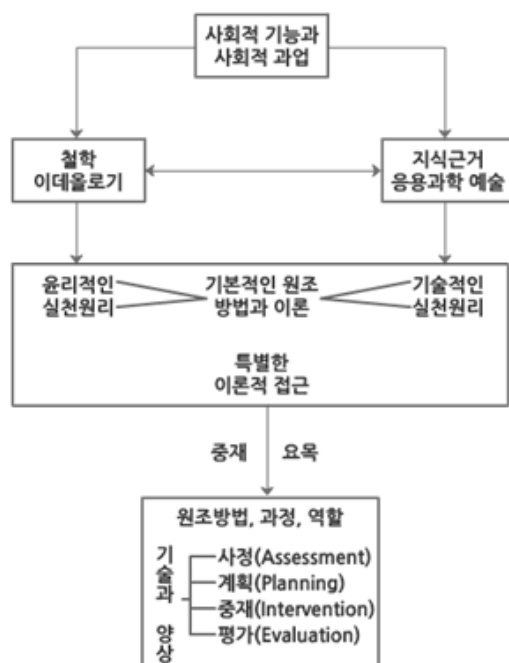
■ 의료사회복지의 목적

- 사회적·경제적 부적응의 원인과 결과에 대한 그 전문적 지식을 국가의 복지사업에 투입함
 - 건전한 사회정책과 진보적인 사회복지프로그램의 발전에 공헌
- 이 두 목적을 동시에 성취할 수 있음
 - 환자에게 가장 적합한 건강의 목표를 향하여 의료진과 함께 일함
 - ☞ 의료적 치료를 조정·보강하여 질병의 원인이 될 수도 있음
 - 진료과정에 장애가 될 수도 있는 환자 및 그 가족의 사회적·정서적·경제적 문제 등 인간의 내·외적인 문제를 해결하도록 도움
 - 퇴원 후 환자가 그의 가정이나 지역사회에 복귀
 - ☞ 적절하게 정상적인 사회기능을 발휘하도록 도움

■ 사회복지실천에는 가치, 목적, 승인, 지식, 그리고 방법 등으로 구성된 체계를 전제함

■ 기본적인 실천 이론의 요소 두 가지

- 지식의 기초로서 이해
- 행동하는 기술적인 방법 또는 기술적 실천 원리



[그림 12] 전문사회복지실천모델

2) 의료사회복지의 실천

- 의료사회복지의 실천모델은 전문사회복지의 실천모델을 근거로 함
 - 목적과 이를 달성하기 위한 구체적인 목표와 전략
 - 실천과업과 서비스의 과정으로 설명

2. 의료사회복지의 실천과정

1) 초기단계

- 보건·의료사회복지에서 가장 중요한 세 가지 접근법
 - 상황적·과도적 위기를 포함한 위기 이론을 중심으로 한 단기치료
 - 일련적인 중재
 - 장기치료(1년 이상)
- 포함되는 요소
 - 환자와 가족이 사회복지사에게 찾아오는 시기
 - 의료진에 의해서 의뢰되어 도움을 요청하는 시기
 - 원조서비스(Helping Service)의 준비, 관여, 탐색, 문제규정과 사정, 계약, 목표설정 그리고 다음 단계의 설정 등
- 준비단계
 - 환자와 접촉하기 이전에 원조과정의 성공적인 시작에 확신을 도울 수 있는 단계
 - 예기되는 감정이입(Empathy), 사려 깊은 감상, 그리고 계획 등이 내포됨
- 관여(Engagement)
 - 환자와 사회복지사가 목표달성을 위하여 각자의 과업을 성공적으로 수행할 수 있게 함
 - 환자, 가족 또는 관련된 사람들과 업무수행상의 관계를 확립시킴
 - 보건·의료영역에서 사회복지사는 그의 기능과 역할을 설명
 - 환자의 주치의, 간호사 그리고 다른 진료팀과의 관계를 설명해야 함
 - 질병에 관련된 스트레스를 다룸
 - 실천적인 관심을 충족시키기 위한 자원을 찾음
 - 퇴원계획을 세워 환자와 그 가족을 도움
 - 사회복지사 자신의 서비스로 환자와 그 가족을 어떻게 도울 것인가를 신중하게 설명
- 사정(Assessments)
 - 임상실천을 위한 정보 또는 자료를 선택, 협력과정에서의 실제적인 자료, 그리고 중재의 초기단계에서 이러한 자료의 해석 등을 포함한 모든 활동을 의미
 - 사정의 목적
 - 클라이언트와 의료진이 중재를 위한 표적문제를 결정하고 중재목표를 묘사할 수 있도록 돕는 데 있음
 - 사회복지사의 문제 사정의 목적
 - 그가 다루고 있는 상황을 이해하고 개별화하며 특수한 상황 속에서 관련성 있는

요인들을 발견하고 분석하는 데 도움을 받고자 하는 데 있음

- 전문적인 사정의 1차적인 목적

- 개인을 치료하기 위한 계획에 적절한 정보를 조직하는데 있음

■ 핀커스 미나한(Pincus & Minahan)은 문제 사정에 들어가는 다섯 가지 요인

- 문제의 발견과 서술
- 사회적 상황의 역학분석
- 목표와 목적의 인정
- 과업과 전략의 결정
- 변화노력 안정화 등

■ 문제해결에 관한 특수성을 갖는 사정의 4R's

- 환자의 사회적인 역할(Roles)을 사정하는 것
- 환자의 대인적인 관계(Relationships), 문제의 원천과 문제에 대한 잠재적인 해결 그리고 자원욕구 등을 사정하는 것
- 문제에 대한 환자, 가족의 정서적 반응(Reactions)을 사정하는 것
- 문제 해결을 위해 관여될 수 있는 환자와 가족에 유용한 자원(Resources)을 사정하는 일

■ 브라트(Bracht)

- 사정에서 분석하는 과업을 다음과 같이 제시함
 - 환자의 독특한 개인력
 - 개인적인 강점과 약점
 - 사회적, 환경적 여건
 - 환자 자신이 알고 있는 의료체계
 - 경제적 자원
 - 질병문제에 대한 개인의 반응
 - 질병에 의해서 초래한 생활양식의 변화 • 단기 또는 장기적인 변화
- 이상과 같은 것을 분석하고 이를 근거로 해서 사정해 나가야 함
- 사정은 문제지향적인 기록에 따라 행해지며 다음은 행동적 사정모델, 그리고 의료사회적 진단모델 등으로 행해짐

■ 위드(Weed)에 의해서 개발된 문제지향적 기록은 문제해결을 위한 4가지 영역의 중요한 요소를 기초로 함

- 근거자료의 획득
- 문제규명 확인
- 규명된 문제에 관련된 계획의 개발
- 계획의 실행

■ 행동적 사정모델(The Behavioral Assessment Model)

- 행동치료가 보건의료기관에서 현저하게 활용하는 근거는 직접적인 서비스를 주는 실천과 조사 연구를 위한 전략에 있기 때문임
- 행동치료의 장점 : 치료의 사정단계 동안 얻어진 기본적인 정보에 대하여 치료적 중재가 지속적으로 추적되고 측정되는 점
- 행동적인 사정모델의 내용
 - 표적행동(Target Behaviors)의 관찰, 내역, 그리고 규정하는 일
 - 표적행동의 빈도, 강도, 그리고 지속시간 정도
 - 표적행동(환경적인 결정인의 행동관계성)과 결과를 기록하는 일
 - 치료계획과 평가방법의 자세한 내역

■ 의료-사회적 진단모델(The Medical-Social Diagnosis Model)

- 도머러스(Doremus)가 의료-사회적 진단을 하는데 역할, 반응, 관계성, 그리고 자원에 초점을 둔 사회체계 관점의 모델을 개발한 것

■ 질병에 대한 반응을 사정

- 사회적 · 정책적 그리고 과학적 환경에는 여러 가지 요인이 있음
- 충격, 부정, 우울, 또는 통합 시초 등이 내포되는 환자의 적응단계
- 전(前)의 사회적 역기능 또는 정신과적 위기 어느 것이든 이에 대한 반응
- 문제를 극복하려는 환자의 동기, 가족이나 중요한 다른 사람과 환자와의 관계성 에 따른 질병의 영향과 그들의 본질에 따라 사정하게 됨

■ 도머러스의 의료-사회적 진단의 개념적 모델

- 보건·의료에 있어서 사회적 진단

1. 환자의 개별화
환자를 전인적인 인간(as a whole person)으로 생각하고 독특한 개인으로 가치를 고려한다.
2. 환자의 질병 또는 장애를 분석
 - A) 기술적인 정보 : 진단과 예후
 - B) 사회적 인종적 문화적 영향
 - C) 사회적 함축성 : 가계도, 비판력, 만성도, 예견성 등
3. 환자의 그의 사회환경에 대한 질병의 심리사회적 영향분석
 - A) 환자의 문제와 목적에 대한 환자 그 가족들의 지각
 - B) 사회체계의 검토
 - ① 역할(role)과 우선적인 사회기능·생활양식(사람, 배경, 능력, 우선적인 역할 수행)
 - ② 질병과 생활상황에 대한 반응(reactions) : 감정, 태도, 대처동기
 - ③ 그의 사회환경 내의 대인관계(relationships) : 그 대상자는 누구이며, 그 관계성의 본질
 - ④ 그의 문제에 대처하기 위한 자원(resources)
 - i. 경제적 자원 : 진료비의 출처, 지원하는 출처
 - ii. 환경적 자원 : 지역사회, 주택환경, 신체적, 정서적 안정도
 - iii. 제도적 자원 : 직업, 교육정도, 종교, 사회단체
 - iv. 인적자원 : 가족, 친구, 친지의 친밀도(행동 또는 경험에 영향을 주는 대처능력)

4. 의료-사회적 진단(초기의 느낌과 계획)

- A) 역할, 반응, 관계성, 자원 등 사회체계적인 검토를 통하여 제시된 문제를 사정
- B) 의료적·인적·대인관계적·실천적 인상(impression)
- C) 실시하게 되는 중재적인 수단의 범위와 계획하는 자

■ 문제지향적 의료기록지

1) 사회복지 자료근거(social work data base)

2) 문제번호와 문제명칭(Problem No. and title)

3) 의뢰처와 의뢰사유(sources of referral and reason)

4) 자료출처와 획득방법(sources of data : how obtained)

5) 가족의 구성(family constellation)

S : 주관적(subjective)

문제의 기대에 대한 환자 또는 가족의 지각 보고자료

1) 규명된 환자의 현 역할 : 최근 사회적 기능과 적절한 배경자료

2) 환자의 중요한 대인관계성의 본질

3) 동원 가능한 자원 또는 부족한 자원으로서 중요하게 보고된
자원(재정적, 환경적, 제도적, 인적)

O : 객관적(objective)

환자와 가족에 대한 사회복지사의 전문적 평가

4) 반응 : 태도, 행동, 동기, 능력, 예컨대 긍정적 또는 부정적 반응과 관찰된 대인관계성
정당한 것으로 인정되고 현재 중요한 특별한 객관적 사회자료

A : 사정(assessment) : 의료적, 사회적 진단

환자의 역할가능, 대인관계성, 환자의 생활환경상에서의 문제에 대한 반응에 관하여
중재가 필요시되는 것을 사회상버부가 사정하고, 이를 문제의 우선순위로 나열하는 일

P : 계획(plan)

사회적 치료나 모든 환경적 서비스 등의 중재 또는 다학문적인 행동(interdisciplinary
action) 건의에 대한 특별한 계획

2) 협력적인 실천(Collaborative Practice)

■ 협력적인 실천의 책임과 과업

- 웹스터(Webster) 사전에서 협력(Collaboration)

- “일이나 근로를 함께 수행하는 행위”라고 정의

- 정신의료사전에서는 설리반(Sullivan)이 사용하던 개념

- “타자(他者)의 욕구에 대해 협동하는 것뿐만 아니라 민감한 반응이 수반되는
대인관계”라고 정의

- 콘웨이(Conway)

- “직접서비스협력을 환자 또는 환자집단들에게 통일적인 치료에 제공하기 위하여 2인
또는 그 이상의 요원들이 함께 일하는 것이다”

■ 의료사회복지사의 협력적인 활동은 다음과 같은 기본적 전체를 고려해야 할 것임

- 보건과 의료에서 사회복지 관여를 위한 적절하고 본질적인 요구로서 협력하는 데 근본적인 이유가 되는 사회적·정책적 그리고 과학적 환경에는 여러 가지 요인이 있음
- 사회적 설비로서 보건과 의료에 관련된 다양한 활동에서 타자와 효과적인 일을 수행해 가는 관계를 형성하고 유지해 가는 데 내포되는 행동적인 요구가 있음
- 협력적인 사회복지실천의 행동적인 요구를 충족시키는 데는 여러 쟁점이 있는데, 즉 자율성 문제, 의사의 기술 지배적 문제, 역할혼란 문제(캡, 중복, 불일치), 커뮤니케이션 문제, 환자의 참여 분제 등
- 협력적인 양식에서의 목적, 전조, 장소, 그리고 재정의 영향을 특히 강조하는 사회복지협력양식에는 전통적 그리고 응급적인 것이 있음
- 보건계획, 정책결정, 1차·2차·3차 의료에서 의료서비스 전달, 보건, 의료프로그램과 서비스의 평가, 조사연구와 교육을 다루거나 표현하는 데 비교할 수 있는 방법이 있음
- 협력적인 과정에서 강조되는 문제와 현실성에 현 사회복지 협력적인 활동의 강점과 제한점을 사정하는 것
- 협력적인 실천의 과장적인 것과 현실적인 것 간의 갭(Gap)을 다루는 데 방법이 다양함

■ 의료사회복지의 개입배경

- 보건·의료체계나 병원에서 사회복지의 공식적인 참여를 하게 된 외적인 특성은 다음과 같음
 - 생리의료적인 지식과 기술의 선례 없는 발전
 - 의학의 전문화로의 큰 변화(의료실천과 의학교육)
 - 질병에 대한 초점이 보건서비스, 보건조사연구 그리고 보건교육의료의 변화
 - 병원에 입원한 환자에게 병원의 자원 활용에 대한 관심증대
 - 과학적 의료의 관심과 행동의 주류에서 예방적인 서비스와 장기요양의 분리 등임

■ 보건·의료영역에서 최적의 사회복지 협력은 다음과 같은 요건에 따라 좌우된다고 볼 수 있음

- 보건·의료에서의 자의적인 상황뿐 아니라 활기찬 인도주의를 유지하려는 욕구를 제공해주는 보건·의료체계를 승인하고 지지하는 정도
- 질병의 결과, 과정뿐 아니라 원인에서 심리적·사회적 그리고 생리학적 요인에 상호영향을 미치는 보건·의료와 공공정책에 의해서 그 인식을 할 여유
- 보건프로그램, 욕구 그리고 책임의 개념화에 사회사업의 가치, 지식, 기술을 기여할 수 있는 사회복지의 능력여부
- 이상과 같은 광범하고 심오한 능력 내에서 사회복지교육, 실천 그리고 조사연구에 관한 자원을 협력적으로 하는 정도 등(Dana, 1983:186)

- 협력적인 과정에서 행동체계적인 요구(Demands)면에 기여할 수 있고, 보다 효과적으로 협력적인 행동이 되게 하는 사회복지의 특성
 - 전문직의 가치와 윤리, 그리고 신념에 따른 철저한 실행
 - 클라이언트문제에 대하여 전체적인 접근을 시도하는 신념
 - 상호의존적인 실천에 대한 인식
 - 동료나 다른 전문가의 전문적 지식과 기술에 대한 인식 등
- 쉐फी드(Schoenfeed)는 병원에서 사회복지기능의 주요지도영역을 제안하고 있음
 - 병원조직의 사회적 향상발전에 기여하는 일
 - 병원행정 및 의료요원이 보건·의료영역에서 처하게도 되고 처하게 될 외적인 변동을 함축한 새로운 방법을 개발하는 데 돕는 일
 - 병원의 목적에 대한 환자나 지역사회에 이해를 향상시키는 일
 - 이사장과 장기계획위원회의 일부가 되어 사회정책을 개발하는 일을 돕는 일
 - 병원의 일반직원이 교육에 참여하는데 이 중에는 신입직원에게 질환에 있어서 심리적 이해를 향상시키고, 환자를 위한 옹호적인 프로그램을 창안토록 오리엔테이션 시키는 일 등
- 오늘날 의료사회복지의 자율성
 - 법적·제도적으로 자격이나 편성을 규정하고 전국적인 조직체가 형성되어 있고 의료사회복지 직무의 표준화 병원협회 등에 의한 병원사회복지의 표준화로 옹호되고 증진되어 가고 있음
- 협력적인 활동에서 사회복지의 실천영역
 - 보건·의료에서 협력적인 실천은 임상실제에서 중요한 역동임
 - 보건의료영역에서 활용하는 협력적인 모델은 의사를 제외한 다른 전문가들의 역할을 존중하는 조직으로서 위치에 대한 인식을 반영하는 것
 - 협력적인 관계에서 생리·심리·사회적인 상황에 개입하는 사회복지의 자율성은 의사에 의해서 타협되지 않음
- 의사가 사회복지에 기대하는 점
 - 사회복지사가 케이스를 다루는 일 뿐 아니라 환자의 문제를 찾아내고 그 문제해결에 장애물 그리고 해결을 위한 계획에 관련 있는 정보를 의사로부터 또는 다른 의료전문가들로부터 획득하는 일을 알고자 하는 것
 - 사회복지사가 생리·심리·사회적인 접근을 하는 데는 의사와 타전문가들과의 협력적인 망(Collaborative Network)을 통해서만 이루어짐
- 협력적인 팀워크 행동체계에서 사회복지사는 다음과 같은 주요활동에 관여
 - 직접적인 서비스·임상실천
 - 환자나 그 가족에 대한 직접적인 서비스를 제공하기 위하여 의사를 중심으로 다른 전문가들과 함께 의료적인 심리·사회적 문제를 사정하고, 평가·진단하여 치료계획을 세워서 공동노력으로 치료에 개입하는 일

- 지도·감독
 - 팀워크를 하는 행동체계에서 협력의 기술을 갖기 위해서는 항상 같은 수준으로 직접적인 서비스가 협력적으로 함께 연구 계획되어야 함
- 행정
 - 사회복지실에서 행정은 내적으로나 외적으로 효과적인 프로그램 개발을 위하여 협력하는 데 있음
- 교육활동
 - 협력적인 활동에서나 보건·의료영역에서 사회복지를 이해하게 하고 팀워크에서 상호협력을 전제로 전체적인 교육이 있어야 각 전문직의 자율성과 조정적인 역할이나 활동을 효율적으로 하게 됨
- 조사연구활동
 - 보건·의료영역에서 사회복지사가 타전문가와 협력해서 팀워크 활동의 수요, 욕구조사, 직접적인 서비스의 평가, 환자 및 환자의 역학적 조사 그리고 지역사회보건향상을 위한 프로그램 개발을 위한 자료수집 등

3) 계약(Contracting) 단계

- 계약은 사회복지사와 클라이언트들이 함께 관여하는 일이나 그들 자신들의 기대와 서로 간의 기대에 명확한 동의를 하는 것
- 계약이란 "사회복지사와 클라이언트가 표적문제, 목표와 중재전략, 그리고 참여자의 역할과 과업에 대하여 명백한 동의를 하는 것"으로 정의
- 엡스테인(Epstein) 계약에 포함되어야 하는 8가지의 기본적인 요인을 제시
 - 우선적인 계약(최대 3)을 구체적으로 기술하는 일
 - 실천가들에 의해서 수용된 특수한 클라이언트 목표를 지정하는 일
 - 클라이언트의 일반적인 과업을 지정하는 일
 - 실천가들의 일반적인 과업을 지정하는 일
 - 중재가 계속되는 기간, 활용될 수 있는 일정과 제한된 시간을 지정하는 일
 - 면접을 위한 스케줄, 면접날짜, 계획, 그리고 장소 등을 정하는 일
 - 중재를 위해 기대되는 스케줄, 중재의 지속과 일정을 지정하는 일
 - 중재에 참여하는 사람들로써 1차적으로 클라이언트와 그와 관계되는 사람 등을 지정하는 일
- 계약을 하는데 중요하게 강조되는 것
 - 사회복지사가 환자에게 접근할 때 감정에 공감을 갖고 온화하고 진실되게 하는 것
 - 신중한 공감을 갖는 것이 환자에게 그의 문제를 명확히 하고 문제의 규정을 수용하게 하며 그 문제해결을 위한 노력을 하도록 돕는 데 결정적인 것이 됨
 - 문제해결에 장애물 그리고 해결을 위한 계획에 관련 있는 정보

1. 의료사회복지의 실천과정

1) 중재(Interventions) 단계

■ 목표

- 환자체계와의 대면적인 첫 접촉으로 시작
- 중재에 처음으로 임하는 목표
 - 문제 확인과 해결을 위한 구성을 하는 것
 - 한 번에 이루어진 중재는 최종적인 해결을 지향
 - ☞ 현존 문제의 확인이 명확해짐
 - ☞ 환자에 있어서 건강상태에 관련 있는 새로운 문제를 보다 더 잘 파악

■ 피셔(Fisher)의 3차원

- 중재전략을 설정하는 일
- 특수한 중재절차를 선택하는 일
- 프로그램의 영향을 평가하기 위한 방법을 개발하는 일

■ 중재전략의 구성

- 중재에 관하여 첫 결정을 하게 되는 것은 행동체계의 규모
- 행동체계를 구성하려는 사회복지사는 행동체계의 세 가지 주요특성의 범위 안에서 일해야 함
 - 목적을 달성하기 위해 효과적인 행동체계의 규모
 - 행동체계형성을 위하여 어떤 특수한 사람을 선발하여 포함시킬까 하는 구성
 - 의료사회복지사가 시간을 활용함에 있어서 상호작용의 장소를 계획하여 상호작용과 의사결정을 위한 규범이나 규칙을 제정하는 운영절차
 - ☞ 행동체계의 기능수행에 영향을 줄 수 있음

■ 피셔의 중재전략을 구성하는 3가지 유형

- 클라이언트 체계의 일부로 된 바람직한 행동을 증진하는 것
- 바람직하지 않는 행동을 감소시키는 것
- 인식적 유형을 변화시키는 것

■ 선택한 특수중재절차

- 사회복지사의 중재는 다음을 활용할 수 있는 능력에 의해 좌우됨
 - 자신의 창의력, 지식
 - 클라이언트에게 수용될 수 있는 기술
 - 클라이언트가 직면한 문제를 해결하는 데 효과적인 기술

■ 게르메인(Germain)의 환자체계에 따른 모든 중재

- 환자의 역할에 있어서 선천적인 감수성에 직면하는 행동과 결정을 할 수 있는 기회를 제공
- 직원과 환자가 환자 자신의 문제를 극복하려는 노력과 그들의 존엄성의 지원을 보상하도록 이들을 도움
- 환자의 생활양식에 대한 존중, 문화적인 가치와 사회적 관계, 조직적인 규범, 심지어 진료과정에서 저항을 받을 때까지도 환자를 존중
- 가끔 성공적인 극복을 좌우하는 필연적인 정보를 제공하는 데 도움

■ 중재대상별 과업, 역할 기술

- 의료사회복지사는 일차적인 대상문제인 질병으로 파생되는 심리사회적, 경제적, 사회복귀적인 재활 등의 문제를 다루고 도울 수 있는 전문적인 기술, 임상적 다원적 접근방법을 획득하게 하는 교육과 수련이 요망되고 이런 기술을 활용하는 기본적인 철학이나 신념이 확립되어지기를 요구하고 있음
- 사회복지사의 과업은 질병 또는 장애로 인하여 개인적·환경적으로 어려운 관계를 향상시키고, 스트레스에 의해서 야기된 고통과 서러운 감정을 다루고, 극복대처하기 위하여 개인적·환경적 자원을 강화하고, 스트레스를 경감시키도록 도움으로써 환자가 가지는 목표나 과업을 달성할 수 있도록 지원하는 것임
- 이 단계에서 사회복지사가 해야 할 과제
 - 동기조성(Motivation)
 - 문제해결(Problem-Solving)
 - 정서적 안정유지(Maintaining Inner Comfort)
 - 자주성(Self-Directedness)의 향상 등이 있음

■ 클라이언트의 문제해결

- 사회복지사는 클라이언트가 가지고 있는 심리사회적·의료적 문제를 해결할 수 있는 능력을 유지·강화시켜 주어야 함
 - 사회복지사가 해야 할 과제와 역할 및 기술유형 p249, 표9-8, 참조

■ 정서적 안정유지

- 사회복지사는 클라이언트의 고통스러운 감정을 해소시키고, 건전한 자존심을 갖게 도와주며, 새로운 자기의 모습을 받아들이고 질병으로 인해 변화된 현실 속에서의 자신의 과제를 찾게 해주고, 치료와 회복에 방해가 되는 방어기제들을 적절히 조절해 주어 내적인 정서적 안정을 유지 시켜야 함
 - 정서적 안정 유지를 위한 과제, 역할 및 기술유형 p250, 표9-9, 참조

■ 자주성의 향상

- 치료와 변화의 단계에서 최종적인 목표는 클라이언트가 더 이상 타인의 도움 없이도 스스로 문제에 대처해 나갈 수 있는 능력을 향상시키는 것

■ 자주성을 위한 과제, 기술 및 역할 유형

역할 유형	클라이언트의 대처과제	사회복지사의 실천과제	사회복지사 역할	사회복지기술
신체상태에 일치하는 자주성을 성취하고 유지하도록 도와주는 촉진자의 역할	자주성	1) 효과적인 대처를 위한 정보, 시간, 장소의 제공 2) 신체적 상태에 일치하는 선택, 의사결정 행동을 위한 기회의 제공 3) 과도한 의존 또는 독립심을 개선시킴	촉진자	1) 클라이언트에 대해: ① 적절한 시간과 적절한 양으로 적절한 인지의 범위 내에서 정보를 제공한다. ② 개방된 선택에 의해 의사결정하고 행동할 수 있는 기회를 제공한다. ③ 대처요구를 재구성시킴 ④ 퇴행의 관리 ⑤ 워커와 클라이언트 사이의 활동에 있어서 보조, 리듬, 시간을 조절한다. ⑥ 대처전략을 개발하고 시도할 수 있는 공간과 시간을 제공하고 실패를 다루기 위한 공간과 시간을 제공한다. ⑦ 의존심과 수동적 자세를 관리한다.
		신체적 상태에 일치하는 효과적인 대처를 위해 시간과 공간을 제공하고 선택, 의사결정 및 행동의 기회를 제공하도록 환경에 영향력을 행사한다.	촉진자	2) 기관환경에 대해 ① 환자와 가족에게 필요한 정보를 제공하도록 의사에게 영향력을 행사한다. ② 호나자와 가족들이 행동과 의사결정에 보다 더 참여할 수 있게 조직적 쇄신을 도입한다. ③ 부적응적 변화를 야기하는 의존심과 독립심을 효과적으로 다루도록 직원을 도와준다. 3) 외부환경에 대해 - 과잉보호의 문제를 취급하는 가족과 지원망을 도와준다.

2) 평가(Evaluation)

- 평가는 계획된 변화 과정 전반에 걸쳐 계속되는 활동으로서, 각 단계마다 과업이 완료되었을 때 당초의 목적을 달성했는지의 여부를 사정하는 과정
- 의료사회복지사가 환자나 그 가족의 문제해결에 대하여 재검토하고 평가해야 하는 주요이유
 - 계약에서 동의한 성장목표가 어느 정도 실현되었는가를 환자의 치료행동 체계 성원들에게 보여 줄 사회복지사의 전문적 책임과 관계가 있음
 - 명시된 결과와 성공의 재검토와 사정이 사회복지를 포함한 전
 - 의료팀(계획한 변화노력에 참여한 모든 구성원)에게 새로운 경험을
 - 학습하게 하는 데 있음
 - 의료사회복지부서의 활동에 대한 평가
 - 부서가 필요로 하는 대상에게 서비스를 주고 있는가
 - 부서가 요청된 서비스를 얼마나 제공하고 있는가
 - 그러한 서비스가 얼마나 효과적인가
 - 그러한 서비스가 얼마나 능률적으로 제공되고 있는가에 대한 질문에 응답할 능력을 보는 것

3) 기록(Record)

- 사회복지(의무)기록의 개념과 목적
 - 사회복지기록(의무)이란 클라이언트의 문제에 관계되는 모든 사항과 기관이 클라이언트에게 수행한 모든 개입행위를 기록한 문서
 - 기록의 의의
 - '공적 기록'의 성격이 있으며, 기록에 대한 정의는 실무자와 기관이 정확성의 기준을 지키면서 클라이언트의 사적 권리를 보장할 수 있도록 하는 데 의의가 있음
 - 사회복지기록의 목적
 - 전문적, 효과적인 개입을 가능하게 함
 - 기관의 책임성을 다하고, 행정적 요구에 의해서 기록 함
 - 사례의 지속성을 유지하기 위해서임
 - 전문가 사이의 의사소통의 수단이 됨
 - 지도감독의 자료로서 사용되기 위해서임
 - 교육훈련의 자료로서 사용되기 위해서임
 - 연구조사의 자료, 통계를 위한 기초자료로서 활용되거나 지역사회 조직이나 사회행동을 위한 자료로서 사용될 수 있음
 - 클라이언트와 정보를 공유하는 수단이 될 수 있음

4) 사회복지기록의 종류

■ 자료중심기록(Source Oriented Record)

- 병원의 경우 입원차트에 기록된 임상적인 정보로서 간호기록지, 의사의 처방, 증세의 진전과정에 대한 기록, 입원시의 노트, 각종 검사결과, 심리검사, 사회복지사의 기록 등이 포함됨

■ 진단적 요약기록(Diagnostic Summary Record)

- 기관에 따라 양식이 다양하며, 주로 서술적 양식도 포함함

■ 문제지향식 의무기록(PORM : Problem Oriented Medical Record)

- 구성요소

• 기초자료(Data Base)

- ☞ 문제 지향 식 의무기록의 첫 단계, 환자의 정보를 가능한 자세하고 광범위하게 수집하여 문제점을 파악하고 치료방침을 결정하는데 필요함
예) 주호소, 현재 및 과거의 병력, 사회력, 이학적소견, 생리적 자료, 검사소견

• 문제목록(Problem List)

- ☞ 가장 핵심적 요소
- ☞ 기초자료에서 얻은 정보를 근거로 환자의 건강에 관련되는 의학적, 사회적, 정신적 문제 등을 모두 밝혀내어 각 문제에 1,2,3,...식의 번호를 붙여서 목록을 작성

• 초기계획(Initial Plan)

- ☞ 문제목록상의 문제를 해결하기 위해 계획을 세우는 것
- ☞ 각 문제에 대해 네가 지 항목 진단계획(diagnostic plan), 치료계획(therapeutic), 교육계획(Education Plan), 추적계획(Follow Up), 경과기록(Progress)
- ☞ 각 문제별로 주관적 정보(Subjective Information : S), 객관적 정보(Objective Information : O), 분석평가(Assessment : A), 계획(Plan :P)의 네 가지 형태로 기록됨

- 문제지향식 의무(사회복지)기록의 장점

- 치료자가 환자의 문제점에 대하여 조직적인 사고를 하여 환자의 문제점들을 빠짐없이 다룰 수 있고 서로 상호관계를 파악하여 처리해 나갈 수 있음
- 책임성을 향상시킴
- 진단이나 치료의 과정, 변화들이 논리적으로 나타나기 때문에 치료에 참여하는 모든 치료자들이 명확히 알고, 의료팀 구성원 사이에 의사소통이 명확히 이루어짐
- 의학교육면에 있어서, 학생은 교수가 환자의 문제점을 확인하고 계획을 설정한 논리적 과정을 쉽게 볼 수 있고, 교수는 학생이 이해하지 못하는 부분을 단면적으로 확인 할 수 있어 좋은 교육이 이루어짐
- 제공된 치료의 질을 평가하기에 좋은 도구로 쓰임
- 간결한 기록을 장려함
- 의무기록의 내용을 컴퓨터에 수록할 때 재래식 기록보다 용이하게 할 수 있음

- 순서도(Flow Chart)
 - 시간의 경과에 따라 환자에 관한 구체적인 정보를 모으는 이 메모들을 내담자의 현재 및 변화하는 상태에 관한 집중적 연구로서 기능함
- 퇴원요약(Discharge Summary)
 - 서비스 제공자의 각 문제와 각 서비스에 대한 반응을 재검토함
- 표준화된 기록양식(Standardized Format)
 - 클라이언트의 정보를 수집하기 위해서 사용된 동일한 양식을 말함
 - 서술적 기록의 필요성을 최소화 함
 - 쉽게 검토하고 즉시 답을 써 넣을 수 있도록 주로 양자택일 형태로 구성되어 있음

5) 사회복지기록의 내용

- 카그레(Kagle)의 사회복지기록의 내용
 - 사회복지사와 클라이언트의 상호작용
 - 클라이언트에 대한 기초자료 : 개인의 신상과 문제에 대한 기본자료(이름, 주소, 생년월일, 당면문제, 가족관계)
 - 클라이언트를 만나게 된 이유 : 클라이언트의 주된 호소(Chief Complaints)
 - 클라이언트의 문제와 상태에 대한 보다 상세한 자료: 표면적인 문제뿐만 아니라, 그 문제의 원인과 관련되는 심리시 회력
 - 개입과정
 - 사후관리에 대한 자료
 - 수퍼바이저, 타사회복지사 및 치료진과 논의할 코멘트
- 양인석의 의료사회복지 기록양식 내용
 - 협진의뢰기록(Consultation)
 - 진찰권란, 병원명, 진단명, 입원, 외래구분, 병실번호, 입원일, 예후, 향후 입원기간, 현재 임상소견, 의뢰문제영역, 의뢰사유, 의뢰일, 임상과 서명, 보고 등으로 구성됨
 - 병원표준화심사에서 나누는 의뢰문제, 심리사회적 문제, 지역사회자원 연결, 입, 퇴원문제, 재활문제, 경제적 문제로 나눔
 - 초기면접기록(Intake)
 - 일반적인사항, 기록지 또는 가계 구성도, 발달력 가족력, 문제사정 및 개입계획
 - 경과기록(Progress Note)
 - 진찰권란(등록번호, 이름, 성별/나이, 진료과, 병실 등 포함), 날짜, 내용, 서명, 등의 줄 있는 노트형식으로 구성
 - 종결기록(Conclusion)
 - 진찰권란, 사례번호, 진료과, 진단명, 임상과, 주치의, 입원일, 퇴원일, 초기면접일, 문제영역별 의뢰 시, 문제상정시, 개입영역은 구체적인 개입 방법표시, 개입영역별 개입횟수, 진료지원금액(원내, 원외) 종결 후 계획, 사회복지사 평가

6) 사회복지기록의 작성방법

■ SOAP 작성방법

- SOAP는 문제지향적기록(POR)에서 나왔으나 문제지향식기록체계와는 독립적으로 사용할 수 있음
- 주관적 정보(Subjective Information : S)
 - 환자 또는 직계가족이 자기보고 하는 것으로서 주요호소, 증상, 병력 등을 기재함
 - 주관적 정보는 클라이언트가 상황을 어떻게 인식하고 느끼는가를 나타냄
 - 환자의 병력
 - 환자의 생활양식이나 가정생활
 - 환자의 정서나 태도
 - 환자의 목표
 - 환자의 치료에 대한 반응
 - 환자의 사례나 현 상태에 관련된 다른 정보
- 객관적 정보(Objective Information : O)
 - 전문가의 직접적인 관찰, 임상적 실험, 체계적인 자료수집 등에 의해 얻어지며, 주관적 정보와 비교하여 볼 때 이러한 자료는 독립적으로 검증될 수 있음
 - 의료기록지에 나온 환자의 병력이나 현 문제와 관련된 환자의 병력
 - 객관적인 검사 또는 측정이나 관찰의 결과
 - 이미 환자에게 제공되는 과제
- 분석평가(Assessment : A)
 - 주관적 및 객관적 자료의 중요성을 분석·정리하고, 그 결과에 의하여 환자의 문제에 대한 전문가의 생각을 말함 즉 치료진의 견해, 해석, 사정 등이 포함됨
 - 주관적 정보와 객관적 정보 사이의 관계
 - 단기목표 혹은 치료계획에 대한 정당화
 - 환자의 주요 문제들에 대한 명확화
 - 치료에 대한 정당화
 - 치료에 있어서 환자의 진전(혹은 비진전)에 대한 토의
 - 처음의 면담과 검사 동안 정보 획득에 있어서의 어려움에 대한 성명
- 계획(Plan : P)
 - 앞으로의 진단과 치료에 대한 계획, 환자나 가족에 대한 교육계획 및 추적계획이 포함됨
 - 하루 혹은 일주일에 환자가 치료받아야 할 횟수
 - 치료의 장소
 - 치료의 진전
 - 평가나 재평가에 대한 계획
 - 퇴원계획
 - 타 기관에 의뢰

■ 가계도(Genogram)

- 가족과의 상호작용적 자료를 그림으로 나타낸 것
- 2~3세대에 걸친 가족관계를 설명할 수 있는 사정도구
- 가계도 작성방법
 - 가계도상의 정보는 중요한 사항만을 기재함
 - 중요사건, 가계도 작성 후에 일어난 가족구조의 변화, 가족의 문제나 변화에 대한 가설이나 메모 후에 일어난 가족구조의 변화, 가족의 문제나 변화에 대한 가설이나 메모도 여기에 포함됨
 - 메모에는 반드시 날짜를 기록함
 - ☞ 병력
 - ☞ 나이 학력
 - ☞ 직업
 - ☞ 병역관계, 범법행위
 - ☞ 신체적 학대 또는 근친상간, 기타 가족의 정보 등을 기록함
- 가계도에 쓰이는 약어
 - 'Div'=Divorce(이혼) 'M'=Married(기혼) 'S'=Separation(별거)
 - 'D'=Death(사망)
 - 가계도에 쓰이는 기호들, 가족의 상호작용의 상징 들
 - 가계도의 예, 그림9-2. 가계도 참조

■ 생태도(Eco-Map)

- 하트만(Ann Hartman)에 의해 개발되었으며, 클라이언트의 사회적 사정을 유용하게 만들어 주는 것으로, 사회적 맥락에서 개인이나 가족의 위치를 나타낸 그림
- 생태도는 클라이언트와 함께 작성하며 함께 논의할 때 좋은 개입 효과를 얻을 수 있음
- 생태도 작성방법
 - 지도 중앙에 있는 원을 클라이언트로 잡음
 - 클라이언트와 그의 환경에 있는 중요한 요소들에 대해서 대화한 후, 그 요소들을 원을 사용하여 중앙의 원 주변에 배치함
 - ☞ 배치시 원의 크기가 크고 중앙에 가까울수록 클라이언트에게 중요한 환경적 요소가 됨을 의미함
 - 각각의 요소에 대한 클라이언트의 경험에 대해 클라이언트와 이야기 함
 - 각각의 요소에 대한 클라이언트의 관계에 나타내는 선을 지도 위에 그림
 - 지도가 완성되면 클라이언트와 함께 그것을 확인함
 - 결과를 평가하고 클라이언트에게 전체인상을 물어봄

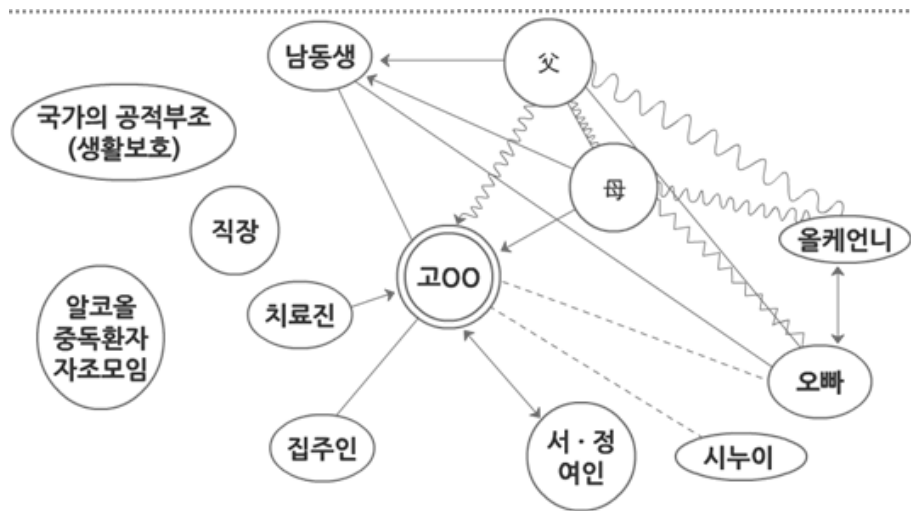


그림 12 고OO환자의 생태도

1. 현재의 병과 개인력 사정

1) 환자의 신상조사

- 이름, 나이, 성, 인종적, 문화적 배경 배우자의 상태, 직업과 입원비 조달방법, 환자의 가족상황

2) 주요증상과 현재의 병력

■ 주요증상

- 환자자신의 말로 진술되어야 함
- 환자 자신이 사건을 파악하는 방법이 중요
- 중요한 불만의 말 그대로의 기록함
 - 면접자로 하여금 사건이 어떻게 감정적으로 혼란된 환자에게 나타나는가를 알고자 하는 의도에서 주기적으로 재조사할 수 있음

■ 현재의 병

- 환자가 알고 있는 범위에 따라 현재의 병력을 설명해야 함
- 환자와의 면접
 - 환자의 병력을 고집어내는데 있어서 의료사회사업가는 주의 깊게 들어야 하고 환자에게 자발적으로 이야기 할 수 있도록 함
 - ☞ 환자의 행동, 자세의 변화, 억양, 얼굴표정, 그리고 이야기하는 주제에 대한 감정적 영향을 주의해서 관찰
 - ☞ 환자가 자발적이면 자유롭게 설명하도록 하고 될 수 있는 대로 질문은 제한함
 - ☞ 환자로 하여금 면접자는 그를 하나의 개인으로서 존중한다는 것을 깨닫게 하는 것이 바람직함
- 보고서 작성
 - 의료사회사업가는 면접에서 얻은 자료로부터 현재의 병의 발달에 대해 명료하고 연속적으로 나타내주는 항목들을 추출해서 구성해야 함

3) 개인력 사정 내용

■ 유아기 · 소년기 · 청년기 · 성년기가 분리되어 기록되어야 함

- 각 기간에 대해 지나치거나 부적당한 두려움이나 죄의식에 의한 억압과 환자가 기쁨을 얻는 근원과 함께 환자의 사회적, 성적, 직업적 기능에 대해 그가 면접한 것을 기록해야 함

■ 유아기

- 직접 얻는 데이터는 부모로부터만 얻을 수 있음
- 신체적 운동력
 - 아이들의 욕구를 신체적 운동력으로 표시하는데 부모들은 그들의 아기의 행동이 부모의 기대와 일치되지 못하면 일련의 악순환이 형성됨
 - ☞ 부모와 자라나는 어린아이 사이의 상호작용에서 지배적인 양식을 이루고 가끔 중요한 감정적 결과를 초래함
- 수면양식
 - 잠자는 자세가 유아기 때 어떠했으며 후에 어떻게 바뀌었는지 아는 것이 바람직함

■ 소년기

- 이 시기는 1살~학교 입학 전, 학교 입학 전~사춘기 시작으로 나눔
- 환자가 자란 신체적, 감정적 분위기를 이해하는 것이 필요
 - 소년기에 일어나는 병의 이야기와 그것이 환자와 그의 부모에 의해 어떻게 견디어졌는지를 아는 것
- 환자가 학교에 처음 들어갈 때와 그 후의 학교생활에 대한 반응
- 부모의 기대가 사회규범과 일치하는지 혹은 큰 차이가 나는지를 아는 것이 중요
- 애정의 공개적 표시나 어린이의 성적 호기심에 대한 솔직한 인정에 대한 가족의 태도
- 동생의 출현에 대한 환자의 반응
- 수면양식과 잠자는 자세에 대한 질문

■ 청년기

- 자존심을 세우고 걱정을 이기며, 화를 표현하는데 대한 적응기술을 알아내는 것이 목적
- 이 기간에 주어지는 특별한 요구는 사춘기의 시작과 성적충동에 관련된 것과 출세를 위한 학교교육의 준비에 관련된 것
- 환자의 청년기의 성적 행동에 대한 그의 가족의 반응은 발달에 중요한 역할을 함
- 학교성적이 청년의 일반적 기능에 대한 하나의 지침이 될 수 있음
 - 자신의 에너지를 건설적인 방향으로 구성하는 능력에 대한 표시와
 - 그의 능력을 어른의 책임감으로 뜻있게 구성하는데 표시가 됨

■ 성인기

- 성인기의 시점을 환자의 인적 역사를 알아내기 위해 자세하게 묘사
- 개인의 역사는 자신의 욕구와 계획의 결과로써 행동했느냐 안 했느냐 이에 대한 그의 반응은 어떠했느냐에 좌우됨
- 성인기에서는 환자의 인간교육, 성적경험, 연애, 결혼 등이 서술되어야 함
- 환자에 대한 기록에는 그가 성인으로 성장하면서의 정서적 위기라든지 어려움이 기록되어야만 함
- 신체적 허약과 그에게 중요한 다른 사람과 부모의 질병이나 죽음이 그에게 끼친 영향도 주의해야 함

■ 생활력

- 환자집안의 부모의 동기들에 대한 이야기 포함되어야 함
- 주요한 사람들에 대한 기록이 상세히 기록되어야 함(그들의 이름, 연령, 직업, 경제적 및 사회적 지위, 결혼기록 및 신체적, 정서적 허약)

2. 가족역동성과 가족기능 사정

1) 가족의 공통적 기능

- 가족은 생물학적 유대, 법적 관계, 충성과 헌신에 대한 장기적인 기대와 관련된 사람들의 집단으로 규정했고, 흔히 최소한 2세대를 포함하며 보통 1가구 내에 함께 거주함
- 이 집단은 가족에게 공통적인 기능들의 대부분을 수행하는 의지와 능력을 갖추어야 함
 - 아동의 양육과 사회화를 제공함
 - 가족성원에게 친밀성과 소속감을 제공함
 - 합의한 성인들의 성적인 표현을 할 수 있도록 정서적으로 안정감을 느끼는 환경을 제공함
 - 가족성원이 휴식을 할 수 있는 사적인 공간을 갖도록 함
 - 가족성원에게 법적, 사회적 정체성을 제공함
 - 경제단위로써 기여한함
 - 상처 입기 쉬거나 스스로를 돌볼 수 없는 가족성원을 보호하고 도움
 - 지역사회 자원이 필요한 가족성원에게 옹호자로서 도움
 - 핵가족과 확대가족구조 이외의 가족형태는 편부모가족, 혼합가족, 기능적 가족, 이차적 부모 등이 있음

2) 가족기능 수행에 관한 정보

■ 가족생태적 특징

- 가족성원의식을 규정
 - 다양한 방법으로 성원의식을 볼 수 있음
 - 생물학적 가족의 성원은? 법적 가족은 성원은? 기능적 가족은? 인식된 가족은? 헌신성을 나타내는 가족은? 충성과 의무에 대한 기대를 다른 가족은?
- 가족의 사실과 실제
 - 가족의 이름, 성과 연령은? 발달단계에 따른 가족기능은? 가족기능과 가족생활주기와 어떤 관련이 있나? 종교적, 윤리적, 문화적 정체성을 갖추었나?
 - 소득의 출처는? 이혼, 유기, 혹은 폭력의 역사가 있나?
 - 가족성원의 신체적 혹은 정신적 질병, 장애나 중독으로 가족의 기능수행이 영향을 받나?

■ 가족구조의 특징

- 가족의 역할구조

- 가족 내에서 다른 사람에게 어떻게 행동할 것인가를 규정짓는 사고와 행동패턴을 말함
- 어떤 역할은 공통적인 일상적인 과제
 - ☞ 차를 운전하는 사람, 세금을 지불하는 사람, 아동을 돌보는 사람을 나타냄
- 역할구조는 가족의 문화와 종교에 의해 강한 영향을 받음

- 가족기능

- 경제단위(안전한 소득, 세금지불)로써 가족기능은 어떠한가?
- 일상생활과제(요리, 청소)는 성공적으로 관리되고 있나?
- 가정은 휴식, 건강회복과 성원을 위한 사적인 공간을 제공하기에 충분한가?
- 가족은 아동에게 적절한 사회화의 경험을 제공해서, 그들이 성인기에 필요하게 될 대인간 그리고 사회적 기술을 학습하도록 돕고 있나?
- 가족은 중요하다고 생각하는 의식, 전통, 그리고 종교적 신념을 고수할 수 있나?

- 가족의 내적 경계(가족체계는 네 가지 하위체계로 구성)

- 부부하위체계(보통 성관계를 포함하는 2인의 성인)
- 부모하위체계(아동양육을 책임지는 가족성원들)
- 부모-자녀 하위체계(부모와 자녀 사이의 특별한 친밀성)
- 형제 하위체계
 - ☞ 하위체계를 규제하는 다양한 규칙, 의사소통 채널, 행동패턴을 경계란? 용어로 설명함
 - ★ 건강한 가족-경계가 꽤 명확하고 사회규범과 조화
 - ★ 밀착된 융합된 가족-경계가 불명확하고 약할 때 성원들은 가족성원들의 생활에 침입하고 과도하게 관여

- 가족의 분위기

- 가족은 따뜻하고 서로 돌보는가? 염세적인가? 외향적인 분위기인가? 우울한가? 즐거운 애정적 분위기인가? 화가 난 분위기인가? 통제적인가? 자발적인가?

- 가족 성원들과 정서적 친밀성

- 모든 사람은 친밀성에 대한 욕구가 있지만 동시에 우리 대부분이 친밀성에 대한 약간의 두려움도 갖고 있음
 - ☞ 자신의 상처가 드러날 것에 대한 것과
 - ☞ 그들의 취약성을 어느 정도 이용할 것에 대한 두려움이 있기 때문임

- 가족성원의 개별성

- 가족을 사정할 때, 가족성원들이 차별성을 어떻게 다루는지 고려해야 함
- 차이점을 다루는 네 가지 기본적인 방식
 - ☞ 다른 사람을 무시함
 - ★ 다른 사람의 개성을 무시하거나 억압함으로써 차별성을 다루려고 하는 것
예) 다른 사람의 결점 찾아내기, 비난하기, 공격하기 등
 - ☞ 자신을 무시함
 - ★ 자신의 개성을 억압함으로써 차별성을 다루는 것임
예) 항상 동의하고 다른 사람에게 양보하고 자신을 조정시키며, 자신의 진실된 감정을 숨기는 것 등
 - ☞ 이슈를 피함
 - ★ 차이점을 드러내는 이슈를 부정하거나 억압함으로써 차별성을 다루려는 것
예) '안전한' 주제만 다루는 가족 의사소통을 유지하는 것 등
 - ☞ 개방적이고 정직한 의사소통을 함
 - ★ 차이점이 존재한다는 것을 인정하고 상호존중의 태도로 그것들을 논의하고 어떤 갈등이 발생하든지 해결하려는 노력을 통해 차별성을 다루는 것

- 가족체계의 적응성

- 비록 체계적 관점에서 가족을 보는 것에 큰 가치를 두고 있지만, 역동적 체계가 독립적인 인간을 구성되어 있고 각자는 독특한 유전적 특성, 생물학적 특성, 개성, 생활경험을 갖고 있다는 것을 기억하는 것이 중요
- 사회사업가는 그 가족체계의 규범, 가치, 규칙이 좋은 적합성을 갖추었는지 아니면 잘못 부합되었는지를 고려하는 것이 유용함

■ 가족의 과정

- 가족 내적인 변화

- 변화에 대한 지지와 반대를 사정하기 위해서 사회사업가는 가족성원이 가상적으로 변화의 효과에 대해 생각하도록 요청할 필요가 있음

- 가족체계의 항상성

- 가족은 가족 그 자체를 유지하고 가족 내 한 성원을 희생양으로 만듦으로써 체계를 보호하려고 하는데 이러한 현상을 흔히 가족성원을 다시 구성하는 것이 라고 함(가족체계가 가족성원을 포함하거나 배제시킴으로써 안정성을 회복하려는 가족체계의 노력)

- 가족의 의사소통

- 가족성원들이 각자의 욕구에 적절히 반응하기 위해서 상대방의 욕구에 관심을 둔 의사소통이 되어야 함

- 가족의 의사소통 패턴
 - 둘 혹은 그 이상의 사람들이 정기적으로 상호 작용할 때는 언제든지 언어적, 비언어적 의사소통 패턴이 개발됨
- 가족 내 적응의 어려움
 - 가족 상호작용에 관한 두 가지 상호 관련된 주제는 많은 문제행동과 비문제 행동을 설명해 줌
 - • 친밀성 대 소원함, 소속감 대 독립성에 대한 바람이 있는데, 문제를
 - 다루는 가족의 노력을 관찰할 때 사회사업가는 계속 질문을 해야 함
- 가족 내 의사결정
 - 모든 가족은 의사결정의 패턴이나 스타일을 개발함
 - 어떤 가족은 모든 성원이 의사결정 과정에서 의견을 표명하고 또 다른 가족의 경우 한 성원이 모든 주요한 결정
- 가족의 의사결정
 - 가족규칙은 가족의 조직이나 체계성을 유지하는 외적, 내적 원리를 말하고 가족성원의 상호작용을 좌우함
 - ☞ 규칙은 식사시간에 좌석을 배치하는 것, 가족규정
 - 예) "목욕이 끝난 후 욕조를 깨끗이 하는 것"과 같은 규정에 반영함
 - 대조적으로 대부분 가족역기능에 기여하는 언급되지 않았거나 숨겨진 규칙들이 있음
 - ☞ 규칙은 정서를 압도하고 무책임한 행동을 덮어 주며 부정직을 증진시키거나 수치심과 같이 특별히 해로운 감정을 낳게 함
 - 예) "아버지가 술을 마실 때는 절대 그의 형과 말하지 않는 것", "부모님이 싸우는 것을 못 본 체하는 것"

1. 가족역동성과 가족기능 사정

1) 의료사회복지의 사정모델

■ 심리사회적 사정 모델

- Hollis는 사회심리적 사정의 모델을 발달시킨 중요 인물
- 이론적 기초
 - 주요 이론은 자아개념에 초점을 맞추는 정신분석학 이론
 - 골스테인(Goldstein, 1988)는 사회사업 실무에 자아심리학이 통합되는 과정에 대해 설명하면서 2가지 초점을 강조
 - ☞ 생리-사회-심리학적 과정에 관한 초점임(교류, 대처기제, 방어기제, 자아기능, 정체감, 자기생성, 개성화에 관한 초점)
 - ☞ 인지적 발달, 극복과 적응, 그리고 스트레스와 같은 발달적 쟁점에 초점을 둠
 - Goldstein은 이 모델의 6개의 이론적 가설을 확인
 - ☞ 인간은 극복하기 위한 내적 능력을 가지고 태어남
 - ☞ 자아기능은 역시 내적인 것
 - ☞ 자아발달은 생애의 과정임
 - ☞ 자아 기능은 기회의 결여, 낮은 역할모델, 그리고 낮은 학습에 의해 손상되어질 수 있음
 - ☞ 자아기능은 과거와 현재 사건에 의해 만들어짐
 - ☞ 사회적 기능 안에서 문제는 외부 스트레스와 두 사람간의 적절성의 결여, 내적 기능의 손상에 따른 결과
 - 터너(Turner, 1988)는 사회심리적 이론이 정신분석학적 이론뿐만 아니라 다른 이론을 통합하였다고 함
 - ☞ 거기에는 민족성, 가치 그리고 힘과 같은 요인과 체계이론과 역할이론을 포함함
- 사정기술
 - 사정의 목적은 특이한 진단에 도달하도록 하는 것
 - 터너(Turner)는 심리사회적 진단이 문제를 명명하고 확인하는 것뿐만 아니라 클라이언트의 감정을 인식하는 것을 포함하여 진행하는 과정
 - 골스테인(Goldstein)은 인간과 환경간에 작용하는 것으로 사회심리적 사정을 설명함
 - Goldstein은 사정과정을 안내하기 위하여 6가지 도구적 질문들을 제시함
 - ☞ 클라이언트의 문제가 스트레스로부터 오는가?
 - ☞ 자아 능력에 따른 문제인가?
 - ☞ 오래 지속된 해결되지 못한 문제에서 오는가?
 - ☞ 환경적 자원의 결핍에 따라 오는 것인가?

- ☞ 자아능력과 환경적 자원을 얼마나 가지고 있는가?
- ☞ 클라이언트가 가지고 있는 자아능력과 환경자원은 무엇인가?

- 비판

- 마티타이니와 키르크(Mattaini & Kirk)
 - ☞ 심리사회적 사정에서 수집된 측정자료는 수집된 형태에 따라 명목자료에서 서열자료까지 다양한 자료로 되어 있음
 - ☞ 이 접근으로부터 수집된 자료의 '풍부성'을 언급함
 - ☞ 심리사회적 자료는 서술적이고 일회적이며, 평가 보고서는 자료의 집계보다는 하나의 서술적 논거로 나타남
- 심리사회적 접근의 제한
 - ☞ 이론적 통합의 결여
 - ☞ 치료계획을 수립하는데 어려움
 - ☞ 적절한 접근내역의 어려움
- Goldsteins
 - ☞ 발달적이고 대인관계적인 이론 구성을 지속적인 통합하는 것에 동의하고 이를 요청함
 - ☞ 좀 더 효과적인 치료 목적을 세우고 그 목적을 평가하기 위해 단일사례 연구방법을 사용함

■ 문제해결사정모델

- 이론적 기초

- 존슨(Johnson, 1981)은 문제해결 접근이 듀이(Dewey)의 합리적 문제해결, 역할이론, 상징적 상호작용주의, 자아심리학에서 끌어올린 이론적인 절충이라고 하였음

- 사정기술

- 사정의 목적을 클라이언트가 문제를 극복하도록 돕는 데 있음
- 사정은 관련된 대인 관계적 쟁점의 맥락 안에서 문제를 확인하는데 관심이 있음
- 펄만(Perlman, 1957)은 4P를 클라이언트에게 제시하였음
 - ☞ 인간(Person), 문제(Problem), 장소(Place), 과정 (Process)
 - ☞ 4P는 클라이언트로부터 사정자료를 수집하고 조직하는 방법임
- 도르무스(Doremus, 1976)은 4R 더함
 - ☞ 역할(Role), 반작용(Reaction), 관계(Relationship), 자원(Resource)
- 쉐퍼(Sheafer, Horejis)은 4M 을 더함
 - ☞ 동기(Motivation), 의미(Meanings), 관리(Management), 모니터링
- 4P, 4R, 4M에 관한 자료수집은 실무자가 클라이언트에게 물어볼 수 있는 질문이 됨

■ 행동적 사정모델

- 이론적 기초

- 도프만(Dorfman, 1988)은 사회사업 분야에서 행동적 이론과 방법의 통합에 역사를 검토
- 조작적 조건화와 고전적인 행동주의적 심리학임
- 전제는 모든 행동이 학습되어 진다는 것임
- 클라이언트의 변화를 위한 예후는 인간 행동에 대한 전통적 이론보다 더 긍정적임
- 최근에 이 모델은 인간의 인지와 감정에 대해 학습원리의 적용보다는 인지적 경향을 보임
- 행동결과의 순환적 본질, 상호작용, 복잡성 등의 개념이 더 추가되었음
- 로스(Rose, 1988)는 오늘날 행동 모델의 주요한 가설 8가지를 규정
 - ☞ 인지는 행동의 연속성에서 깨닫게 되는 것
 - ☞ 문제와 치료는 다각적인 차원에서 신뢰되는 것
 - ☞ 문제는 다루어질 수 있다는 관점으로 봐야 함
 - ☞ 내적인 사건과 외적인 사건 모두 동등하게 중요한 것
 - ☞ 가치 있는 행동은 가치 있는 평가를 하는 것
 - ☞ 변화의 지속과 일반화는 최대한 포함하는 것은 클라이언트를 격려할 수 있게 됨
 - ☞ 클라이언트와 치료적 관계는 변화를 발생시킬 수 있는 첫 번째 것이 되어야 함

- 사정기술

- 행동사정의 목적은 선행되고 지속적으로 변화되는 구체적 행동(사고, 감정, 과잉행동을 사정)
- 갠브릴, 토마스(Gambril, Thomlison)와 카터는 9 단계
 - ☞ 문제영역의 사정 도구
 - ☞ 문제 선택과 접촉
 - ☞ 협조 관계의 허용
 - ☞ 초점이 되는 행동의 구체화
 - ☞ 초점 행동의 하한선
 - ☞ 조정 가능한 조건의 개념화
 - ☞ 환경자원의 사정
 - ☞ 행동 목표의 구체화
 - ☞ 수정 계획의 구성
- 톰리슨(Thomlison, 1986)은 행동 사정을 10 가지 정차로 정리
 - ☞ 가족원이 지각한 문제에 대해 질문하여 문제가 되는 행동목표를 문서로 수집함
 - ☞ 통제할 수 있는 행동적인 문제와 조건을 우선 고려함
 - ☞ 결과를 예측하기 위한 우연성이나 규칙을 규명함
 - ☞ 가족 내에서 발생하는 행동패턴을 규명하고 이를 관찰함
 - ☞ 변화를 이루어내는 작업에서 각 가족원으로부터의 자문을 구함

- ☞ 가족원이 행복해지기 위한 긍정적이고 바람직한 행동 규명함
- ☞ 긍정적인 행동을 변화의 목표를 결정함
- ☞ 가족들과 목표를 협의하는 과정에서 가족 구성원들이 선택된 목표에 대해 자유롭게 반응할 수 있도록 격려
- ☞ 기초선 측정을 수행함
- ☞ 주의할 필요가 있는 또 다른 문제들을 규명함
- 갬브릴(Gambrill, 1983)은 사회학습 이론에 기반으로 한 능력-기초 평가법의 특성을 제시
 - ☞ 갬브릴(Gambrill)은 타인의 행동, 사고, 감정, 생리적인 요인, 셋팅 사건, 환경에 대한 물리적인 특성, 윤리적이고 문화적인 요인, 물리적인 지역사회 자원, 과거력, 사회적인 요인, 발달적인 요인 등 클라이언트의 행동에 영향을 미칠 수 있는 힘들을 정체화 하였음
 - ☞ 갬브릴(Gambrill)은 위의 평가 정보에 문제와 결과에 대한 인테이크와 개관, 라포 형성, 특성과 목표 셋팅, 행동과 다른 관련 요인을 구체화, 기초선 자료수집, 진행자의 정체화, 서비스 계약 중재, 자원에 대해 정보 수집, 조직하고 해석한 정보, 중재하는 개입계획 안에서 과정 지침을 제안함

- 비판

- 갬브릴(Gambrill, 1983)은 환경적인 특성, 윤리적이고 문화적인 요인, 과거력 등을 포함하여 중요한 차원들을 규명
- 로스(Rose, 1988)는 현재의 경향은 많은 복잡한 문제를 처리하는 경향이 있지만 과거의 행동모델과 관련된 문제들 중의 하나는 문제의 정의가 너무 협소하다는 것이라고 기술함
- 마타타이니와 키르크(Matatain i& Kirk, 1990)는 이 이론이 자폐아 같은 중요한 사회문제에 대해 크게 주목하지 않았다고 지적함

■ 과제중심 사정모델

- 이론적 기초

- 1960 년대에 정신분석적으로 지향된 단기 모델로부터 개발되었음
- 초점은 경험적으로 조사연구 되어 질 수 있는 결과를 개발하는데 있음
 - ☞ Reid, 1988 : 과제중심 케이스웍의 이론적 기초는 다양한 이론적이고 기술적인 지향으로부터 통합되기 쉽도록 고안됨
 - ☞ Studt, 1968 : 초기부터 언급되었던 중요한 사상은 케이스웍이 문제해결과정(Perlman, 1957)이라는 것과 클라이언트의 과제라는 개념

- 사정기술

- 사정의 목적은 대상이 되는 문제와 그들이 바라는 결과를 상세히 서술하는 것
- 레이드(Reid, 1988)는 사정 과정을 더 연구함
 - ☞ 작업은 초기의 문제 형성을 하는 것: 문제에 대한 클라이언트의 지각이 중요하며 클라이언트가 문제의 전체 범위를 인식하거나 경험하는데 도움이 필요로 할 것이라는 것을 인식시키는 것
 - ☞ 서비스를 받기 원하는 클라이언트의 경우: 실무자는 클라이언트가 서비스제공자에게 제기하는 자신의 문제를 중심으로 시작함, 문제가 제시된 후 그것은 문제가 일어나는 맥락 안에서 평가됨

- 비판

- 과제중심 접근의 유용성은 모델의 구조를 기꺼이 이용할 수 있고 특정문제를 해결할 수 있는 클라이언트에 제한됨
- 이 접근은 과제와 문제의 상술이 특별한 수행계획에 되도록 이끄는 것을 규정함

■ 생활모델에서의 사정

- 이론적 기초

- 정신사회재활에서 관계망 활용과 자원체계 연결에 유용한 사정도구임
- 생태모델의 이론은 인간과 그들의 환경간의 상호작용에 관심을 두는 생태학적인 것
- 중요한 개념들은 스트레스, 극복, 적응, 능력, 자율성, 사회적 망 그리고 조작들을 포함함
 - ☞ 목적은 이 모델이 사회사업가와 클라이언트에게 적절한가를 생화과정에 반영하기 위한 것
 - ☞ 목적은 클라이언트의 병리적인 것보다 그들의 강점을 세우는데 있음
 - ☞ 목적은 치료와 사회 개혁간의 연결고리를 형성하는 것

- 사정기술

- 사정 목적은 문제를 이해하고 접근 계획과 목표를 설정하는데 클라이언트와 사회복자사가 함께 하는 것(Johnson,1981)
 - ☞ 저메인(Germain)과 지터맨(Gitterman):“클라이언트의 생태학적 맥락 안에서 존재하는 것으로 기관의 영향을 포함하고 생활공간 안에서 역동적인 힘의 상호작용”과 관련된 것으로 생활모델 시각으로부터 사정 설명
- 생태도는(Eco-map)은 사회적 맥락 안에서 클라이언트를 그리는 방법으로서 사용됨
- 사정의 1 차적 도구는 삶의 공간의 3 가지 영역을 포함함
 - ☞ 삶에서의 이동, 환경적의 압력, 부적응적 대인관계 과정임
- ① 가족은 같은 생활주기인 발달단계를 경험함
 - ☞ 특별한 과업은 개인이나 가족이 다음 단계로 이동하여 할 때 각 발달단계에서 성공적으로 협상하도록 요구함

② 두 번째 영역은 환경의 압력임

- ☞ 고려할 점은 필요한 조직과 사회망 자원을 포함하고, 다른 환경적 압력으로는 클라이언트의 육체적 환경과 실제적 생활상황에서 야기될 수 있음

③ 역기능적 대인관계 과정

- ☞ 클라이언트와 사회사업가간의 관계에서 보여 질 수 있으며 부적절한 지각, 기대, 반응으로 나타날 수 있음. 이러한 영역에 있어서 문제의 징후는 철수, 역기능적 제휴, 희생양임

- 비판

- 저메인(Germain)과 지터만(Gitterman)

- ☞ "가장 실무적인 기술이 대부분 모델에 공통적인 것이다"하는 시각이 아니라 "절차가 직접적일 뿐만 아니라 행동이 일어나는 생태학적 맥락의 영역을 지향하는 목적"에 따른 유일한 것이라고 하였음

1. 가족역동성과 가족기능 사정

1) 의료사회복지의 사정모델

■ 의사소통/상호작용적 사정모델

- 사티어는 알토의 헤일리와 잭슨과 일 하면서 이 모델을 가장 잘 설명한 이론임
- 이론적 기초
 - 가족의 의사소통 패턴과 가족의 자기가치에 대한 관점인 가족체계가 초점임
 - 이 모델에 기초가 된 이론은 의사소통에 대한 것이며 이중구속 의사소통, 메타 의사소통, 가족의 역할과 규칙과 같은 개념을 설명함
- 사정기술
 - 사정을 위한 시작 포인트는 가족규칙에 의해 가족의 성장과정을 막는 징후인 가족의 증상임
 - 증상은 가족이 건강하고, 즐거우며, 기능적으로 극복할 수 있는 능력과 관련될 수 있는 각 개인의 왜곡, 무시, 거부, 투사 비양육, 미개발된 부분의 망을 해결하기 위한 실마리를 제공하기 때문에 적절한 출발점이 됨
 - 접근의 목적은 사람들이 성장할 수 있도록 그들의 잠재성에 접근하도록 돕는 데 있음
 - 사티어(Satir)는 접근의 8단계를 설명하였는데, 신체적, 지적, 정서적, 감성적, 상호작용적, 상황적, 영양적, 정신적 단계
 - 넬슨(Nelsen, 1986)은 역기능적 의사소통 패턴을 결정하기 위한 관련 사정 질문을 설명함
 - ☞ 클라이언트가 기억해야 할 정보는 무엇인가?
 - ☞ 그들이 보고 일련의 행동을 이끌 수 있도록 받아들여져야 할 정보는 무엇인가?
 - ☞ 사회사업가에 의해 제공된 정보를 포함하고 그들에게 유용해야만 하는 그들이 받아들인 새로운 정보를 지키는 그들의 작은 사회체계 속에서 규칙을 작동하거나 정보화 과정에 그들의 방법이 있는가?

■ 비판

- 넬슨(Nelsen, 1986)은 의사소통 이론의 가장 큰 기여가 사정과정을 이해하기 위한 개념적 틀을 가진 사회사업가들에 의해 제공되어 질 수 있다는 것을 제시함

■ 구조적 가족사정 모델

- 필라델피아의 아동상담소의 미누친의 연구에서부터 시작되었음
- 이론적 기초
 - 가족의 행동패턴, 가족의 하위체계와 가족체계, 가족 생활주기를 포함한 가족구조에 초점을 둠
 - 래핀(Lappin)은 가족을 일련의 규칙과 규정 혹은 구조에 따라서 가족원이 상호 작용하는

개방체계를 보았음

- 체계는 발달 안에서 성장을 향한 내·외적인 힘에 의해 추진되어지고, 안정된 상태나 항상성(Homeostasis)을 유지하려고 하지만 변화하는 환경에 역시 반응해야만 함
- 건강한 가족은 환경적 조건에 성공적으로 적응함
- 하위체계는 연령, 세대, 그리고 유사한 범주를 기초하여 형성됨
- 경계는 "언제, 어떻게, 어떠한 상황 안에서 누가 참여하는가를 결정하는 체계의 규칙"임
경계는 연속체로 묘사됨

예) 영킴으로부터 혼란이나 격리에서부터 경직에 이르는 연속체임

- 증상은 가족체계가 역기능을 나타내는 존재하는 문제임

- 사정기술

- 래핀은 사정은 개입과 분리할 수 없으며 진행하는 것이라고 하였음
- 사정의 목적은 증상을 유지하는 메카니즘을 이해하기 위한 것이고, 실천가들은 무슨 구조가 문제를 지속하는 것과 관련되는가에 초기 가정을 할 수 있음
- 가계도는 가족세대간의 맥락 안에서 클라이언트를 그리는 방법으로서 가족치료자에 의해 사용되어짐

- 비판 : 변수의 특이성 결여는 이 접근에 대한 주요 비판임

2. 사회지지망 사정

1) 분석적 연구에서의 사회적 지지망

■ 사회적 지지망

- 개인이 사회적 지지를 일반적으로 제고하거나 받는, 또는 상호교환 관계에 있는 유대 전부를 연구대상으로 함

■ 사회적 지지이론

- 다차원적 지지기능이 개인의 안녕에 미치는 효과를 이해하는데 적합하며
특히 완충효과와 주효과에 관한 많은 연구결과가 축적되어 있음

■ 사회적 지지망은 사회적 망과 장점을 공유하고 있음

- 사회적 지지망은 사회적 지지의 배분에 관련된 유대를 사정하는데 편리함
- 사회적 유대의 구조적 및 상호작용적 특성을 분석하는데 유용함
- 개인적·환경적 요인이 어떻게 사회적 지지망, 또는 사회적 망에 영향을 미치는지를 밝혀줌
- 개인에게 이용 가능한 잠재적 망자원을 규명하는데 유용함
- 사회적 지지를 개인과 망 구성원과의 교류적 맥락에서 이해할 수 있도록 함

2) 실천분야에서의 사회적 지지망

■ 카플란(Caplan)

- 사회적 지지체계에 가족과 친척과 같은 1차적 집단뿐 아니라 친구, 이웃, 상호부조집단, 지역사회 보호제공자까지 포함하였음
- 삶의 스트레스적 경험과 전환기에 있어 일가친척을 포함하는 지지체계의 역할강조

■ 사회적 지지체계의 육성을 위한 전문가의 역할

- 유사한 삶의 위기를 경험하는 사람들을 위한 상호부조집단을 조직하도록 돕고, 기존의 집단에게 전문적 자문을 주는 역할
- 지역사회 비공식적 지지망에서 핵심적 역할을 수행하는 보호제공자에게 자문을 주는 역할을 수행

■ 휘태머(Whittaker)는 사회복지서비스와 관련하여 전문적 서비스에 통합시키는 세가지 전략 제안

- 전문적 도움전략은 부부상담, 정신분석적 치료, 놀이 치료와 같이 전통적인 접근법에 의해 서비스를 제공하며, 이에 따라 사회적 지지망 개입은 고려되지 않음
- 혼합전략에 세 가지 유형이 있으며, 전문적인 치료적 목적에서의 사회적 지지망 개입, 전문적 도움을 보충·보완·향상시키는 수준에서의 사회적 지지망 개입, 사회적 지지망을 1차적 도움방법으로 활용하고 전문적 도움을 보조적·지지적 수단으로 하는 사회적 지지망 개입방법이 있음
- 비공식적 도움전략은 전문적 개입 없이 사회적 지지망을 유일한 도움방법으로 활용하는 방법
 - 비공식적 지지망, 비공식적 지지망과 전문적 개입에 의해 형성된 비공식적 지지망의 통합적 개념, 그리고 점차 전문적 개입에 의한 비공식적 지지망과 공식적 지지망을 통합하는 개념으로 발전되었다고 하겠음

3) 분석적 연구와 실천분야에서의 사회적 지지망의 연계

■ 분석적 연구에서 사회적 지지망이 개인적 차원에서 적용된 것이라면, 실천분야에서의 사회적 지지망은 개인적 차원뿐 아니라 집단, 지역사회, 전체사회를 대상으로 적용

■ 사회적 지지망은 분석적 연구뿐 아니라 실천분야에서도 비공식적 지지망과 공식적 지지망을 모두 포괄하는 개념으로 사용되고 있다고 하겠음

4) 사회적 지지망

■ 트레이시와 휘태커(Tracy & Whittaker)

- 사회적 지지망 지도를 비롯하여 하트만의 생태도, 지노그램 등이 있고, 클라이언트의 사회적 지지자원을 사정하는 도구로서 사회적 지지망 지도를 개발함
- 사회적 지지망 지도
 - 사회적 지지망 지도는 가구(동거가족), 가족 및 친척, 친구, 직장 또는 학교 등에서 형성된 유대, 클럽, 조직체, 종교집단을 통해 관계를 맺은 유대, 이웃, 그리고 기관 또는 공식적 서비스 제공자의 7개 영역에 지지망 구성원을 규명함
- 지지망 구성원이 규명된 후 개인과 지지망 구성원들 간의 관계에 관한 일련의 질문이 주어짐
- 지지망 구성원이 개인에게 제공하는 사회적지지, 관계의 친밀 정도, 접촉빈도, 관계의 친밀 정도, 접촉빈도, 관계지속 기간 등이 포함함
- 사회적 지지망 지도는 지지망규모 영역규모 정서적·구체적·정보적 지지의 이용가능성에 대한 인지 비판성 친밀도 상호성 방향성 안정성 접촉빈도에 관한 정보를 제공해 줌
- 사회적 지지망의 사정은 클라이언트의 스트레스 요인을 규명하고 보다 체계적 방식으로 클라이언트의 사회적, 환경적 자원에 관한 정보를 수집하는데 유용함
- 사회적 지지망의 사정과정에서는 클라이언트가 자신의 지지망에 대한 통찰력을 가지도록 돕고, 이의 개선을 위한 대안을 모색하도록 격려함
- 사회적 지지망의 사정기법은 클라이언트 개인에게 적용될 수 있을 뿐 아니라 기관의 인테이크(intake) 과정에 도입될 수 있고 지역사회 취약인구집단이 가지는 욕구를 사정하는데 적용될 수도 있음

3. 의료사회사업의 영역

1) 개요

- 의료기관에서 의료팀의 일원으로서 사회사업의 전문적인 방법을 활용하여 환자 및 질병치료와 회복 및 사회복귀 기능을 돕는 목적을 가지고 질병으로 인하여 파생되는 환자의 심리적 사회적 및 경제적 문제가 질병치료나 그 회복에 악영향을 주지 않도록 문제를 해결해 주거나 조정하여 환자 및 그 가족을 돕는 전문적인 활동임

2) 구분

■ 일반의료사회사업

- 병원이나 진료의 수준에 관계없이 환자의 진료과정에 있어서 파생되는 문제의 해결이나 효과적인 진료를 위한 협력적인 활동이며 나아가서 지역사회 자원을 활용하여 사후지도를 주로 하는 활동임

■ 정신보건사회사업

- 정신의학자, 사회사업가, 심리학자, 정신과 간호사, 작업치료사 등으로 구성된
- 치료팀이 정신적, 정서적 장애로 고통을 받고 있는 사람들의 건강회복과
- 정신건강을 촉진하기 위한 2차 예방뿐 아니라 1차 예방적 활동으로 확대된
- 서비스를 내포하는 사회사업임

■ 재활의료사회사업

- 재활의료기관에서 심신장애인의 의료적, 사회적, 교육적, 정신적, 직업적 장애로부터 그의 잠재능력을 최대한 개발할 수 있도록 돕기 위하여 재활팀의 일원으로 재활과정에서 주로 심리사회적 진단과 치료, 사회자원 동원과 조정, 사회운동, 직업보도 등의 서비스를 하는 사회사업임
- 의료사회사업의 기능에는 본질적 기능과 핵심적기능, 확대적기능이 있음
 - 본질적 기능에는 의료팀과 협동, 환자 및 그 가족에 대한 직접적인 서비스, 병원내의 프로그램 계획과 정책결정에서의 참여, 지역사회 자원 조직에의 참여, 교육프로그램의 참여, 의료에 관계된 조사연구에 참여 등이 있음
 - 핵심적기능에는 정보제공과 의뢰, 지역사회 의뢰, 상담, 경제적원조, 퇴원계획 등이 있음
 - 확대적 기능에는 병원직원에 대한 사회사업 케이스 자문, 사회심리적 평가, 병원에 대한 지역사회 자원체계의 관리, 병원서비스에 대한 시민의 활용촉진, 심각한 문제 케이스의 발견, 병원 프로그램에 대한 질문, 지역사회 보건계획 수립의 참여, 병원 기획사업참여, 병원시설의 환자들에 대한 편의와 융통성 검토, 지역사회에 대한 프로그램 자문, 입원계획 등이 있음

3) 의료사회 사업가의 역할

■ 심리사회적 치료자의 역할

- 환자 및 그 가족에게 지지적인 개별사회사업의 치료방법을 이용하여 질환으로 야기되는 심리적인 문제를 해결하고 환자가 안정감과 자신감을 갖고 치료에 임할 수 있도록 함

■ 서비스 조정자의 역할

- 심리 사회적, 경제적인 정보를 의료팀에 제공함으로써 치료에 참여하는 여러 다른 전문요원과 함께 진단과 치료 및 서비스 계획을 수립함에 있어 환자에 대한 전인적인 이해를 증진시키고 의료팀의 종합적이고도 통합적인 서비스를 위한 협력과 조정을 담당함

■ 자원동원자의 역할

- 의료적 치료 및 재활과정에 있어서 필요로 하는 인적, 물적, 제도적, 법적 자원의 활용을 극대화하기 위해 자원을 조직화하고 동원함

■ 재활치료와 교정자의 역할

- 재활의료팀에서 심리사회적 측면의 조사연구와 평가, 치료훈련, 지도 및 서비스의 계획수립에 협력하여 생활지도적, 심리사회적, 직업적 등의 종합적인 재활과정에 참여해 치료나 교정을 함

3) 재활

■ 재활의 개념

- 장애를 지닌 이들의 신체적, 정신적, 사회적, 직업적, 경제적 가용능력을 최대한 회복시키는 것으로 계획된 목표지향적이고 개별화된 일련의 연속된 과정으로서의 체계적 서비스를 말하는데, 이것은 재교육, 재적응, 선천적 장애와 관련되는 Habilitation과 교육, 학습, 후천적 장애와 관련되는 Rehabilitation으로 구별할 수 있음
- 재활이란 사회복귀, 또는 사회통합으로 이해되고 있으며 원어의 Rehabilitation은 접두사 Re(다시)와 어간 Habilit(적합한)와 접미사 Ation(~으로 하는 것)으로 되어 있음
 - 다시 적합하게 하는 것을 의미하므로 재활은 사람답게 될 권리와 자격과 존엄이 어떤 원인에 의해서 손상된 사람이 그것들을 다시 회복하는 것을 의미함
 - 근본적으로 장애를 은폐하는 것이 아니고 회복하는 것
 - 이처럼 재활이라는 개념은 단순한 치료나 훈련의 기술적인 측면만이 아니고 심신의 장애를 가진 사람이 훌륭한 사회인으로서 생활할 수 있게 되는 것을 의미함
 - 즉 장애의 보충이나 보상, 치료회복과 개선, 문제의 해결과 극복으로서 장애인의 전인적인 복권이 이루어지도록 모든 욕구를 충족시켜주는 종합적 서비스인 것
 - 미국재활협회에서는 재활이란, 심신장애자의 신체적, 정신적, 사회적, 직업적, 경제적 가용능력을 최대한으로 회복시켜 주는 것으로 정의하고 있음(Townsend. 1966)

■ 재활의 목표

- 장애를 제거하여 사회에 복귀시키는 것
- 신체장애의 발생초기부터 의료적, 직업적, 교육적 및 사회심리적 개입과정을 통하여 서비스 대상에 따라 개별화되고 전문직간의 팀워크에 의한 통합적인 서비스와 그 가족 및 지역사회와의 적극적인 참여를 유도하게 됨
- 재활은 크게 의료적 재활, 교육적 재활, 직업적 재활, 사회심리적 재활로 구분될 수 있음

■ 재활과정이란?

- 장애인이 어떤 기관이나 시설을 통하여 검사 받고 치료받아야 하는가에서 부터 어떻게 사회생활에 적응해 나가는가 하는 방법을 습득해 가는 하나의 체계임
- 재활과정은 일련의 연속적 과정이므로 장애인과 재활프로그램에 대한 지속적인 평가가 이루어져야 함
- 일반적인 재활과정은 초기면접(접수)-평가-상담(치료)-직업배치-사후지도 순으로 진행됨
 - 초기면접
 - ☞ 재활과정의 개시점으로 전화나 직접 방문을 통해 재활서비스를 지원신청하고 각종양식과 신청서를 작성하고 날인하는 과정임
 - 평가
 - ☞ 내담자의 제측면은 필요한 재활치료와 서비스욕구와 관련하여 평가하고 진단과 개별재활계획서 작성의 기초를 이룸

- 상담(치료)
 - ☞ 신체적, 정신적 치료, 보장구, 치료적 처치, 공학과 직업배치를 통해 장애의 진전을 중지시키고 심신의 안정을 도모하여 직업배치를 준비함
- 직업배치
 - ☞ 고용준비와 심신의 안정을 이루거나 의료적 안정을 회복한 개인이 고용과 직업배치에 필요한 준비를 완료했을 때 적절한 직업배치가 이루어짐

■ 독립생활재활

- 직업재활만이 개인이 성취해야 할 목표가 아니라 장애인이 사회의 한구성원으로서 독립적으로 살아갈 수 있는 사회적 생존이 총체적 재활사업의 목표가 되기도 함
- 독립생활 재활은 보편적으로 의사결정이 있어서 일상생활에 있어서 타인의 의존을 최소화하고 자신이 결정할 수 있는 선택에 기반하여 자신의 생활을 추구하는 것

■ 사후지도

재활이 종료된 내담자에 대해 여러 가지 개인적, 의료적, 심리적 서비스를 제공하여 생활안정을 기하도록 하는 것

■ 재활분야?

- 재활의 영역으로 의료, 청각, 언어, 심리사회, 직업재활, 공학영역으로 나누며 이들 영역간에는 상보적 관계가 존재함
- 의료재활
 - 재활의 목표가 신체상의 장애를 최소한으로 줄여주고 잠재하고 있는 신체상의 능력을 최대한으로 개발하여 일상생활과 일에 적응할 수 있게 하여 주는 것이므로 의료재활은 재활과정의 첫 단계라 할 수 있음
 - 재활에서 정의하는 의료재활은 장애의 예방, 장애의 조기 발견뿐만 아니라 장애를 가진 이들에 대한 각종 재활치료를 행하는 포괄적인 의료임. 따라서 의료재활에 있어서는 여러 재활전문가들의 상호 긴밀한 팀웍이 그 어느 의료행위보다도 중요하다고 할 수 있음
 - 이렇게 함으로써 종합적 재활의 목적은 이루어지게 되는 것
- 의료적 욕구에 따른 재활전문인으로는 재활의학 전문의사, 사회복지사, 물리치료사, 직업치료사, 재활간호사, 언어치료사, 임상심리사, 심폐기능기사, 오락치료사, 보장구제작자 등을 들 수 있음
- 의료재활서비스의 주요활동 내용은 결손된 기능의 개선, 개발, 회복과 과제 수행능력의 개선 및 기능상실과 경험과 예방에 있으며 구체적인 활동내용은 다음과 같음
 - 물리치료
 - ☞ 운동치료, 열치료, 전기치료, 수치요법 등을 통해 신체적 기능을 최대한으로 개발하여 주거나 다른 부수되는 변형을 예방하는 치료활동임
 - 직업치료
 - ☞ 일은 치료의 매개체로서 사용하여 장애인의 심리적 지원과 신체의 능력의 개발 및 직업적 능력을 향상시키는 의료활동임

- 의용공학

- ☞ 인체 공학적 차원에서 적절한 의수족 및 각종 보장구를 선택하여 착용시킴

- 청각, 언어치료

- 청각, 언어재활은 모든 재활의 수단이 되는 매우 중요한 영역임
- 청각, 언어재활은 듣기와 말하기 기능을 포함한 개인의 의사소통능력을 신장시켜서 장애인이 일상생활에서 필요한 모든 정보를 수용하고 표현할 수 있도록 하는데 그 목적을 두고 있음
- 중증의 청각, 언어재활 대상자에게는 의사소통대체라는 첨단 공학적 접근을 통해서 의사 소통이 기능하도록 함으로써 실질적 청각, 언어재활의 기회균등이 보장되고 있음
- 지금까지는 장애인에게 정상인들이 사용하는 음성언어를 반드시 습득시키는 것을 목적으로 하는 '정상화론'의 입장에서 청각, 언어재활이 이루어져 왔으나, 앞으로는 '자아실현론'의 입장에서 사용 가능한 모든 수단을 동원한 총체적 의사소통 능력신장을 목적으로 하는 경향으로 바뀌고 있음
- 이러한 청각, 언어재활의 구체적인 내용은 다음과 같음

- ☞ 청능훈련

청각장애인의 판별, 청력손실의 정도, 성질 범위의 결정, 청력개선을 위한 의료적 위탁이나 전문적 지원, 청능훈련, 독화지도, 청각장애에 관한 부모, 학생, 교사들의 상담과 지도

- ☞ 언어치료

언어장애의 판별, 언어장애의 진단과 평가, 언어치료 프로그램의 구안, 언어치료의 실시(조음장애, 유창성 장애, 음성장애, 기호장애) 언어장애의 개선을 위해 필요한 의료적 위탁이나 전문적 지원, 언어장애에 관한 부모, 아동, 교사 등의 상담과 지도를 함

- 직업재활

- 인간의 사회적, 경제적 욕구는 직업으로서 충족됨
- 장애인의 직업훈련은 의료적, 교육적 서비스 못지 않게 중요함
- 의존적 생활로부터 독립적 생활로 전환할 수 있는 유일한 방법이 바로 이 직업재활 서비스임 이와 같이 공공 및 비영리 재활서비스의 내용은 다양하지만 주요활동을 요약하면 다음과 같음

- ☞ 직업평가

신체적 평가, 심리평가, 사회적 평가, 직업적 평가

- ☞ 직업훈련

직업적 훈련, 직업훈련

- ☞ 취업알선

선별적 작업배치, 체계적 직업배치

- ☞ 사후지도
고용 후 직업 안정을 기할 수 있도록 하는 제반 활동
- ☞ 직업상담
직업탐색, 진로지도, 구직활동에 필요한 노력

- 심리재활

- 심리재활서비스의 주요내용은 다음과 같음
 - ☞ 장애인의 심리측정
 - ☞ 장애인의 심리평가
 - ☞ 장애인의 직업 및 사회적응 안내
 - ☞ 장애인 상담
 - ☞ 장애인 가족 및 관련자 상담
 - ☞ 장애인 심리재활 서비스 프로그램 수반 및 운영

- 교육재활

- 장애인이 가지고 있는 능력을 최대한으로 향상시키고 발휘하게 하며 그의 잠재능력을 개발하여 사회생활에 적응하도록 도움을 주는 교육제도와 교육방법 및 기술을 통한 교육적 서비스를 지칭하며, 이와 관련된 교육은 특수교육임

- 사회적 재활이란?

- 사회재활서비스는 장애인의 사회적 기능을 회복시켜 주는 서비스로서 장애에 대한 적응이나 가정생활, 직장생활 또는 사회생활에서 적응력을 키워주는 것을 목적으로 하며, 한편으로는 사회가 이들 장애인을 수용하도록, 행정적, 입법적, 교육적으로 노력하는 과정임. 사회재활 서비스의 내용은 사회적 기능 능력을 갖게 하는데 주목적을 가지고 있으며, 주요 내용은 다음과 같음
 - ☞ 물리적, 제도적, 문화적 장애물의 제거
 - ☞ 장애인에게 적절한 환경의 조성
 - ☞ 건축물상의 편의시설, 교통편의 시설제공
 - ☞ 긍정적 장애관의 확립
 - ☞ 장애인의 사회활동고무
 - ☞ 장애인의 사회기능 함양

■ 재활공학

- 장애인이 여러 가지 형태의 사회적, 직업적 그리고 일상생활 요구에 대응할 수 있도록 능력을 대신하거나 유지 및 증대시키고 확대할 수 있는 기회를 제공하기 위해 여러 가지 장치나 방법을 고안하고 설계, 제작하는 것
- 장애인이 지니고 있는 최소한의 신체적 기능도 재료공학, 생체역학 그리고 전자공학과 같은 첨단기술과 접목된 때에는 놀라운 결과를 가져올 수 있음
 - 보조공학
 - 대체의사소통 대체개발

- 재활엔지니어링
- 컴퓨터 매체와 보조장치
- 원격 환경 제어
- 테크니컬 에이드(기술 공학적 도구와 기기)

1. 성인병 환자와 가족의 심리·사회적 개입

1) 환자와 가족의 심리·사회적 서비스

- 의료사회복지사는 환자의 질환이나 치료과정에서 파생되는 심리·사회적 문제와 빈곤환자의 치료비문제, 퇴원 후 생활문제 등에 전문적인 서비스와 자원조정의 활동에 중점을 둠
- 치료적 관계에 있어서 환자와 바람직한 인간관계를 형성하는 일이 중요함

2) 의료사회복지사의 환자에 대한 태도

- 환자의 성격의 특성에 따라 다르게 반응해야 함
- 환자가 무슨 말을 하려고 하는지를 잘 들어야 함
- 편견이나 비판적 태도가 아닌 수용의 자세를 지녀야 함
- 환자를 객관적으로 평가하여야 함
- 환자나 가족이 예후나 진단을 속단하지 않도록 해야 함
- 진료결정을 환자 스스로 할 수 있도록 도움
- 환자를 민감하게 관찰하고 파악하여 대응함
- 환자 자신의 병력을 자연스럽게 이해하고 말할 수 있도록 도움

3) 환자 슬픔의 극복과정

- 건강 상실로 오는 슬픔의 극복과정은 4단계로 나누어짐
- 순서적으로 보이지만 서로 중복되고 다시 나타나기도 함

	극복과정	내 용
1	부정	• 자신의 병을 부인하거나 병에 따른 감정을 부정 • 적절한 치료를 거부하거나 치료가 늦어지게 됨 • 병에 대한 사실적인 상태에 직면하게 해줄 필요가 있음
2	감정발산	• 환자에게는 그의 감정이 표현되도록 허용되어야 함 • 환자의 감정을 표현할 수 있는 계기를 마련해 줄 수 있음 • 자신의 상태를 극복하는 방법을 찾을 때까지 유지되어야 함
3	방어기제 사용	• 병적인 방어기제를 사용하여 감정을 조절하려고 함 • 부정, 수치심, 죄악감, 투사, 대치, 합리화 → 승화 • 방어기제의 건전한 활용과 병적인 사용을 인식하게 도움
4	회복	• 환자 자신의 결함을 적극적이고 건설적으로 이용 • 다른 사람의 문제에 공감함으로써 자신의 문제는 되살아나지 않음

2. 성인병 환자의 심리·사회적 문제에 대한 서비스

1) 성인병환자와 성인병의 개념

- 연령 40세~65세 간 발생하며, 이 연령층에서 높은 사인이 되거나 일상생활에 지장을 주는 질병으로서 노인현상이 간접적으로 원인내지 소지는 되나 직접적인 원인은 아니며, 국가적으로 금연, 절주, 육체적 및 정신적 과로방지, 체중과 영양조절, 적절한 운동, 정기적인 건강진단 등 그 예방책을 적극적으로 계몽 교육하고 치료를 철저히 해야 하는 질병

성인병의 특성	
1	아무 증세가 없어서 조기발견, 조기치료가 절대적으로 필요
2	어느 정도 진전되면 완전치료가 안되고 만성적으로 오랜 세월에 걸쳐 진행
3	합병증을 수반
4	치료의 핵심은 환자 스스로가 관리하는 생활의 규제
5	성인병 발생은 일부 유전과의 관계가 인정 체질이나 가계가 영향

2) 성인병환자의 심리·사회적 문제

의료사회복지사가 개입하는 성인병환자의 문제	
1	장기요양을 필요로 하여 노동능력의 저하나 상실로 인한 생활비문제 야기
2	공적부담제도의 미비로 지나친 치료비 부담문제
3	기동이 곤란한 환자나 임상노인과 같은 상태
4	기동부족으로 인한 전담간호나 사후지도 요구의 문제
5	환자는 직장생활, 가사, 육아 등을 수행하기 어려움
6	정신적 불안이나 고통
7	가족관계의 갈등이나 가족해체

■ 고혈압환자의 심리·사회적 문제

- 혈압조절을 위한 매일의 긴장이 요구됨
- 치료보다는 조절해야 한다는 점을 이해해야 함

■ 뇌졸중환자의 심리·사회적 문제

- 후유증으로 인한 사회복귀가 어려움
- 신체적 활동의 제한으로 인한 심리적 타격이 있음
- 외부세계와의 접촉을 피하고 위축되어 있음

■ 암환자의 심리·사회적 문제

- 신체적, 정신적, 경제적 문제를 모두 나타냄
- 암환자의 심리적 특성을 이해해야 함
- 부정→ 비애·위축→ 분노→ 조절·조정→ 퇴행의 심리적 특성을 보임
- 암환자의 진단명을 알릴 것인지 숨길 것인지의 문제가 있음

■ 당뇨병환자의 심리·사회적 문제

- 심리적 박탈, 정서적 지원의 상실, 무의식적 갈등과 우울의 상태가 있음
- 여자일 경우 임신이 불가능하므로 좌절감이 유발
- 음식조절로 인한 심리적 부담과 갈등 발생

3) 성인병환자의 의료사회복지서비스

■ 환자에 대한 심리적 원조

■ 가족관계의 조정과 가정생활계획의 원조

■ 사회자원의 활용 및 개발의 원조

■ 고혈압환자에 대한 의료사회복지서비스

- 가정이나 직장에서의 평안하고 원만한 분위기의 조성
- 환자를 자극하고, 흥미를 키울 취미를 갖도록 도움
- 퇴원이나 재활을 위한 세심한 계획 필요
- 가족이 환자의 치료에 적극 참여하도록 도움

■ 뇌졸중환자에 대한 의료사회복지서비스

- 재활계획에 있어 환자로 하여금 자신이 할 수 있는 일과 할 수 없는 일을 설계하도록 도움
- 환자의 흥미를 파악하여 실천하도록 도움
- 사회복귀를 위한 원조로서 적극적인 행동을 하도록 독립심을 길러줌
- 가족의 장기간 간호의 어려움을 환자에게 주지시켜 새로운 역할을 하도록 원조

■ 암환자에 대한 의료사회복지서비스

- 환자의 심리적, 감정적인 면에 관심을 가지고 치료를 시작함
- 환자가 신체적, 심리적으로 안정되도록 가정의 여건을 도움
- 환자치료에 관계되는 모든 의료진이 환자와 가족을 이해
- 자신의 병을 수용하여 치료에 협력적이고 적극적인 참여가 되도록 유도
- 환자의 사회경제적 문제와 환자와 가족의 비협력적인 면을 도움
- 진료과정에서 환자, 가족 그리고 다른 의료진의 감정을 지지하거나 이해하는 역할이 필요
- 퇴원 및 가정요양 계획에의 원조

■ 당뇨병환자에 대한 의료사회복지서비스

- 당뇨조절에 영향을 주는 환자의 태도, 습관, 대인관계에서의 상호작용에 대한 상담원조
- 병에 대한 수용과 함께 당뇨조절에 용기 있는 참여를 하도록 도움
- 당뇨병에 대한 제반 정보를 제공

3. 골수성 백혈병환자와 그 가족에 대한 사례

1) 급성골수성 백혈병

- 남 11세 급성골수성 백혈병, 초등 4학년의 사례를 다룸
- 일반적 사항, 정보제공자, 의뢰경위, 가족사항, 발달력 및 환자 생활사, 병력에 대해 자세하게 기술

2) 사회복지 문제사정과 개입계획

- 문제사정(심리·사회적 측면, 경제적 측면)
- 개입계획(심리·사회적 측면, 경제적 측면)

3) 사회복지 개입과정

- 환아에 대한 이해(무균실 입원에서 오는 고립감 및 불안감, 사회적 고립감)
- 환아 어머니에 대한 이해(자책감 및 죄책감, 다양한 역할기대에서 오는 부담감)
- 골수 공여자에 대해(공여자인 누나의 불안감 및 두려움)
- 경제적 측면의 개입계획 및 내용, 평가(1000만원 이상의 진료비 마련의 어려움)
- 입원내용 등에 대한 개입, 개입결과 및 평가

4) 평가 및 한계

- 급성 골수성 백혈병으로 조혈모세포이식을 필요로 하고 있는 상황
- 비용의 어려움이 있어 스스로 방문하여 개입하게 된 사례
- 한국복지재단에 의뢰하여 지원여부 결정 될 수 있도록 개입할 계획
- 급성중수돌기염으로 입원하였고, 항암치료 후 이식을 위한 입원예정이었으나 재발 확인되어 재 항암치료 실시
- 환자의 상태변화로 인해 한국복지재단이 아닌 부산공동모금회와 라디오 모금 방송에 의뢰
- 상황변화로 의뢰초기 사정되었던 경제적인 어려움이 더욱 크게 부각됨
- 재발로 인해 환자 및 가족들의 심리·사회적인 상실감과 치료에 대한 부담감 가중된 사례

1. 화상환자의 심리적 상황

1) 화상환자의 심리적 상황

- 사람은 보통 돌발적으로 화상을 입는데, 이때 그는 자기가 괴멸할지도 모른다는 극심한 불안을 겪음
- 그 뒤에는 심한 동통이 따르고 심한 생리적 균형상실을 겪으며 생사가 왔다 갔다하는 위험에 처함
- 화상환자는 생존의 위협, 동통과의 싸움, 신체손상 추형가능성과의 싸움이 화상 환자가 겪는 근본적인 심리상황임
- 입원 중 화상의 부차적인 심리상황은 화상 자 체에서 오는 고통 외에 부차적 문제로 고통을 겪게 됨
 - 감정이 격해짐
 - 가족 친척과의 격리가 됨
 - 화상이 장차 그의 인생에 미칠 영향을 걱정함
 - 부적절감이 옴
 - 성문제로 고민함
 - 가족친지나 주위사람에게 냉대 받지 않을까 걱정함
 - 적개심이 생김

2) 심리적 경험과 상황문제 유발요인

- 환자와 가족과의 관계
- 평소에 스트레스를 어떻게 다루고 해소해 왔는가의 양상에 따라 다름
- 화상을 입게 된 경위에 따라서 다름
- 사고 나기 전부터의 정신병리의 유무에 따라 다름
- 의료진과 가족이 환자를 대하는 태도에 좌우됨

2. 중화상 환자의 심리·사회적 문제와 의료사회 복지 서비스

1) 치료 초기의 심리 사회적 문제

- 신체적인 면
 - 환자는 화상으로 인해 체액상실, 전해질불균형이 와서 생리적 쇼크 상태로 빠지고 그 응급치료로서 괴사조직체제거, 절단, 기관절개술 등이 필요한 시기

■ 정신적인 면

- 해리현상이 왔다가 곧 급성 외상성 반응을 보이는 시기로 때로는 섬망 태까지로 발전
- 해리상태
 - 화상직후, 무슨 일이 일어났는지 잘 파악 못하는 상태로서 의식은 깨끗해서 말은 잘 하지만 뒤에 가서 이를 기억 못 함
- 급성 외상성 반응
 - 외상에 대한 심리적 반응으로 과격한 경악반응, 불면증, 화상 장면이 나오는 악몽이나 감정 동요가 있음
- 섬망
 - 꼭 치료초기만 오는 것이 아니라 피부이식을 받던가 새 피부로 덮일 때까지 있다 없다 함
 - 증상으로는 지남력장애, 인지기능장애, 의식의清明과 혼탁변화, 불면증, 환각, 심한 불안 등

2) 치료중기의 심리·사회적 문제

■ 환자의 상태가 어느 정도 안정되어 수 주일, 수개월간은 화상 당한 자리에 피부이식을 여러 차례로 받은 시기로 환자가 희망과 낙담 사이에 왕복하는 시기임

■ 환자가 이러한 상태에서 심리 사회적 적응을 해야 하는 어려운 과업을 갖게 됨

■ 화상환자가 흔히 쓰는 적응기제

- 억제
 - 화상이 어느 정도인지 알지만 더 이상 그것을 생각 않기로 하자라는 심정
- 억압
 - 화상 정도를 보고 들어서 알았지만 불리한 정보는 무의식에 넣었기 때문에 뒤에 다시 물어보면 기억 못함
- 수축
 - 모든 감정을 굳건히 자제 제어함으로써 의식에 들어오는 모든 자극을 극소화시킴
- 퇴행
 - 좌절하여 인내력이 떨어지고 애기처럼 요구하고 투정이 늘고 의존심이 커짐
- 부정
 - 화상자체를 부정하여 대단한 것으로 여기지 않는 심리

■ 치료중기에서의 심리 사회적 문제로서 중요한 것

- 동통
 - 동통을 참는 능력은 개인차가 큼
- 불안과 두려움
 - 중화상자는 불안해하고 두려움에 떨
 - 증상 : 초조, 긴장, 동공확장, 불면증, 악몽, 피로감, 신경질, 식욕감퇴, 동통에 관한 과민성

- 분노와 적개심
 - 자신의 화상에 대한 분노가 모든 중화상자에게 있음
- 우울
 - 우울증은 화상환자에게 나올만한 증상임
 - 원인 : 용모, 신체 일부, 피부를 잃었다는 데서 오는 애도반응, 동통, 신체손상, 의존성, 불안, 두려움, 신체 제어능력상실, 죄책감, 일생에서 즐거움을 상실, 전부터 있던 우울증이 심해짐
- 퇴행
 - 환자의 퇴행은 현재의 스트레스가 견디기 어려워 어린 시절의 심리상태로 돌아감

3) 회복기의 심리 사회적 문제

■ 현실적이고 객관적인 문제에 직면

- 자기상의 변화와 주체성의 위기
 - 외모변화
 - ☞ 자기의 외모가 변한 것에 대해 입원 중부터 알기는 하나 퇴원을 해보면 묘한 균형이 깨짐
 - 대인관계의 변화
 - ☞ 부모인 환자와 오래 떨어졌던 애들은 그것 때문에 서먹서먹해 하는데다 흥해서도 환자를 못 본 척 하거나 주춤거림
 - 자체불편
 - ☞ 환자는 회복을 기다리는 처지라 직장에 영영 못 나갈 수도 있고 전직해야 할 경우도 있음
 - 심리적 반응
 - ☞ 회복기 환자는 심리적으로 여러 고통을 겪음
 - ☞ 독립성회복에 따른 불안, 외상신경증상태, 공포신경증도 올 수가 있음

4) 치료 초기의 의료사회 복지 서비스

■ 중화상자의 심리, 사회적 문제는 다음사항을 고려하여 원조하는 것이 일반적임

- 의료진을 신뢰케 함
- 환자와 의사소통을 잘해야 함
- 독방보다는 여러 사람이 같이 쓰는 방에 환자를 둠
- 가족은 환자의 심리적 측면에서 유의하여야 함
- 환자에게 병 상황에 따른 치료상의 자율권을 주는 방향으로 함
- 전화상 환자를 병실로 방문토록 함

5) 치료중기의 의료사회복지 서비스

- 정신적 동통을 적게 하기 위하여 환자 옆에 앉아서 생활사를 들어주고 파악해서 그를 이해하고 위로, 격려함
- 불안과 두려움, 분노와 적개심 문제는 환자가 느끼는 것이 무엇인지를 자세히 묻고 이야기하게 하도록 하여 발산케 함
- 퇴행 환자는 왜 퇴행하는지 그 이유를 이해해야 함
- 환자와 가족을 위한 의료사회복지의 역할
 - 심리적 지지를 위한 개별사회사업과 가족관계를 파악하여 가족과 환자간의 역동적인 심리과정에 병의 치료에 장애가 되지 않고 오히려 촉진 시킬 수 있도록 조성, 환자의 상처나 치료과정에서 겪는 심리적 과정을 잘 통과할 수 있도록 돕고, 퇴원 후, 재활에도 개입하여 자신의 신체적 조건을 받아들이게 정서적 지지와 강화를 주어 장애를 극복하고 사회에 적응토록 도움

3. 성인 화상환자와 그 가족의 개입사례

1) 성인 화상 환자

■ 인적사항

성명	김00	성별	남자
나이	43세	생년월일	1959년 2월 6일
의료보장	의료급여 1종	직업	없음
주소	충북 제천시 000		
연락처	041-***-****	정보제공자	부모, 조부모
교육수준	고졸	종교	없음
주거	무료임대 방 1칸	결혼여부	미혼
진단명	화염화상 18%	주치의	일반외과 김00 교수

■ 의료적 상황 및 의료경위

- 가스폭발 화재로 환자는 얼굴과 손에 18% 화염화상을 입었고 부인은 5%, 첫째 아들 25% 둘째 아들 70%의 일가족 모두가 화상을 입었음
- 일가족의 화상치료와 피부이식수술을 위한 치료비 마련을 위해 주치의로부터 의뢰되어 개입
- 첫째 아들
 - 사고 이틀 만에 사망
- 둘째 아들
 - 4차례 피부이식수술을 받고 향후 얼굴과 손, 목에 기능성형수술이 남아있는 상태
- 부인
 - 2주일 정도 화상치료를 받은 후 퇴원, 환자는 피부이식 수술 1회 받은 후 얼굴과 손에 화상 흉터가 심하게 남아있었음

■ 제시된 문제

- 치료초기

- 경제적 문제
 - ☞ 환자와 아들의 치료비를 마련하기 못하고 있었음
- 심리·사회적 문제
 - ☞ 가족들은 안정을 위해 첫째 아들의 사망소식을 숨기고 있었고, 환자가 향후 받게 될 심리적 충격에 대해 걱정하고 있었음

- 치료중기

- 심리·사회적인 문제
 - ☞ 얼굴과 팔에 심한 화상흉터걱정, 큰아들 사망소식, 위독한 상태에 있는 둘째 아들에 대한 걱정, 고부갈등을 참지 못하고 이혼을 제안하는 부인에게 실망함

- 치료후기

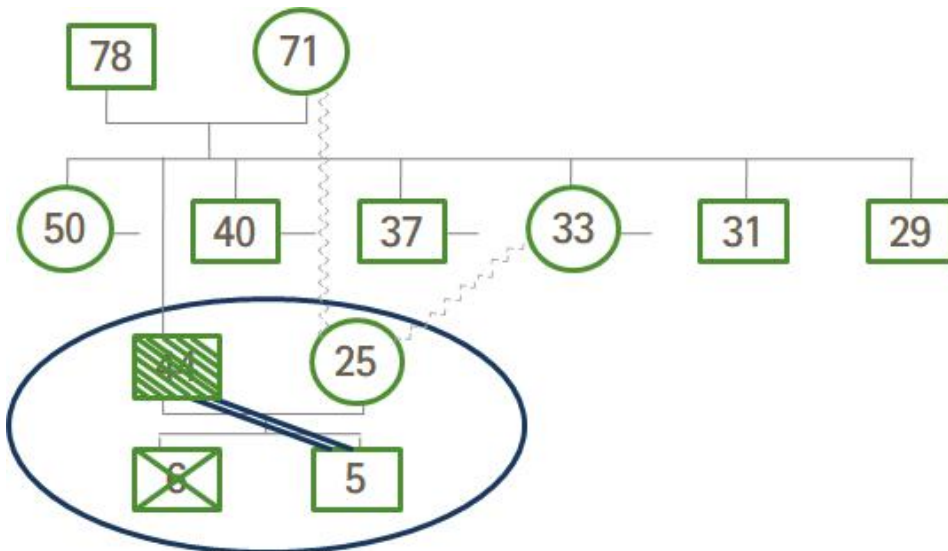
- 사회복귀 및 재활문제
 - ☞ 환자와 둘째 아들은 화상 흉터와 반흔구축으로 인한 장애를 입고 퇴원하는데 대한 두려움, 퇴원 후 거처에 대한 걱정

■ 개인력

- 환자 : 44세 남자, 7남매 중 둘째로 장남, 부인과 두 아들, 학력은 고졸, 농사지으며 생계유지, 결혼적령기를 놓치고 뒤늦게 어린 부인과 결혼, 성격이 너그러워 동네사람들로부터 칭찬을 많이 받았고, 최근 부인의 카드 빚 때문에 부부갈등 심화

■ 가족배경

- 지노그램



- 가족구성원

- 부인

- ☞ 25세 고졸, 농사, 1남 1녀의 막내, 결혼 전 10대에 낙태한 경험이 여러 번 있음, 밝고 명랑한 성격이지만 타인에게 신뢰를 주지 못하는 편, 지출이 심하여 빚이 많고, 타인의 비난에 방관자적인 태도, 치료초기에 혼자 경한 화상을 입은 데 대한 시댁식구들의 비난을 많이 받음

- 첫째아들

- ☞ 6세 사고 이틀 후 사망

- 둘째아들

- ☞ 5세, 화재사고로 화염화상 70%의 중화상 입음, 2개월간 중환자실에서 위독한 상태, 피부이식수술 5 차례 받았으며 팔, 다리 일부를 제외한 전신에 화상흉터 있음

- 아버지

- ☞ 78세, 오랜 농사일로 노환이 심함, 오래 전 허리 다쳐 후유증 심함

- 어머니

- ☞ 71세, 당뇨, 고혈압, 심근경색으로 보건소에서 약을 타다 먹는 상황

- 누나

- ☞ 50세, 언어장애인, 남편 또한 언어장애인

- 남동생

- ☞ 40세, 1남 1녀의 자녀와 함께 대구에 살고 환자 가정이 힘들 때 달려와 도와줌

- 남동생

- ☞ 37세, 화물차 기사 1남 1녀를 양육, 간경화로 입 퇴원 반복

- 여동생

- ☞ 33세, 3,4개월째 남편이 일자리를 찾지 못하고 있어 경제적으로 힘든 상황

- 남동생

- ☞ 31세, 미혼으로 제천에서 홀로 거주 무직

- 남동생

- ☞ 29세 막내 미혼으로 노동 일하며 혼자 생계유지

- 가족역동

- 환자의 가정은 농사적자로 생계난이 가중된 상태에서 부인의 과잉지출로 카드 빚이 늘어나고 있는 상태였음
- 친가와 같은 동네에서 살고 있어 경제적으로 많이 의존되어있음
- 부인의 나이가 어리고 미숙한 행동들이 많은 비난을 받았고 고부간의 갈등도 깊었음

■ 경제적 배경

- 의료보장형태
 - 의료급여 1종
- 주거상태
 - 무상임대 방 1칸
- 수입상태
 - 월 100만원 정도(농사적자로 비정기적인 수입임)
- 부채상태
 - 부인의 카드 빚 영농대출자금 등
- 진료비 마련방법
 - 한국복지재단 2,000만원 후원금과 동네 이웃들의 성금, 방송을 보고 관할 시에서 환자의 치료비를 돕겠다고 제안

2) 사회복지 문제사정

■ 확인된 문제

- 경제적 문제
 - 사고 전부터 농사적자로 생계난 가중, 친지를 모두 동원해도 3명 치료비를 부담 할 수 없음
- 심리 사회적 문제
 - 첫째 아들 사망, 둘째 아들 중화상으로 위독한 상태
 - 부인이 고부갈등을 견디지 못하고 환자에게 이혼을 제안하여 가족해체의 위기를 느낌
- 사회복지 및 재활문제
 - 환자와 둘째 아들이 화상으로 인한 외모손상을 입고 퇴원을 준비하는데 대인관계의 어려움을 겪고 있었고 집이 전소되어 퇴원 후 거처가 마련되지 않음

■ 문제해결을 위한 환자 및 가족의 강점

- 환자가 가장으로서의 책임의식이 크고 자녀사랑 극진한 점
- 환자와 환자의 부인이 형제가 많아 가족의 정서적 지지를 받을 수 있음
- 일가족이 화상을 입었고, 특히 5살 둘째 아이가 중화상을 입어 언론을 통해 후원지지체계 마련용이

3) 사회복지 개입단계

■ 계약내용

- 환자와 가족의 치료비 마련을 위하여 방송출연을 통해 후원기관의 지원받음
- 환자가 겪는 심리사회, 정서적인 문제를 해결하기 위해 지속적인 면담을 함

■ 개입목표

- 장기목표
 - 환자와 가족이 화상치료를 받고 건강한 모습으로 퇴원 할 수 있도록 지원
- 단기목표
 - 외부 후원기관 연계하여 환자와 가족의 치료비를 지원함
 - 환자가 화상치료 회복기에 겪는 심리적인 문제에 대해 정서적으로 지지를 함
 - 가족갈등으로 야기된 가족해체의 문제를 부부상담을 통해 해결책을 모색함

■ 개입계획

- 한국복지재단 사랑의 리퀘스트에 환자와 가족의 진료비 지원요청
- 환자와 주 1회 정서적인 지지상담실시
- 환자와 환자의 부인과 함께 부부상담 실시

■ 개입과정

- 경제적인 문제 해결을 위한 개입
 - 환자 가족이 동원할 수 있는 자원을 격려하여 자부담 500만원을 마련
 - 환자 거주지 관할 동사무소 사회복지 전문요원에게 기초생활 보장 수급 대상자로 선정협조
 - 한국복지재단에 후원의로 방송 출연하여 2,000만원의 후원금 받음
 - 방송을 본 이후 동사무소 사회복지전문요원을 주축으로 모금운동 1,000만원 모금
 - 방송 후 지정후원 희망하는 후원자가 있어 개인통장으로 500 만원입금
 - 방송 후 관할 시에서 환자의 둘째 아들 치료비를 지속적으로 돕겠다고 제안
 - 입원 기간 동안 모금된 후원금으로 환자 1회 수술 둘째 아들 5회 수술받고 퇴원, 남은 후원금으로 성형외과적인 2차 수술을 예약
- 환자가 회복기에 겪고 있는 심리적인 문제에 대해지지 상담하는 개입
 - 화재사고의 장면재연 감정적인 두려움과 불안을 표현하도록 도움
 - 첫째 아들을 잃은 상실감에 대한 충분한 표현과 아버지 나름대로의 장례식 치르도록 권유
 - 외모손상으로 인해 처음 붕대를 풀 때 거부감이 심하여 치료과정임을 설명하고 격려함
 - 과거와 현재를 분리하도록 하고 어쩔 수 없는 사고였음을 받아들일 수 있도록 설득
- 가족해체의 문제와 퇴원 후 거처문제의 해결책을 모색하기 위해 부부상담 개입
 - 부인이 고부간의 갈등으로 인해 환자에게 이혼을 요구 이로 인하여 크게 낙담한 환자의 걱정을 충분히 표현하도록 함
 - 아들 양육과 남편의 간병을 포기하고 이혼을 요구하는 부인의 어려운 심정을 표현함
 - 부부 간 개별 면담을 통해 발견된 가정을 다시 꾸리려는 의지를 매개로 부부상담 권유
 - 부부가 갈등으로 의사소통이 단절, 부부간 대화를 부부상담을 통해 실시
 - 사회복지사는 이웃 사람들의 원조손길을 모아 독립된 공간에 새로 집을 장만, 퇴원 후 거처문제 지원

■ 종결 및 사후관리

- 둘째 아들이 다섯 차례 피부이식 수술 후 70% 중화상의 어려운 치료과정을 잘 이겨내면서 호전을 보이자 환자와 부인, 둘째 아들 핵가족중심으로 응집력이 생기는 것을 확인 하고 종결 퇴원 전까지 2주에 한번 병실방문을 하며 사후관리, 향후 성형외과적 수술을 위해 재 입원 시 사후 관리 할 필요가 있음

4) 평가

■ 환자와 가족의 평가

- 환자와 가족은 치료비 후원으로 풍부한 치료를 받을 수 있게 해준 데에 대해 감사하고, 환자와 가족이 입원 치료를 받는 동안 겪는 다양한 걱정거리에 대해 들어주고 해결책을 같이 모색해 주어 힘이 되었다는 긍정적인 평가를 함

■ 의료 사회복자사의 평가

- 환자와 가족이 원하는 방향으로 노력할 수 있도록 격려하고 지지하는 개입이었으며 부부 간의 문제를 충분히 직면시키고 가족치료적인 개입을 하지 못한 아쉬움이 남음

1. 발달장애아동과 미숙아동의 발생양상

1) 발달장애의 유형과 원인

- 발달장애란 "22세 이전에 발생하고, 장애가 심각하고, 진행되는 장애를 가진 사람들에게 초점을 두고, 주로 정신지체 영역에서 도출된 포괄적인 것
- 발달장애의 유형
 - 미국 연방법 : 정신지체, 뇌성마비, 간질, 자폐증, 기타 신경학적 장애
 - Ehlers 등 : 정신지체, 자폐증, 뇌성마비, 뇌기능장애 감각장애, 간질
 - 뇌기능장애는, 과잉행동, 산만성, 충동성 지각-운동손상, 학습곤란, 말과 청각장애, 반사회적 행동, 신경학적 장애 등으로 구분
- 발달장애의 원인
 - 유전적 요인
 - Down's Syndrome, 약제 X 증후군, Phenylketonuria(PKU), Tay-Sachs 질환 포함
 - 환경적 요인
 - 뇌염, 뇌막염, 풍진, 태아 알코올 증후군, 납중독, 영양부족, 학대 등
 - 출생 전 요인
 - 산모의 일반적인 건강상태, 산모의 다이어트 등에 의한 영양실조, 홍역, 임질, 만성빈혈, 임신부의 알코올과 약물복용, 흡연, 산모의 정서 상태, 산모의 연령, 방사선 노출, RH 인자의 부적합, 신진대사이상, 염색체 이상 등
 - 출생 시 요인
 - 조산과 난산에 의한 저체중, 호흡곤란, 산소결핍, 무산소증 등이 뇌세포 손상, 두개내출혈, 운동신경 장애 등 유발
 - 출생 후 요인
 - 질병 또는 중추신경 감염, 사고, 학대, 지적 자극의 부족, 심리사회적 불리요건 등

2) 미숙아의 주요 발생률과 발달양상

- 미숙아의 주요 장애발생률
 - 생존 영아 중에는 중추신경계손상과 발달장애를 보이는 비율이 정상적으로 출생한 아동에 비해 훨씬 높음
 - VLBW 아동의 반 이상이 지능이 평균 이하이며, 학령기에 1/4이 심하게 지체
 - 1978년~1980년 사이에 출생한 VLBW 아동 중 뇌성마비 9%, 정신지체 8%, 학습장애 19%
 - 1980년대 초, 중반에 출생한 미숙아 중 25% 이상이 뇌성마비, 정신지체, 맹 등의 장애들이 복합되어 나타남

■ 미숙아의 정의

- 출생체중이 2,500gm 이하이거나 재태기간(임신기간)이 37주 미만인 경우를 통칭하여 미숙아라고 정의함

■ 미숙아의 원인

- 산모
 - 태반이나 자궁의 이상과 임신중독증, 만성 질환, 감염 및 약물남용
- 태아
 - 쌍둥이를 임신한 경우 임신 중 태아 자체의 여러 가지 질환(염색체 이상 감염 등)
- 기타
 - 산모의 흡연 염산섭취 부족, 양수가 미리 터졌을 경우

■ 미숙아에 발생하는 문제점

- 간기능
 - 황달 발생
- 체온조절기능이 제한
 - 저체온과 고체온에 빠지기 쉽기 때문에 보온이 중요함
- 면역체계가 약함
 - 병원체에 감염될 위험이 만삭아에 비해서 높음
- 장 운동 소화기능 미숙
 - 튜브로 젖이나 우유를 넣어 주거나 혈관으로 영양공급
- 폐기능 미숙
 - 호흡곤란증후군 발생

■ 미숙아의 발달양상

- 자기통제
 - 방해를 받으면 진정이 되지 않음
- 주의
 - 엄마에게 집중하지 못함
 - 계속 반응을 요구하면 쉽게 지침
- 운동신경계
 - 근육을 떨거나 경련을 일으킴
 - 다리를 점
 - 제대로 서지 못함
- 생리적 현상
 - 아기의 피부색이 쉽게 변함
 - 호흡이나 맥박이 불규칙함
 - 쉽게 먹은 것을 토함

3) 발달장애아에 대한 효과적 개입

- 효과성에 대한 논쟁 : 3세 미만의 아이와 가족개입
- 효과적인 초기개입의 구성내용
 - 일상사회 관계에서의 사회적인 예상의 만남(적응행동)
 - 배움에 관한 자발적인 관심
 - 대인관계의 발달(아이-부모의 상호작용)

4) 발달장애아에 대한 초기개입

- 다학제간 팀에 의한 접근
 - 팀에서 사회복지사는 심리사회적 평가, 중재자, 지지자, 사정, 퇴원계획, 케이스 매니지먼트, 개인상담, 집단상담, 보호와 옹호, 교육, 직·간접적 가족 서비스 조정, 제공 및 가족지지 등의 역할
- 개별화된 가족중심 서비스 제공
 - 아이와 가족기능에 적합한 개별화된 가족중심 서비스가 지속적인 제공될 수 있도록 함
- 구체적 개입활동 내용
 - 부모-아이의 상호작용 경향파악, 가족과 아이에게 특별한 지도와 교육을 위해서 생활 실태조사를 위한 가정방문 수행
 - 가정환경 안에서 아이의 심리·사회적 발달사정 수행
 - 가족 기초육구와 가족기능 상에서 발생하는 문제와 관련된 서비스 사정과 제공 아동학대 조사
 - 개인 그리고 가족상담
 - 아이와 부모의 사회기술 훈련과 부모지지집단 등과 같은 가족서비스 계획과 실행
 - 가족지지자원을 확인, 동원, 연결
 - 가족을 돕기 위해 필수적인 사회체계 조정
 - 집, 학교, 지역사회 사이 연계를 용이하게 함
 - 위험에 대처 요소들과 지지, 지역사회 자원 평가
 - 가족 권리를 위해 옹호하고 지역자원에 접근을 용이하게 함
 - 정보 제공과 가족과 전문가에게 교육
 - 변화 계획을 세우는 것을 도움
 - 사정 그리고 평가 팀에게 가족 연락/접촉 또는 교섭협상자 역할수행
 - 가족의 쟁점에 따른 다른 전문가 집단과 상담연계
- 발달장애 초기개입의 원칙
 - 발달장애의 의학적 측면에서의 지식은 회송 자원, 가족체계를 사회복지사가 가족들 서비스 욕구 안에서 효율적으로 도달할 수 있도록 함
 - 임상에서 사회복지사는 발달장애를 가진 아동으로 인해 발생하는 스트레스로부터 가족과 부부문제/관심을 다루는 준비를 하며, 환경적 위험요소와 가족의 대처능력 정도를 파악 후, 가족에게 적합한 서비스를 조정하고 가족이 조정된 서비스를 결정할 수 있도록 함

- 사회복지사는 서비스 조정자로서 가정 방문하는 동안 아이 진행 상태와 가족기능을 평가하고 가족이나 보호자에게 적합한 개별화된 가족서비스를 수정하여 제공함
- 사회복지사는 아이들과 가족들이 자연스럽게 상태가 진행될 수 있도록 초기개입 서비스(0-3세)부터 취학 전 서비스(3-5세)의 발달을 만들도록 하는 모임에 지속적이고 효과적인 서비스를 가지고 참여할 수 있어야 함
- 사회복지사들이 초기개입서비스를 제공하는 다른 기회는 아동복지기관과 지역정신보건센터를 통해서임

■ 초기개입의 모델 : 생물심리학 모델

- 생물심리학 모델은 생물적 심리적 개인, 가족, 그리고 사회체계와 이러한 체계들 사이 관계의 상호의존적 정보 포함 → 사회복지사가 복합적 요인을 가지고 있는 영역에 개입하는데 있어 유용

5) 근본적인 문제와 훈련전략

근본적인 문제	훈련전략
▪ 전문적인 훈련경험이 없는 외람된 능력주의 ▪ Social Work 커리큘럼에서의 초기 개입문제의 관심 부족	▪ Multimethod - 필수 기초지식, 기술 인원 - 설계에 있어서의 Multy, Interdisciplinary

2. 미숙아동과 그 가족의 개입사례

1) 미숙아동 사례

■ 개요

- 미숙아동이 영 유아기에는 별다른 반응을 보이지 않다가 학령기에 이르러 여러 가지 학습이나 행동상의 문제가 나타날 수 있음
- 그러므로 부모에게 이런 아동들이 성장하면서 나타내 보일 수 있는 여러 가지 손상이나 발달상의 문제들에 대한 충분한 정보를 주어야 함
- 또한 부모들에게 아동의 발달이 정상적으로 이루어지고 있는지를 계속해서 정기적으로 점검하도록 알려주어야 함
- 그래야만 문제가 발생하는 즉시 조기중재가 이루어져 발달상 문제를 예방하거나 최소화할 수 있을 것임
- 일반 사항

	환자	보호자
성명	무명	이○○
나이/성별	생후1개월/M	19세/F
주소		서울시○○구○○동
학력		고졸
종교		기독교
직업		무직
결혼상태		미혼모
경제상태		不
주거형태		월세 (보증금 3,000만원, 월 10만원)
보험유형		건강보험
입원일	3월3일(출생)	3월3일
퇴원일		3월5일 (*퇴원사유 : 입원비용부담)
진단명	미숙아 (27+4주의 임신기간에 983g으로 출생)	갑상선
의뢰경위	3월 4일 NEO에서 향후 환아의 양육의 문제로 의뢰됨	
주정보제공자	Pt의 외조모	

■ 개인력(History)

- 미혼인 이씨(환아의 어머니)는 2001년 12월 초 몸에 이상을 느껴 동네 병원에 가서 임신 4개월이라는 사실을 알게 됨
- 환아 부에게 임신 사실을 알리자, 환아 부는 낙태시키라며 크게 화내고 그 후, 연락 두절됨
- 예기치 않았던 일로 당황스러웠던 환아 모는 낙태를 하려고 하였으나, 몸이 매우 약하고, 갑상선이 있어 동네 병원에서는 수술이 어렵다며, 큰 병원으로 가라고 하자, 겁이 나서 임신사실을 숨기고 지내왔음
- 임신 6개월에(출산 5일 전), 환아 외조모가 임신사실을 알게 되었고, 낙태를 하기 위해 본원에 왔으나, 산모의 건강문제(갑상선, 혈압) 때문에 유도분만으로 환아를 낳을 수밖에 없었음

■ 의료 경력(Medical History)

- 환아는 3월 3일 27+4주의 임신기간에 983g으로 출생하여, 미숙아 진단을 받았으나, 다른 미숙아에 비해서는 비교적 건강한 상태로 인공호흡기도 빨리 제거할 수 있었음
- 그러나, 생후 10일 후(3월 13일) 폐에 이상이 발생하여 인공호흡기를 다시 설치하였으며 3월 25일 현재 혈중 치료를 마친 상태로, 수일 이내에 퇴원하여 외래 추후 관찰예정임

■ 경제적 상태(Economic State)

- 수입
 - 없음(환아 외조모 약 월 90만원)
- 주거
 - 월세(보증금 3,000만원, 월 10만원)
- 자산
 - 환아 외조모가 운영하는 작은 꽃집(월세: 보증금 500만원, 월 30만원)

■ 가족 상황(Family Situation)

- 가족배경
 - 현재 환아의 출생사실은 환아 모, 외조모, 이모만 알고 있고, 환아 부와 외조부, 삼촌은 환아의 출생사실을 전혀 모르고 있음
 - 환아 모 : 만 19세의 미혼모, 무직
 - ☞ 현재 잠도 잘 자고, 앞으로 잘 대처할 수 있으며, 환아가 빨리 입양되길 바람
 - ☞ 환아 출생 이후 한 번도 환아를 본 적이 없고, 환아에 관해서는 성별이 남자라는 것 이외에 전혀 정보가 없으며, 관심도 표시하지 않음
 - ☞ 환아의 병원비 걱정을 하고 있고, 환아가 빠른 시일 내 입양되기를 바라고 있으나 입양관련 정보에 대해 전혀 통찰(insight)이 없음
 - ☞ 모 자신의 건강상태도 출산 이후 악화되어 예민해져 있는 상태이며, 환아 부와의 관계에 대해서는 전혀 언급을 피하고 있음
 - 환아 부 : 만 25세 미혼, 무직
 - ☞ 환아의 임신 사실을 알고, 크게 화를 내며 낙태하라고 한 후 연락두절 된 상태로, 현재 환아의 출생사실을 모르고 있음
 - 환아 외조모 : 꽃집운영
 - ☞ 환아 모에게 환아와 관련된 사항은 말하지 말아달라고 부탁하며, 환아와 환아 모를 매우 안쓰러워 함
 - ☞ 가정에서 실질적 가장 역할을 하고, 환아의 출생에 대해 식구들에게 비밀로 하고 있음
 - ☞ 환아와 관련된 모든 사항을 직접 처리하고 있으며, 현재 환아의 병원비용 부담이 매우 큰 상태임
 - 환아 외조부 : 무직
 - ☞ 환아의 출생사실을 전혀 모르고 있으며, 환아 외조모에 따르면, 외조부가 환아의 출생 사실을 알게 되면 병원치료도 받지 못하게 할 것이라고 말함
 - 환아의 이모
 - ☞ 환아의 출생사실에 대해서는 알고 있지만, 그 사실에 관련해서는 전혀 언급하지 않으며, 빨리 환아가 입양되길 바라고 있다고 함

2) 사회복지문제와 개입계획(Main Problem & Plan)

Main Problem	Plan
■ 현재, 환아의 치료비 및 입원비에 대한 보호자 부담이 커서 환아의 계속적인 입원치료를 거부하려 함	■ 입양 및 입양기관에 대한 정보제공 ■ 보건복지부 '미숙아 의료비 지원사업' 연결

3) 사회복지 개입과정(Intervention Process)

수행 월/일	수행내용	수행결과
3/4		
3/11	■ 환아 보호자와 환아 외조모와 함께 사회복지팀 방문	■ 홀트에서 환아 건강 상태 진단 후, 입양가능 평가하기로 함
3/12		■ 주치의가 환아 건강상태 악화로 약 2주 관찰하고 상태 호전된 후, 소견서 작성하기로 함
3/21	■ 거주지관할 보건소에 보건복지부 '미숙아 의료지원 사업' 수혜가능여부에 대해 문의, 절차 확인 후	■ 환아 외조모가 이씨가 미혼모라는 사실이 밝혀지는 것을 우려하여 거부함
3/26	■ 환아의 건강상태가 안정되어 홀트에 진단소견서 송부함	■ 홀트에서 환아의 몸무게가 1500g~1,600g 이상이 되어야, 입소 가능하다고 함 ■ 1,500g 이상된 후, 다시 의뢰하기로 함

4) 사회복지사의 평가(Social Worker's Comment)

- 본 사례는 미혼모가 낳은 미숙아의 입양시설 연계와 관련된 것으로, 미혼모, 입양문제, 미숙아와 향후 성장 후 문제에 대해 생각해 보게 하는 사례였음
- 대부분의 미혼모들은 심리적 불안과 경제적 이유, 가족으로부터 이탈로 보건의료서비스에 쉽게 접근할 수 없고 건강을 해치게 되는 경우가 많음
- 하지만 이 사례에서는 이씨(미혼모)의 어머니가 이씨를 이해하고 감싸려는 마음이 강했고, 가족들에게 이씨의 출생사실을 비밀로 함으로써 이씨가 가족으로부터 이탈되지 않을 수 있었고, 이씨도 필요한 의료 서비스를 계속 받을 수 있었음
- 반면, 어머니의 조심스런 마음이 이씨 본인과 접촉을 어렵게 하여, 이씨가 표현하지 못하고 있는 심리적 불안감에 대한 개입이나 정보제공은 차단될 수밖에 없었고, 환아에 대한 무관심이 지속되었음
- 특히, 환아에 대한 관심결여와 방임은 성장과정에서 여러 가지 문제를 유발시킬 수 있을 것

척수손상 / 14주차 2차시

1. 척수손상환자의 손상부위와 적응과정

1) 척수 손상부위별의 재활기능과 적응과정

■ 척수

- 중추 신경계의 일부분으로 신체와 뇌 사이의 주요 전달 통로(운동신경 & 감각신경이 오고 가는 통로)
- 척추의 가운데로 지나가며 척추에 의해 보호
- 사고나 질병에 의해 척수 손상 ⇒ 뇌와 신체 사이의 신경전달 손상
⇒ 감각 소식, 자율신경계에 의해 조절되는 방광과 장의 조절 손상

■ 척추

- 31개 마디의 뼈들로 구성
- 경추(7개), 흉추(12개), 요추(5개), 천추(5개), 미추(1개)
- 사지 완전 마비에서 하지의 부분 마비 등으로 장애의 정도 다양

미국척수손상학회 척도	손상 정도
완전 손상(Complete)	손상 척수 이하 부위의 운동감각 신경계의 완전한 손상(흉추 1번 이상-사지마비, 1번 이하-하지마비)
감각만 있음 (Sensory only)	운동신경계는 완전한 마비이며 손상척수 이하 부위에 감각신경기능만 유지된 손상
운동기능은 있으나 쓰기 어려움 (Motor useless)	운동기능은 있으나 실질적으로는 사용하기 어려운 정도의 손상
운동기능이 사용 가능함 (Motor useful)	손상척수 이하 부위의 운동 기능도 유지된 손상
회복(Recovery)	신경학적 증상 없음(위약, 감각 소실, 괄약근의 기능장애는 없으나 비정상 반사는 있을 수 있음)

■ 뇌 손상 부위별 재활 기능

- 경추 4번
 - 호흡가능, 상지의 운동 없음
- 경추 5번
 - 식사가능, 전동 휠체어 사용
- 경추 6번
 - 일상생활이 보조기 이용해 가능, 휠체어 밀 수 있음
- 경추 7번
 - 혼자서 침대에서 휠체어로 이동 가능, 혼자 생활 가능

- 경추 8번, 흉추1번
 - 거의 휴추 장애인과 비슷한 정도로 독립생활 가능

- 마비신경손상
 - 1년 반에서 2년에 걸쳐 회복됨, 대개 목발 보행 가능

■ 척수손상 부위에 따른 기능 장애(보충)

- 근 기능은 척수 레벨에 따라 작용하기 때문에 손상 부위에 따라 기능 수행능력이 다름
- 척수손상 위치와 정도를 결정하면 궁극적인 기능 회복 정도를 예측할 수 있으므로 환자 훈련과 교육 목표를 설정할 수 있음
- 경추부 혹은 상위 흉추부 척수손상이 있는 환자는 보행연습을 열심히 시켜도 결국은 휠체어를 이용해야 하는 것이 필연적이므로 처음부터 무리한 기대는 버리고 현실적인 목표를 설정하는 것이 바람직함
 - 물론 보행 연습의 목적이 꼭 단순히 걷게 하려는 데만 있는 것은 아님
- 제4경추(C4)
 - 상지 및 하지의 수의적 기능(Voluntary Function)은 거의 불가능함
- 제5경추(C5)
 - 삼각근과 이두박근의 사용이 가능하여 어깨 일부의 기능이 있으나, 전반적으로 자기 관리의 능력과 침상동작 능력도 없고 기능이 결핍된 상태가 됨
 - 약해진 근육을 지지하기 위해서 'Feeder'가 필요하게 되며 영구적 'Feeder'가 필요하기도 함
 - 손의 기능을 대신하기 위해서 조절 가능한 보조 장치로 부분적으로 동작을 도울 수 있으며, 전동 휠체어를 이용할 수 있음
 - 일상생활이나 이동을 위해서는 항상 돌보는 사람이 있어야 함
- 제6경추(C6)
 - 제5경추 환자의 경우보다 손목 기능을 사용할 수 있으며, 간단한 가죽밴드와 같은 수부 보조기구(Hand Device)를 이용해서 찢술이나 손가락 등을 이용할 수 있음
 - 몸을 뒤집거나 힘들지만 침대에서 앉을 수 있고, 평평한 곳에서는 휠체어를 조작할 수 있으며 한 근육을 이용해서 작동하는 전동 휠체어(Electric Wheel Chair)나 자동으로 움직이는 전기 기구를 사용하여 일상생활동작에 보조를 받음
 - 손을 이용하는 집안일을 하기가 힘들기 때문에 이들도 역시 돌봐주는 사람이 있어야 함
- 제7경추(C7)
 - 어깨와 상지의 기능이 부분적이거나 가능함
 - 환자는 몸통 올리기(Push-Up)를 할 수 있으므로 혼자서 침대에서 휠체어나 의자로 옮겨 갈 수 있으며, 휠체어를 밀고 가는데 불편이 적음
 - 보다 편리하게 해 주려면 고무테이프 같은 마찰력이 있는 것을 바퀴손잡이에 감아주면 좋음

- 물건을 잡고 놓을 수 있으나 쥐는 힘이 약하므로 약한 부분만을 보조하는 보조기를 선택하여 사용하기도 함
 - 대개 휠체어를 이용하여 독립적으로 활동할 수 있지만, 외부에서의 보행은 거의 불가능함
 - 집에서 하는 직업은 가능할 수 있음
 - 대부분의 사지마비 환자는 제6경추 또는 제7경추 손상이 많은데, 이는 형태학 및 해부학적으로 제6 및 제7경추 사이에서 운동이 가장 많이 일어나기 때문에 탈구(Dislocation)의 기회가 많기 때문이라고 함
- 제1흉추(T1)
- 상지는 정상이고 흉곽을 고정할 수 있는 힘은 있으나 앉은 자세로 균형을 잡을 수 있는 구간근육과 횡경막 호흡을 위한 복부 근육과 늑간근의 작용이 없음
 - 그러나 휠체어 생활은 완전히 독립할 수 있고, 옷 입고 벗기, 식사, 용변 동작 등 자기관리활동은 훈련으로 스스로 행할 수 있음
 - 도와주는 사람이 필요하며 앉아서 하는 직장이라면 종사할 수 있음
- 제6흉추
- 일상생활동작은 완전히 독립적으로 할 수 있음
 - 손의 힘이 완전하므로 휠체어뿐 아니라 개조된 장애인용 차량의 운전도 가능함
 - 이런 환자에게 기능적으로 서게 하기 위해서 보조기를 착용시키면서는 연습이 가능하지만, 보행 때 에너지 소모가 너무 많으므로 기능적인 보행을 기대할 수는 없음
 - 역시 때때로 도와주는 사람이 필요함
- 제12흉추
- 호흡 운동이 완전하며, 복부와 등을 수직으로 유지할 수 있으므로 일상생활 동작은 완전히 독립적으로 할 수 있음
 - 보행은 에너지 소모가 높은 편이지만, 기능적 보행을 위해서 보조기를 공급함
 - 보조기를 착용하면 기능적인 보행도 가능하며 전적으로 도와주는 사람은 필요치 않음
 - 직업은 앉아서 하는 것을 택하는 것이 좋으며 집에서는 주로 휠체어를 사용하는 것이 편할 것
- 제4요추
- 보조기 없이 서고 보행할 수 있음
 - 그러나 발목과 둔부 근육(Gluteal muscle) 작용이 약하므로, 오리걸음(Waddling gait)이 나타나기도 함
 - AFO(Ankle Foot Orthoses)를 착용하고 목발 보행을 하는 것이 좋은데, 만일 그렇지 않으면 비정상적인 보행동작으로 인한 요추부의 과도한 전만증(Lordosis)과 전반슬(Genu Recuratum)의 변형이 올 수 있기 때문임
 - 모든 일을 독립적으로 할 수 있으나 층계를 오를 때 곤란함을 느낄 수도 있음

- 결과적으로, 척수손상은 운동신경 및 감각신경의 마비, 대소변 기능의 장애, 호흡기능의 장애, 성기능의 장애 등 다양한 신체적 장애를 발생시키며, 자기개념(Self-Concept)의 혼란, 분노와 수치감, 강요된 무기력감, 죄책감, 불안, 우울과 같은 부적응적인 정서를 유발할 수 있음
- 따라서 척수손상은 신체기능을 상실했다는 의미를 넘어서 심리적 평형과 생존(Psychological Equilibrium & Survival)까지 위협할 수 있는 삶의 위기상황(Crisis Situation)이라고 할 수 있음

■ 분류 및 증상

- 발생기전에 따른 분류

- 굴곡손상(Flexion injury)
 - ☞ 자동차의 정면충돌이나 추락 사고에서 흔히 발생
 - ☞ 대개 상부 경추부의 전방전위와 하부 경추의 압박골절을 동반함으로써 탈구 및 골절편에 의하여 척수의 심각한 손상을 유발하는 경우가 많음
- 전손상(Extension injury)
 - ☞ 자동차의 충돌이나 넘어지는 사고 후에 발생
 - ☞ 특히 50 대 이후 퇴행성 척추증을 동반한 척추관 협착증이 있는 환자에게서 심한 척수손상 야기
- 회전손상(Rotation injury)
 - ☞ 충돌, 추락 사고에서 굴곡, 신전손상과 같이 발생
- 압박손상(Compression Injury)
 - ☞ 수직으로 작용하는 힘에 의해 추체의 종관부터 골절 발생 심한 경우 추체의 방출성 골절에 의해 척수 손상 발생

- 1차손상과 2차손상

- 1차 손상 : 척추 운동 분절의 급격한 탈골과 골절편의 전위로 신경이 압박되어 받는 손상
- 2차 손상 : 1차 손상 후 생화학적인 기전에 의해 손상이 진행되는 것

- 완전손상과 불완전손상

- 완전손상
 - ☞ 손상 부위 이하의 운동 및 감각 기능이 완전히 소실된 상태 회복 가능성 거의 없음
- 불완전손상
 - ☞ 손상 부위 이하에서 운동 또는 감각 기능이 약간이라도 남아있는 상태
 - ☞ 적절한 치료로 상당히 호전될 수 있는 가능성

- 혈관성 척수질환

- 혈관에 이상이 생겨 나타나는 질환
 - ☞ 척수경색증, 척수출혈, 척수혈관기형, 섬유연골색전증, 감압병

- 기타 척수질환

- 척수쇼크 (Spinal Shock)

- ☞ 손상부위 이하의 모든 척수 기능(운동, 감각, 반사 및 자율신경 기능)이 일시적으로 소실되는 현상

- ☞ 2~3주간 지속 그 후에 회복되거나 강직성 마비로 변함

- 척수구멍증(Syringomyelia)

- ☞ 척수에 Central Canal이 생기는 질환

- ☞ 대부분 후뇌의 기형 동반

2) 뇌 손상 후 심리적 적응 과정

■ 쇼크기

- 손상을 입는 순간부터 수시간 또는 수일까지

- 사고의 진행이 분화 되고, 고립감과 정신적 혼란 등으로 인한 스트레스와 불안이 생기고, 심리적으로 혼란스럽고 겁을 먹게 됨

- 가족과 치료진들의 정서적 지지 중요

■ 부분 이정기

- 수일~ 수주일

- 정신이 깨끗하게 돌아오지 않았고, 몸이 망가진 것을 알고는 하지만 그에 대한 감정에 대해서는 느끼려고 하지 않음

- 자기 신체 상태를 정확히 안다는 것과 싸우는 상태

■ 조안성기

- 손상을 입었다는 사실을 어렵듯이 알면서 표면적으로 받아들이는 시기

- 수개월~ 수년

- 환자가 회복된 것 같고 협조적이며 기가 되살아 난 것 같지만, 진정한 심리적 적응 아님

■ 퇴행기

- 환자가 어린아이 같은 심리상황으로 퇴행하는 시기

- 주위로부터 재활치료를 받으라는 압력을 받는 순간부터 시작

- 자신의 처지와 상황을 새삼스럽게 깨닫게 됨으로 인해 불안감, 절망감이 되살아나 자기를 불쌍히 여기고, 이기적인 요구 ⇒ 불안과 절망을 표시

- 수개월 지속

- 의료진은 환자의 고민, 우울, 슬픔을 인정, 지지와 격려함으로써 환자 스스로 자신상태를 파악할 수 있도록 지원

■ 부정기

- 손상초기에 있다가 사라진 불안 현상이 재현되는 시기

- 퇴행현상이 한층 더 병적인 돌출 현상으로 변하는 것

- 지나치면 편집증 증상, 그냥 두면 평생 지속

■ 우울기

- 퇴행에서 편집적으로 되지 않는 환자가 다음에 겪는 가벼운 우울증
- 심해지면 신체화된 우울이 오게 됨

■ 사회적 회복기

- 자신의 장애를 받아들이는 시기
- 수개월에서 수년에 걸쳐 서서히 다가옴
- 자기 내부에 집중된 에너지가 외부세계와 다른 인간과의 유대관계를 맺는 세계로 이전, 독립적으로 활동 개시, 신체를 통제하고 극복하는데 관심

3) 척수손상에 대한 사회적 편견

■ 우리 사회에서 장애를 가진 사람들은 평가 절하 ⇒ 차별대우

■ 평가절하와 편견 때문에 일반인들은 장애인들과의 접촉을 꺼림 ⇒ 척수손상 이후 사회적 고립

■ 편견과 차별대우로 인한 장애인의 사기 저하

2. 척수손상에 대한 재활의 자세와 가족부담

1) 의료전문가의 재활에 대한 자세

- 부상당한 사람의 인지기능, 정서, 행동에 영향을 줄 수 있는 최근의 다양한 요인들에 대해 심사숙고해야 함
- 부정, 분노, 우울증, 또는 척수손상에 대한 다른 심리적 반응이라고 속단하기 전에 행동을 설명할 수 있는 다른 가능성 등을 고려해야 함(물리적, 사회적 환경)
- 환자의 척수 손상을 지나치게 비극적인 것으로 보지 말 것

2) 척수손상환자의 재활의 자세

■ 독립성과 자율성

- 개인의 유효감과 그 생활에 대한 통제감을 유지하여야 함
- 급성기 치료와 재활기간을 통하여 선택할 수 있는 기회를 제공
- 부상이 발생한 날로부터, 그의 상태와 치료 옵션에 대한 정보제공, 목표설정, 활동, 일과 구성, 간호에 대한 의사결정에 발언권 제공
- 독립성 조성을 위해 척수손상 환자를 문제해결에 포함시킴
 - 자력으로 문제 해결 능력을 계발시킴

■ 긍정적 분위기

- 재활 세팅에서 물리적 환경, 직원의 의상, 재활 센터의 분위기, 재활 진행 중인 사람들의 활동수준
 - 밝고 활동적일수록 동기 증진, 문제 < 환자가 할 수 있는 점

■ 스태프와 상호작용

- 동등하게 존중 ⇒ 긍정적인 자아상의 개발 촉진
- 적절한 전문가적 관계 유지
 - 관계의 명확성, 상호간의 경계 이해, 한계에 대한 이해

■ 사회적 지지

- 상실에 따른 대처
- 회복에 대한 개인의 능력 강화
- 감정이입으로 경청
- 감정의 명확화 지원

■ 희망

- 희망은 환자의 생활에 대한 통제감을 되찾도록 해줌
- 그러므로 의료전문가는 현실성 있는 대답을 해주되, 환자의 희망을 깨뜨리지는 않음

■ 교육적 모델

- 의료전문가가 마련한 교육프로그램에 적극적으로 참여

3) 척수손상환자 가족의 부담

■ 가족이 환자를 돌보면서 안게 되는 전반적으로 고통스럽고 어려운 부정적 문제

■ 복합적이고 부정적인 반응

■ 정서적인 어려움으로 다양한 정서적 문제의 복합적 내재

■ 가족부담감 변인

- 부담감으로 인해 안녕감의 문제, 삶의 질, 생의 만족 정도에 영향을 미침
 - 환자의 특성과 관계된 변인
 - ☞ 환자의 질병상태
 - 가족의 특성과 관련된 변인
 - ☞ 가족의 성별, 연령, 경제수준, 교육 정도, 환자와의 관계 등과 그 이외의 가족의 현재 건강상태, 환자에 대하여 가지고 있는 생각이나 태도
 - 황적인 관계변인
 - ☞ 환자와 가족과의 관계의 질, 다른 가족들에게 두는 중요성이나 가치, 이미 가지고 있는 사회적인 지지 정도

■ 척수손상환자와 가족의 사회적 지지

- 속성차원의 유형-정서적인 지지
 - 느낌, 믿음의 행위(존경, 관심, 애정, 경청, 신뢰, 사랑, 격려)
- 정보적인 지지
 - 의뢰 및 알선, 이해나 문제 대처 등의 사건 해결과 관련
 - 평가 및 도구적인 지지

- 지지의 근원
 - 공적인 지지 : 의료인과 같은 전문가에 의한 것
 - 사적인 지지 : 동료, 타 가족들, 일반인들에 의한 것
- 지지의 단위
 - 개별적 지지
 - ☞ 개인 대 개인
 - 그룹지지 및 지역사회 단위의 지지
 - 이중 지지 그룹의 지지
 - ☞ 대부분 구성원이 서로 유사한 처지에 있는 대상으로 구성된 것
 - ☞ 고민을 함께 나눌 안정성, 신뢰감을 갖게 되므로 자기 노출의 장이 됨